

ہیلتھ سیریز

اپنی دولت بیماری پر نہیں صحت پر خرچ کریں

Cholesterol

کولیسٹرول



ڈاکٹر محمد ادریس



کتاب خانہ طبیب | Facebook

GARLIC

GINGER

سکین پوائنٹ

شیخ محمد بشیر اینڈ سنز

ناشران و تاجران کتب

انتساب

پیارے والدین کے نام
جن کی محنت، شفقت اور دعاؤں
سے میں اس قابل ہوا کہ خلقِ خدا کی خدمت کر سکوں

پروفیسر ڈاکٹر محمد ادریس شاہد

فہرست

عنوانات

صفحہ نمبر

1	تھیراپیوٹکس علاج
2	کولیسٹرول کیا ہے؟
2	کولیسٹرول کے ذرائع
3	کولیسٹرول کا جزو بدن بننا
6	نارمل اور ہائی بلڈ کولیسٹرول
14	کولیسٹرول
18	کولیسٹرول کی مقدار معلوم کرنا
26	ہائی بلڈ کولیسٹرول کی وجوہات
27	وراثتی خطرہ کا عنصر
34	طرز زندگی، طور طریقے
39	تمباکو نوشی کے نقصانات
43	موٹاپا
44	ایسی بیماریاں جو کولیسٹرول لیول میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں
49	ایسی ادویات جو کولیسٹرول لیول کو بڑھاتی ہیں
52	دل کا دورہ
53	ایتھروسیکلکس وکس
55	ایتھروسیکلکس وکس پر بحث
55	دل کی شریانوں میں خون کے لتھڑے کا بننا
60	سینے میں اٹھنے والی ہر دو ہارٹ اٹیک والی نہیں ہوتی
61	ٹوٹل کولیسٹرول کا چارٹ
65	کیا عورتوں کو دل کے عوارضات کا خطرہ کم ہوتا ہے؟
67	آپ بلڈ کولیسٹرول کو کم کیسے کر سکتے ہیں؟
77	کون کون سی چیزوں سے پرہیز کیا جائے؟

- 79 مچھلی کھائیں اور بلڈ کو لیسٹرول نارمل رکھیں
- 82 لہسن میں پائے جانے والے مفید اجزاء کی کہانی
- 85 ریشہ دار غذاؤں کے فوائد
- 93 اپنا وزن کم کیجئے
- 95 وزن کم کرنے کے 20 طریقے
- 98 ورزش کی عادت
- 105 ذہنی دباؤ سے چھٹکارا حاصل کریں
- 108 وٹامنز اور اینٹی اوکسی ڈینٹ کا کردار
- 110 دل کے امراض سے چھٹکارا ممکن ہے
- 112 کیا دوسرے ہارٹ اٹیک سے بچا جاسکتا ہے؟
- 115 بعد از آپریشن ہدایات
- 116 اپنے مستقبل کو صحت مند رکھئے
- 121 سٹریس یا ذہنی دباؤ کا علاج
- 122 چائے اور کافی کے بد اثرات کو زائل کرنے کے لئے
- 123 سگریٹ نوشی کے اثرات بد کو دور کرنے اور سگریٹ نوشی ترک کروانے کیلئے
- 123 الکوحل کے بد اثرات کو روکنے اور اس عادت کے چھٹکارا کے لئے
- 124 موٹاپا
- 126 شوگر
- 127 ہائی بلڈ پریشر
- 128 ایچرو سینکروس
- 130 نوٹل ہائی بلڈ کو لیسٹرول کا ہومیو پیتھک علاج
- 131 کیس نمبر 1
- 131 کیس نمبر 2
- 132 کیس نمبر 3

133	کیس نمبر 4
134	کیس نمبر 5
135	کیس نمبر 6
136	کیس نمبر 7
137	کیس نمبر 8
138	کیس نمبر 9
139	کیس نمبر 10
141	ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ گولیسٹرول اور ایٹھروسیکلر وائس
141	ہائی بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ گولیسٹرول اور ذہنی دباؤ کا طبی طریقہ علاج
142	ذہنی دباؤ یا سٹریس
142	بالچھڑ
142	سناکی
142	حنا
142	روغن مغز کدو 2 روغن کا ہو
142	چھوٹی چندن یا اسرول
143	صندل سفید
143	قالہ
143	کشیئر
143	جو کھار
143	کشمش
143	فلفل سیاہ (کالی مرچ)
144	اسبنول
144	اندرائن
144	عنا ب
144	ایلو



کولیسٹرول کیا ہے؟

کولیسٹرول ایک ملائم اور نرم مٹیریل ہے جو بہت سی غذائی چیزوں مثلاً دودھ، پنیر، انڈے، مکھن، گھی، مچھلی، گوشت خاص کر بیل کے گوشت، اور بکرے کے گوشت میں وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔

قدرتی طور پر یہ ایک چربیلا مادہ ہے جس کی کیمیائی ترکیب کافی پیچیدہ ہے۔ یہ مادہ نسیجوں اور ہارمون کی تعمیر میں مستعمل ہوتا ہے۔

کولیسٹرول کی ایک مناسب مقدار انسانی جسم میں بہت اہم ہوا کرتی ہے کیونکہ اسی مادہ سے انسانی جسم کے خلیات کے مختلف عوامل سرانجام پاتے ہیں۔ مثلاً انسانی جسم میں جنسی ہارمون کی پیدائش اور وٹامن ڈی کے مینابولزم کے لئے کولیسٹرول کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔

چھوٹے بچوں میں دماغی خلیات کی بڑھوتری بھی کولیسٹرول کی مرہون منت ہے۔ اسی طرح بہت سے انسانی جسم کے خلیات کی جھلیوں کو صحت مندانہ کام سرانجام دینے کے لئے کولیسٹرول کی کم از کم مقدار کی ضرورت ہوتی ہے۔

کولیسٹرول کے ذرائع

خون میں کولیسٹرول دو بڑے ذرائع سے آتا ہے۔

(I) بیرونی ذرائع (II) اندرونی ذرائع

(I) بیرونی ذرائع: روزانہ کی خوراک سے۔

ایک عام سبزی خوردہ روزانہ 400-200 ملی گرام کولیسٹرول صرف کرتا ہے۔ جب کہ ایسے افراد جو سبزی خوردہ نہیں جوتے، وہ عام طور پر 600-400 ملی گرام کولیسٹرول روزانہ کھاتے ہیں اور یہ کولیسٹرول کھائی گئی خوراک سے حاصل کرتے ہیں۔

(II) اندرونی ذرائع: خون میں کولیسٹرول کی بڑی مقدار جگر میں تیار ہونے والے کولیسٹرول کی ہوتی ہے۔ اس طرح چند ہفتوں تک اگر خوراک میں کم کولیسٹرول لیا جائے۔ تو جگر اس کی جگہ بھی زائد

کولیسٹرول پیدا کرتا رہتا ہے۔

کولیسٹرول کا جزو بدن بننا

کولیسٹرول کا میٹابولزم: کولیسٹرول کا میٹابولزم خامروں Enzymes اور کئی پیچیدہ راستوں کے عمل سے گزر کر انجام پاتا ہے۔

خوراک سے حاصل ہونے والا کولیسٹرول بذات خود پانی اور خون میں تحلیل نہ ہو سکنے والا ہوتا ہے۔

جس طرح دوسرے غذا کے اجزاء انتڑیوں میں جذب ہونے کے بعد خون میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح غذائی چربی اور کولیسٹرول جب اسی طریقہ سے خون میں شامل ہوتے ہیں تو پھر مزید جزو بدن بننے کے لئے جگر کی طرف چلے جاتے ہیں اور جگر میں کولیسٹرول پانی میں حل پذیر اجزاء کے ساتھ مل جاتا ہے۔ جسے Apolipoproteins اور Phospholipids کہتے ہیں جو Chylomicrons کا نیلو مائیکرون کی شکل میں ہوتے ہیں اور کالونیو مائیکرون ایک پیچیدہ اجزاء کی صورت میں پائے جاتے ہیں جن کو Lipoproteins کہتے ہیں۔ ان پروٹین کے ساتھ چربی ملی ہوئی ہوتی ہے۔

لائی پوپروٹین کی اقسام (Types of Lipoproteins)

ان کی تین اقسام ہیں اور یہ تینوں دل کی بیماریاں پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان تینوں کو ایک دوسری سے الگ شناخت کے لئے خون کو سینٹری فوگ کے عمل سے گزرا جاتا ہے۔ اور یہ تینوں اقسام کی پروٹین خون کی گردش سے جسم کے مختلف حصوں میں جگر کی جانب سے کولیسٹرول لاتی ہیں۔

جب خون کو سینٹری فوگ کے عمل سے گزرا جاتا ہے تو بہت زیادہ کثیف اجزاء نیچے تہہ نشین ہو جاتے ہیں اور کم کثافت والے اوپر آ جاتے ہیں۔

بہت کم کثیف لائی پوپروٹین (Very Low Density Lipoproteins VLDL)

کثیرالچربی اجزاء کو کالونیو مائیکرون، نرائی گلیسرائیڈز اور فیٹی ایسڈ شکل میں VLDL بھی کہتے ہیں۔

ان اجزاء کا یہ نام بہت کم کثافت اور وزن کے باعث تجویز کیا گیا ہے۔

VLDL میں سے کچھ بطور انرجی استعمال ہوتے ہیں اور دوسرے چربی کے ذخیرہ میں جمع

ہو جاتے ہیں۔

اور ایک بڑی مقدار جگر میں خارج ہونے کے لئے واپس آ جاتی ہے۔

VLDL پھر انٹرمیڈیٹ ڈینسٹی لائی پوپروٹین جس کو اختصاراً IDL اور لوڈینسٹی لائیپو

پروٹین جسے LDL کہتے ہیں، تبدیل ہو جاتا ہے۔

کم کثیف لائی پوپروٹین (Low Density Lipoproteins)

VLDL سے ثرائی گلیسرائیڈز کے اخراج کے بعد LDL پیدا ہوتا ہے۔ اور خون میں سب

سے زیادہ کولیسٹرول سے بھرپور لائیپو پروٹین ہوتا ہے۔

LDL کا کافی حصہ چربی کے ذخیرہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے اور بقیہ ماندہ واپس جگر کو

اخراج کے لئے بھیج دیا جاتا ہے۔

LDL کا خون میں بہت زیادہ اجتماع یقیناً نقصان دہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ شریانوں

کی دیواروں میں تہہ نشین ہوتا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ شریانوں کو تنگ کر دیتا ہے۔

LDL کا 130 ملی گرام فی سو ملی لیٹر خون میں اجتماع اچھا خیال نہیں کیا جاتا اور اس سے

زائد مقدار میں اس کی موجودگی دل کے دورے کا باعث بن سکتی ہے۔

ہائی ڈینسٹی لائی پوپروٹین (High Density Lipoprotein - HDL)

HDL کو ایک اچھا کولیسٹرول خیال کیا جاتا ہے یہ جگر اور چھوٹی آنتوں کی دیواروں سے

تراوش پاتا ہے۔ جب کہ خون کے دھاریں میں پختہ ہوتا ہے۔

اور یہ ارد گرد کی بافتوں کے کولیسٹرول کو حاصل کرتا ہے۔ دوران خون پھر HDL کو واپس

جگر میں منتقل کر دیتا ہے۔ اور یہاں سے کولیسٹرول بائیل میں خارج ہوتا ہے۔

اور اس طرح HDL جسم کو زیادہ مقدار کولیسٹرول سے نجات دلاتا ہے۔

عورتوں میں عام طور پر HDL زیادہ مقدار تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتوں

میں ہارٹ ایٹیک یعنی دل کے دورے مردوں کی نسبت بہت کم ہوتے ہیں۔

اور ہارٹ ایٹیک کی کمی موقوفی حیض کی مدت تک برقرار رہتی ہے۔

ایسے بالغ افراد جن کا HDL 35 ملی گرام سے کم ہو، انہیں ہارٹ ایک کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں۔

ایسے افراد جن کا HDL کا درجہ 25 گرام سے کم ہو، انہیں بھی ہارٹ ایک کا خدشہ رہتا ہے، اگرچہ ان کا کولیسٹرول 200 ملی گرام سے بھی کم ہو۔

ٹرائی گلیسرائیڈز (Triglycerides)

یہ جگر سے پیدا ہونے والی ایک چربی کی قسم ہے۔ یہ تین فیٹی ایسڈز سے مرکب ہوتی ہے۔ اگرچہ زیادہ کولیسٹرول اور LDL شریانوں کی تنگی اور رکاوٹ کا سبب مانا جاتا ہے۔ معالجین ٹرائی گلیسرائیڈز کے کردار کے متعلق کم جانتے ہیں۔ جدید تحقیق سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں ٹرائی گلیسرائیڈز کا بڑھ چانا دل کی شریانوں کی بیماریوں کی وجوہات میں سے ایک ہے۔ ایسے افراد جو ذیابیطس، زیادہ وزن یا گردوں کے امراض میں مبتلا ہوں، ان میں ٹرائی گلیسرائیڈز نارمل سے بہت زیادہ بڑھا ہوا ہوتا ہے۔

ایک صحت مند بالغ آدمی میں ٹرائی گلیسرائیڈز عام طور پر 100 سے 200 ملی گرام تک کے درجہ پر ہوتا ہے۔

اگر کسی بھی فرد کے دیگر تمام تشخیصی نتائج تسلی بخش ہوں لیکن اس کا ٹرائی گلیسرائیڈز 300 ملی گرام تک پہنچ چکا ہو تو اسی اکیلے کی مقدار میں اضافہ کو دل کی شریانوں کے لئے خطرناک نہیں سمجھا جاتا۔ اگر ٹرائی گلیسرائیڈز کی ریڈنگ 300 ملی گرام سے بھی بڑھ جائے تو اس کے لئے علاج کی ضرورت پیش آتی ہے، جو ادویات غذا، یا دونوں چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ کئی دیگر غیر صحت مند عوامل کے باعث بھی اکثر اوقات اس کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

کولیسٹرول کا معیاری درجہ (Desirable Cholesterol Levels)

کولیسٹرول تین اقسام کے لائیپوپروٹینز کا مجموعہ ہوتا ہے جو درج ذیل ہیں۔

(1) V.L.D.L. یعنی بہت کم کثیف لائیپوپروٹین (Very low density lipoprotein)

(2) L.D.L. یعنی کم کثیف لائیپوپروٹین (Low density lipoprotein)

(3) H.D.L. یعنی زیادہ کثیف لائیپوپروٹین (High density lipoprotein)

نارمل اور ہائی بلڈ کولیسٹرول (بالغ افراد میں بلڈ کولیسٹرول)

ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول لیولز

نارمل	200 ملی گرام سے کم
نارمل سے زیادہ زیادتی کو چھوٹا ہوا	200 سے 239 ملی گرام
بڑھا ہوا بلڈ کولیسٹرول مانا جاتا ہے	240 یا اس سے زیادہ

یہ پیش کردہ چارٹ امریکہ کے نیشنل کولیسٹرول ایجوکیشن پروگرام NCEP کا شائع کردہ

ہے۔

حال ہی میں دنیا کے مختلف ممالک میں کی گئی مختلف تحقیقات اسی چارٹ کے قریب تر ہیں۔ ان میں تھوڑی بہت کمی بیشی ہے۔

ٹوٹل کولیسٹرول کے علاوہ تین اور تحقیقی نتائج L.D.L، H.D.L اور ٹرائی گلیسرائیڈز بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔

ان خون کے معائنوں سے خون میں چربی کی مقدار کے بارے پتہ چلتا ہے۔ اور ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول کے ٹیسٹ کے ساتھ ان تینوں ٹیسٹوں کا کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔

ایچ ڈی ایل موزوں کولیسٹرول (HDL The Good Cholesterol)
ایچ ڈی ایل کو ایک اچھی قسم کا کولیسٹرول مانا جاتا ہے کیونکہ یہ جسم سے زائد کولیسٹرول کو جگر کے ذریعہ ختم کرتا ہے۔ ایسے افراد جن میں HDL لیول بڑھا ہوا ہو اور 45 ملی گرام سے زائد ہو، انہیں ہارٹ اٹیک کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے۔

جب کہ HDL نارمل لیول مردوں میں 36 سے 45 ملی گرام اور عورتوں میں 40 سے 60 ملی گرام ہوتا ہے۔

عورتوں میں عام طور پر HDL بڑھا ہوا ہونے کے باعث انہیں مردوں کی نسبت ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوا کرتا ہے اور یہ فائدہ عورتوں کو موقوتی حیض تک حاصل رہتا ہے۔

مردوں اور عورتوں میں HDL لیوز کا دل کی شریانوں یا وریدوں کی بیماریوں میں کردار

HDL لیوز یا مقدار	دل کی بیماریوں کی شرح فی صد
مرد	عورت
25 ملی گرام سے کم	18
25 ملی گرام سے کم	25 ملی گرام لیول کی صرف چار عورتوں میں دل کی شریانوں کی بیماریاں نہ پائی گئیں۔
25 ملی گرام سے 34 ملی گرام	10
35 ملی گرام سے 44 ملی گرام	10
45 ملی گرام سے 54 ملی گرام	05
55 ملی گرام سے 64 ملی گرام	06
65 ملی گرام سے 74 ملی گرام	03
75 ملی گرام اور اس سے زائد	0

ڈاکٹر ملر اور اس کے ساتھیوں نے پوچھا۔ ایس۔ اے میں ایک ہزار ایسے مریضوں پر تحقیق کی جو کورونری اسٹیجیو گرافی تشخیص کے ذریعہ CHD یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز میں 67 فی صد مرد اور 80 فی صد عورتیں مریض قرار دیئے گئے تھے۔

ان میں سے 288 مریض ایسے تھے جن کا کولیسٹرول لیول بالکل نارمل تھا۔

اور ان مریضوں میں مردوں کا HDL کولیسٹرول 35 ملی گرام سے کم اور عورتوں میں 40 ملی گرام سے کم تھا۔ ان تمام مردوں اور عورتوں میں ٹوٹن ہلڈ کولیسٹرول نارمل حالت میں تھا۔ ان تمام حقائق کی بناء پر معالجین یہ کہتے ہیں کہ HDL کولیسٹرول کا کم ہونا دل کی شریانوں کی بیماریوں کی راہ ہموار کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔

اگر آپ کی عمر 45 سال سے زائد ہے اور آپ کی فیملی ہسٹری میں CHD یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز موجود ہے اور آپ سگریٹ نوشی بھی کرتے ہیں۔ ہلڈ پریشر بڑھا ہوا اور ذیابیطس موجود ہے۔ وزن میں کافی زیادتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ایسے گروپ میں شمار کریں کہ جنہیں ہارٹ ایک کا

زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔

ایل ڈی ایل۔ غیر موزوں کولیسٹرول (LDL-Bad Cholesterol)

کولیسٹرول کی یہ قسم جگر میں VLDL سے ترکیب پاتی ہے۔

امریکہ کے نیشنل کولیسٹرول ایجوکیشن پروگرام کے مطابق LDL لیول 130 ملی گرام سے

زیادہ نہیں ہونا چاہئے۔

اگر آپ کا LDL لیول 130 ملی گرام سے 159 ملی گرام تک ہے تو کہا جاسکتا ہے کہ آپ پر

خطر حدود میں داخل ہو رہے ہیں اور اگر LDL لیول 160 ملی گرام سے زیادہ ہے تو آپ ان حدود کو عبور

کر کے بہت زیادہ حد تک ہارٹ ایکٹ کا خطرہ مول لے چکے ہیں۔ بیس سال سے اوپر کے تمام بالغ

افراد کو اپنے ٹوٹل کولیسٹرول لیولز کا مکمل ٹیسٹ ضرور کروالینا چاہیے۔

ٹوٹل کولیسٹرول کے ٹیسٹ کروانے کے لئے بہتر ہوتا ہے کہ مریض بارہ گھنٹے پہلے فاقہ سے

ہو۔

عام طور پر بلڈ کولیسٹرول کا چیک اپ کیا جاتا ہے لیکن اس بات کا اندازہ لگانے کے لئے کہ

آیا کسی فرد کو خون کی شریانوں میں کسی قسم کی رکاوٹ کے باعث ہارٹ ایکٹ کا خطرہ ہو سکتا ہے تو

کولیسٹرول کا ٹوٹل لیولز ٹیسٹ یعنی HDL، LDL اور ٹرائی گلیسرائیڈز بھی ٹیسٹوں سے استفادہ کیا جاتا

ہے۔

اس سلسلہ میں 2 سے 4 ہفتوں کے وقفہ کے بعد تین مرتبہ یہ ٹیسٹ کروانے کے بعد ان

نتیجوں ٹیسٹوں کی اوسط نکال کر مکمل تشخیص کی جاتی ہے۔

کسی بھی فرد میں HDL اور کولیسٹرول کے درمیان تناسب نکال کر اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ

اسے کس حد پر ہارٹ ایکٹ کا خطرہ لاحق ہے۔

پچھلے صفحوں میں اس سلسلہ میں ایک چارٹ دیا گیا ہے لیکن ذیل میں درج ذیل مثالوں

سے تناسبی عمل کو واضح کریں گے۔

مثال نمبر 1

فرض کریں آپ کا کولیسٹرول 200 ملی گرام ہے اور آپ کا HDL 40 ملی گرام تو آپ کا

تناسب یہ ہوگا۔

$$\frac{\text{Total Cholestetol}}{\text{HDL Cholesterol}}$$

$$\frac{5}{-} = \frac{200}{40} = \frac{\text{ٹوٹل کولیسٹرول}}{\text{ایچ۔ ڈی۔ ایل کولیسٹرول}}$$

مثال نمبر 2

عبدالمتین ٹوٹل کولیسٹرول 200 ملی گرام اور HDL 50 ملی گرام تناسب معلوم کریں۔

حل:

$$\frac{4}{-} = \frac{200}{50} = \frac{\text{ٹوٹل کولیسٹرول}}{\text{ایچ۔ ڈی۔ ایل کولیسٹرول}}$$

مثال نمبر 3

عبداللہ صاحب ٹوٹل کولیسٹرول 240 ملی گرام اور HDL کولیسٹرول 40 ملی گرام تناسب

کیا ہوگا؟

$$\frac{6}{-} = \frac{240}{40} = \frac{\text{ٹوٹل کولیسٹرول}}{\text{ایچ۔ ڈی۔ ایل کولیسٹرول}}$$

ایسا فرد جس کا تناسب 4.5 یا اس سے کم ہو اسے ہارٹ اٹیک کا بہت ہی کم خطرہ ہوتا ہے۔ جس قدر یہ تناسب بڑھتا جائے گا، اسی قدر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھتا جائے گا۔ اوپر بیان کردہ مثالوں سے ایک بات جو صاف طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے آپ کا تناسب اسی صورت میں کم ہو سکتا ہے کہ اگر HDL کولیسٹرول زیادہ اور یا ٹوٹل کولیسٹرول کم ہو۔

ایک ایسا فرد جس کا ٹوٹل کولیسٹرول اور HDL کولیسٹرول تناسب 4 ہو۔ ایسے فرد کی نسبت جس کا یہ تناسب 5 ہو ہارٹ اٹیک سے زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔

اسی طرح ایک ایسا فرد جس کا ٹوٹل کولیسٹرول 200 ملی گرام ہو جو نہایت موزوں ہے لیکن اس کا HDL کولیسٹرول 30 ملی گرام یا اس سے کم ہو تو اس کا تناسب 6 سے زیادہ بنتا ہے اور ایسے بالغ افراد جن کا تناسب 6 درجہ تک ہو انہیں دل کی بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔

ان تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے کولیسٹرول کے ماہرین اس بات پر پختہ یقین

رکھتے ہیں کہ اگر فیملی میں ہارٹ ڈیزیز کی ہسٹری پائی جاتی ہو اور سگریٹ نوشی، ذیابیطس، ورزش کا فقدان، موٹاپا، ذیپریشن وغیرہ کا شکار ہوں تو HDL کولیسٹرول ضرور چیک کروانا چاہیے، اگرچہ کولیسٹرول لیول نارمل ہی کیوں نہ ہو اور ایسے افراد جن کا کولیسٹرول لیول 200 ملی گرام سے زیادہ ہو انہیں تو HDL کولیسٹرول LDL اور ٹرائی گلیسیرائیڈ کا مکمل ٹیسٹ کروانا چاہیے۔

تحقیقات سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ ستر فی صد سے زیادہ ہارٹ اٹیک کے مریضوں میں ٹوٹل کولیسٹرول اور HDL کولیسٹرول تناسب 5 سے زیادہ ہوتا ہے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ خرگوش اور کتا دوا ایسے جانور ہیں جن کو تقریباً دل کی امراض لاحق نہیں ہوا کرتیں کیونکہ ان کا ٹوٹل کولیسٹرول اور HDL کولیسٹرول تناسب 1.5 کے قریب ہوتا ہے۔

انسانوں میں ایک نئے پیدا ہونے والے بچے میں یہ تناسب 2 تک ہوتا ہے اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے یہ تناسب بڑھتا رہتا ہے۔

سی ایچ ڈی یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز۔ دل کی شریانوں یا

وریدوں کی بیماریوں پر مختلف ممالک میں ہونے والی تحقیقات

دل کے امراض جو اکثر موت کا باعث ہوتے ہیں اور دنیا بھر کو اپنی پلینٹ میں لئے ہوئے ہیں، صرف امریکہ میں پچاس بلین ڈالر ہر سال دل کے امراض اور ان سے متاثرہ افراد کے علاج کے لئے مختص کئے جاتے ہیں۔

اگرچہ برس ہا برس کی تحقیقات سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ دل کے امراض میں سب سے نمایاں اور دیگر عوامل سے زیادہ قابل غور حالت دل کی خون کی نالیوں کی بندش ہے جس میں کولیسٹرول کا اہم کردار ہوتا ہے۔

اگر ہم اپنے کولیسٹرول لیول کو نارمل رکھیں تو دل کے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ کولیسٹرول کی اس خطرناک کارکردگی سے آگاہ نہیں ہیں۔

خود کو تندرست و توانا رکھنے کے لئے ہمیں ہائی بلڈ کولیسٹرول، اس کی وجوہات اور علاج کے متعلق مکمل آگاہی ہونا چاہیے۔

تاکہ بلڈ کولیسٹرول کو نارمل سطح پر رکھ کر دل کے امراض سے نبرد آزما ہونے کی نوبت ہی نہ

CHD کورونری ہارٹ ڈیزیز کو تاحال دنیا کے بہت سے ممالک میں موت کا بہت بڑا سبب گردانا جاتا ہے۔

پچھلے تیس سالوں میں امریکہ میں چالیس فی صد شرح اموات کو کم کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی صرف امریکہ میں 1.5 ملین افراد ہر سال ہارٹ ایکٹ کا شکار ہوتے ہیں، جن میں سے پانچ لاکھ لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔

دنیا کے دیگر کئی ترقی یافتہ ممالک مثلاً کینیڈا، انگلینڈ، جرمنی، فرانس، ہالینڈ، یوگوسلاویہ اور روس میں تو اوپر بیان کردہ حالات سے کہیں زیادہ صورت حال خراب ہے۔

ہمارے پڑوس ملک بھارت میں دل کے امراض بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ 24 ملین سے زائد افراد دل کے عوارضات میں مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ 20 ملین افراد ہائی بلڈ پریشر یا ہائپر ٹینشن میں مبتلا ہیں اور ہائپر ٹینشن CHD کے لئے بہت مددگار پیدا ہوتا ہے۔

بھارت دہلی کی شہری آبادی کی 1993 سروے رپورٹ کے مطابق CHD کی شرح 31.9 فی ہزار ہے اور یہ شرح بالغ افراد میں ہے۔ ڈاکٹر اے جی مہتا کے مطابق انڈیا ہی میں CHD چالیس سال کی عمر سے کم بالغوں میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔

دس ہارٹ ایکٹ کے کیسوں میں ایک کیس چالیس سال کی عمر سے کم عمر کے فرد کا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی رپورٹ میں مزید کہا کہ میرے زیر علاج پانچ شریانوں کی Blockages یعنی رکاوٹ والے مریض کی عمر صرف اکیس سال ہے۔

ڈاکٹر Natoobhai کے مطابق جو سینٹر کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ ہیں اور بمبئی ہسپتال میں خدمات سرانجام دیتے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات سنگاپور میں ایشین پیسیفک کانفرنس میں بتائی کہ میں نے اپنی تحقیقات کے دوران جو خاص بات معلوم کی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا میں CHD چالیس سال سے کم عمر والے افراد میں بھی تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بمبئی ہسپتال میں داخل ہونے والے تین مریضوں سے ایک کی عمر چالیس یا چالیس سال سے بھی کم ہوتی ہے۔ اور یہ تناسب مغربی ممالک کے مقابلہ میں بہت ہی زیادہ ہے۔ کورونری ہارٹ ڈیزیز CHD، روکی جا سکنے والی حالت ہے، ہمیں ہارٹ ایکٹ کو زندگی کا ناگزیر حصہ تصور نہیں کرنا چاہیے۔

USA نے پچھلے تیس سالوں میں ہارٹ ڈیزیز کے باعث ہونے والی اموات کو بہت زیادہ حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ لوگوں میں شعور پیدا کرنا ہے کہ وہ ایسے عوامل کا شجیدگی سے

خیال رکھیں جو CHD کے لئے مددگار ہوتے ہیں۔
مثلاً کولیسٹرول کی زیادتی، سگریٹ نوشی، ذہنی دباؤ، کثرت سے نوشی، کام کی زیادتی اور ناقص غذا۔

ہمارے اپنے ملک پاکستان اور دیگر ترقی پذیر ممالک میں لوگوں میں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ بروقت اپنا جسمانی چیک اپ کروا کر اپنی صحت کو برقرار رکھیں اور پیشگی ایسے عوامل کو قابو میں رکھیں جو CHD کے لئے راہ ہموار کرتے ہیں۔

مختلف سوچ کے لوگ ہیں کچھ لوگ میڈیکل چیک اپ وغیرہ سے بالکل ہی گریزاں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مختلف قسم کے میڈیکل ٹیسٹوں کی رپورٹ سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہوتی ہے اور صحت مند نہیں ہو پاتے، اس لئے ٹیسٹوں وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔

میرے ذاتی تجربہ میں ہے کہ جب مریضوں کو کسی بھی مرض میں علاج کے دوران پرہیز بتایا جاتا ہے تو وہ اسی سے گریز کرتے ہیں اور کہتے ہیں۔ دیکھیں جی فلاں آدمی بھی کبھی کچھ کھائی رہا ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، اسے کیا ہوا ہے۔ ڈاکٹر لوگ خواہ مخواہ میں کھانے پینے والی چیزوں کو روک دیتے ہیں۔

حالانکہ ان کے سامنے بہت سے لوگ جب بدقسمتی سے ہارٹ اٹیک کا شکار ہوتے ہیں اور لقمہ اجل بن جاتے ہیں تو ان کے تمام منصوبے دھڑے کے دھڑے رو جاتے ہیں۔
جو فوج جاتے ہیں وہ بقیہ زندگی ورماندگی اور ڈیپریشن سے گزارتے ہیں لیکن وقت سے پہلے ان تمام عوارضات کے تدارک کے لئے بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔

میں اکثر اپنے مریضوں کو کہا کرتا ہوں کہ غریب آدمی غیر متوازن غذا یا غذائی قلت سے مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جب کہ دوسری طرف امراء زیادہ کھا کر اور بد پرہیزوں سے بیماریاں مول لیتے ہیں۔

اس لئے ہمیں اپنے لوگوں میں CHD میں کمی لانے کے لئے کولیسٹرول کے کردار کے بارے آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔

اسی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کتاب پیش کی جا رہی ہے، جس کے مطالعہ سے CHD کی شرح کو کم کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی کیونکہ اس کتاب میں ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول، اس کے فوائد و نقصانات، کنٹرول اور علاج تمام پہلوؤں پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔

اپنے طرز زندگی میں تبدیلی، غذائی پرہیز، ورزش وغیرہ سے انسان خود کو تندرست و توانا رکھ سکتا ہے۔

بلڈ کولیسٹرول میں اضافہ کو قابو میں لانے کے لئے بھی اوپر بیان کردہ ہدایات پر عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل کی جاسکتی ہے۔ لیکن بہت زیادہ بڑھے ہوئے بلڈ کولیسٹرول کی صورت میں ان تمام احتیاطوں کے ساتھ ادویات کی ضرورت بھی پیش آتی ہے جن کو آگے بیان کیا جائے گا۔

کورونری ہارٹ ڈیزیز کے لئے راہ ہموار کرنے والے عوامل، سگریٹ نوشی، ورزش کا فقدان، ہائی بلڈ پریشر یا بائپھرٹینشن اور بلڈ کولیسٹرول ہیں۔

1950ء سے سگریٹ نوشی کو دل کے امراض پیدا کرنے والے عوامل میں شمار کیا جاتا ہے لیکن بلڈ کولیسٹرول کی زیادتی کو حالیہ دور میں کی جانے والی تحقیقات نے زیادہ اجاگر کیا ہے۔

اگرچہ سائنسدان اور معالجین چالیس سال کی عمر سے اوپر والے افراد میں بلڈ کولیسٹرول کے بڑھ جانے کو خطرہ گردانتے تھے۔ لیکن پچھلے دس سالوں میں ہونے والی بہت سی سائنسی تحقیق نے یہ بات بالکل عیاں کر دی ہے کہ ہائی بلڈ کولیسٹرول اور دل کے عوارض کے درمیان گہرا تعلق ہے۔

اور جدید تحقیقات سے یہ بات بھی مانی جانے لگی ہے کہ اگر آپ بلڈ کولیسٹرول لیول 1% فی صد کم کرتے ہیں تو کوہارٹ ڈیزیز کا خطرہ 2 فی صد کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چربی اور کم کولیسٹرول والی غذا کے استعمال سے دل کی شریانوں کی تختی اور تنگی کو نارمل حالت میں لاسکتے ہیں۔

مکمل شفاء یابی کے لئے طرز زندگی میں تبدیلی اور ضرورت کے تحت مناسب ادویاتی استعمال شرط ہوا کرتا ہے۔

امریکہ کے قومی صحت کے ادارہ کے مطابق ایسے افراد جن کا بلڈ کولیسٹرول 265 ملی گرام سے بڑھا ہوا ہو، انہیں ایسے افراد جن کا بلڈ کولیسٹرول 190 ملی گرام یا اس سے بھی کم ہوان کی نسبت CHD کا چار گنا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔

یہ بات بھی مشاہدہ میں آئی ہے کہ بہت کم لوگ جن کا بلڈ کولیسٹرول 160 ملی گرام سے بھی کم تھا، ہارٹ ایک سے دو چار ہوئے۔

لیکن وسیع پیمانہ پر کی جانے والی تحقیقات سے پتہ چلا کہ 240 ملی گرام یا اس زائد بلڈ کولیسٹرول لیول والے افراد میں ہارٹ ایک کی شرح بڑھ رہی ہے۔

اگر بلڈ کولیسٹرول 200 ملی گرام لیول سے بڑھ رہا ہو تو اسے سنجیدگی سے لیں کیونکہ ہائی

بلڈ پریشر کی طرح ہائی بلڈ کولیسترول کو بھی اصطلاحاً Silent Killer کہا جاتا ہے۔ ہائی بلڈ کولیسترول کی شروع میں کوئی خاص علامات نہیں ہوتیں مگر آہستہ آہستہ جیسے جیسے دل کی شریانوں میں تنگی اور سختی آتی جاتی ہے، علامات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔

یعنی تنگی تنفس، چہرہ کانٹنگوں ہو جانا، چلتے وقت یا سیر حیاں چڑھتے وقت سانس کا پھول جانا وغیرہ۔ کیونکہ شریانوں میں تنگی اور سختی کے باعث دل کو ضرورت کے مطابق خون کی مقدار نہیں پہنچتی اور نہ ہی آکسیجن کی مقدار ضرورت کے مطابق پہنچتی ہے۔

اور آہستہ آہستہ یہ کیفیت بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ دل کو آکسیجن اور خون کی سپلائی میں انتہائی کمی یا قفل سے دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔

کولیسترول

دنیا بھر میں ہونے والی بڑی بڑی تحقیقات سے ہائی بلڈ کولیسترول اور دل کی بیماری کے درمیان گہرا ربط بہت ہی نمایاں ہو جاتا ہے۔ ان تحقیقات کو ہم یہاں پیش کریں گے۔

1952 سے فریمنگہم کی تحقیق: Framingham نے 5000 ہزار سے زائد بالغ افراد جن میں مرد اور عورتیں شامل تھیں۔ تیس سال تک تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ کم بلڈ کولیسترول والے افراد دل کے امراض میں بہت کم مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ تحقیق سب سے پہلی بڑی تحقیق تھی۔

کورونری ڈرگ پروجیکٹ:

کورونری ڈرگ پروجیکٹ کی 1974 کی ریسرچ کے مطابق جو تقریباً درمیانہ عمر کے 8000 افراد پر کی گئی۔ یہ ثابت کیا کہ طرز زندگی میں تبدیلی اور ساوہ دوا مثلاً Nicotine Acid سے بہت سے افراد کا بلڈ کولیسترول لیول نارمل سطح تک آکر ہارٹ اٹیک کا خطرہ دور کیا گیا۔

ملٹی پل رسک فیکٹر انٹروینشن ٹرائل (MRFIT)

اس ادارہ نے 1982ء میں 12000 ہزار سے زائد افراد کی چھ سال تک مسلسل عکس کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر بلڈ کولیسترول لیول کو نارمل سطح پر لایا جائے تو دل کے امراض کے باعث واقع ہونے والی اموات کی شرح کم ہو جاتی ہیں۔

لائسٹڈ ریسرچ کلینکل کورونری پرائمری پریوینشن ٹرائل 1984ء

1984ء میں اس ادارہ کے تحت درمیانہ عمر کے تقریباً 3800 افراد جو مرد تھے اور جن کا بلڈ کولیسٹرول لیول بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا۔ ان کا غذا اور ادویات سے علاج کیا گیا، جس سے بلڈ کولیسٹرول لیول کم ہو کر نارمل سطح پر آیا۔ اور نتیجتاً بلڈ کولیسٹرول کو کم کرنے سے 20 فی صد سے زائد ہارٹ ایکٹ کی شرح کو کم کیا گیا۔

ہلسنکی ہارٹ سٹڈی 1987ء (Helsinki Heart Study)

درمیانی عمر کے 4000 مردوں پر 5 سال تک سٹڈی کے بعد میڈیسن کے ذریعہ کولیسٹرول لیول کو کم کر کے ہارٹ ایکٹ کی شرح میں خاطر خواہ کمی لائی گئی۔

کولیسٹرول لوئرنگ ایٹھروسکلیروسس سٹڈی 1987ء

Cholesterol, lowering atherosclerosis study 1987

162 مردوں پر تحقیق کی گئی جو ہارٹ ایکٹ اور بائی پاس آپریشن سے گزر چکے تھے۔ تحقیق کی مدت دو سال تھی، ادویاتی استعمال اور غذائی تبدیلیوں سے کورونری آرٹریز میں تنگی اور خفی کو نمایاں حد تک کم کیا گیا۔ اب تک بیان کی گئی مختلف تحقیقات سے کولیسٹرول اور ہارٹ ایکٹ کے درمیان پایا جانے والا تعلق بالکل عیاں ہو جاتا ہے۔

پھر بھی مزید عرض کرتا چلوں تاکہ قارئین CHD کے ذمہ دار عوامل میں سے بہت بڑے نامی گرامی فیکٹر کے متعلق اچھی طرح سے آگاہی حاصل کر لیں۔

ترقی یافتہ ممالک میں 1980ء میں بہت بڑی بڑی تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں میں بڑھتے ہوئے کولیسٹرول لیول کے بارے آگاہی کے لئے کافی کام شروع ہو گیا تھا۔ اور اب ترقی یافتہ ممالک میں لوگ اس خاموش قاتل سے بخوبی آگاہ ہیں، لیکن ترقی پذیر ممالک میں ابھی لوگوں کو بلڈ کولیسٹرول کے بارے کوئی خاص معلومات نہیں ہیں۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں بھی ابھی تک لوگوں میں بلڈ کولیسٹرول کے نقصانات کے بارے کوئی خاص علم نہیں ہے۔ ہماری روزمرہ کی خوراک میں کولیسٹرول سے بھرپور چیزوں کی شمولیت سے اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

یہاں پر متوازن غذا، ورزش، اور تدارکی عوامل کا فقدان ہے۔ یعنی دیر تک ہم لوگوں میں

ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول جو CHD کا بڑا فیکٹر ہے، کے بارے میں معلومات کو عام سطح تک نہیں پھیلا دیتے، اتنی دیر تک CHD کے باعث ہونے والی اموات بڑھتی چلی جائیں گے۔

ہمارے ملک میں ہیلتھ کلبوں اور صحت مندانہ کھیلوں کی طرف لوگوں کو مائل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔

جب لوگوں میں متوازن غذا، ورزش، سیر اور صحت مندانہ کھیلوں کا رجحان بڑھے گا تو آئو میٹبلیک دل کے عوارض CHD کے دیگر محرکوں میں کمی کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول میں کمی واقع ہوگی۔

جب ہائی بلڈ کولیسٹرول میں کمی واقع ہوگی تو CHD یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز کے خطرات بہت حد تک کم ہوں گے اور ہارٹ ایک کے باعث ہونے والی اموات کی شرح بہت کم ہو جائے گی۔ اس کے لئے بہت بڑی پائینگ کی ضرورت ہے۔ ہم اس کتاب کو انتہائی کم قیمت پر مارکیٹ میں لاکر ایک چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں۔

جس سے عام قارئین کرام بہت حد تک ہائی بلڈ کولیسٹرول (خاموش قاتل) کے بارے میں جان سکیں گے۔

اور معالجین خاص کر ہومیو پیتھک معالجین اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے اور پیارے وطن پاکستان میں ہارٹ ایک کی شرح کو کم کرنے میں انتہائی مفید کردار ادا کر سکیں گے۔

اس لئے اس کتاب میں اپنے تیرہ سالہ طبی پریکٹس کے حوالہ جات نہایت جامع انداز میں پیش کئے گئے ہیں تاکہ ہومیو پیتھک طلباء، معالجین اور بھرپور استفادہ کر سکیں۔

ترقی یافتہ ممالک میں متوازن غذا کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اور اس سلسلہ میں وہاں پر حکومتی سطح پر بہت بڑے بڑے پروگرام شروع کئے گئے ہیں۔

آپ اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے خود ذمہ دار ہیں

حکومت اپنے وسائل کے مطابق اپنے عوام کو صحت کی سہولتیں فراہم کرنے میں کوشاں ہے۔ لیکن حکومتی وسائل اتنے زائد نہیں ہیں جو تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی میں متوازن غذا اور بیماریوں خاص کر دل کی بیماریوں کے متعلق پر چار کر سکے۔

اس سلسلہ ہمارے اولین فرائض میں شامل ہے کہ ہم معالجین لوگوں میں احساس پیدا کرنے

میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔

ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ مناسب اور متوازن غذا، ورزش، تمباکو نوشی سے اجتناب، اور سہل زندگی کے بجائے، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کو اپنے ہاتھ سے سرانجام دینے سے اور تھوڑے تھوڑے سفر بجائے گاڑی کے پیدل طے کرنے سے نہ صرف روپیہ کی بچت ہوتی ہے بلکہ پیدل چلنے سے پسینہ کی شکل میں فالتوں مادوں کے اخراج سے جسم تندرست اور توانا رہتا ہے۔

اوپر بیان کردہ تمام عوامل ہائی بلڈ کولیسٹرول کو روک کر CHD یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز سے جان بچاتے ہیں اور CHD کے باعث ہارٹ ایکٹ کو روک سکتے ہیں۔ ضرورت صرف لوگوں کو احساس دلانے کی ہے۔

ہمارے ملک میں غریب افراد تو وسائل کی کمی پائی کی بناء پر متوازن غذا نہ کھا سکنے کے باعث بیمار ہوتے ہیں مگر اکثر وسائل رکھنے والے لوگ جن کے پاس ہر سہولت موجود ہوتی ہے، وہ زیادہ مرغن غذاؤں اور سہل پسندی کے باعث CHD کورونری ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا ہو کر ہارٹ ایکٹ سے دوچار ہوتے ہیں کیونکہ وہ غذا کی کلوورک Caloric مقدار کو نہیں جانتے کہ ان کو کتنے کلووری غذا کی ضرورت ہے، وہ کام بہت کم کرتے ہیں اور غذا میں اتنی فیٹس استعمال کرتے ہیں جو بہت زیادہ کلیوری کی حامل ہوتی ہے۔

اور روزانہ بلا ضرورت اتنی مقدار میں چربی والی غذاؤں کی بدولت ان کے دل کی شریانوں اور وریدوں میں سختی اور تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سختی اور تنگی کو پیدا کرنے والا ہائی بلڈ کولیسٹرول ہی ہوتا ہے جو بالآخر ہارٹ ایکٹ کا سبب بنتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو ہارٹ ایکٹ سے بچانے کے لئے آپ کو اپنے بلڈ کولیسٹرول لیول کے متعلق ضرور علم ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ہارٹ ایکٹ کے خطرہ کے کم، زیادہ، یا بہت زیادہ قریب ہیں۔

اس کے بعد کولیسٹرول کو کم کر کے ہارٹ ایکٹ سے محفوظ ہونے کے لئے مستند معالج سے رجوع کریں، اس کی زیر نگرانی علاج دیر نیز آپ کو ہارٹ ایکٹ سے ضرور بچانے میں کامیاب رہے گی۔

کولیسٹرول کی مقدار معلوم کرنا

کولیسٹرول لیول ہمیشہ ہی ایک مقررہ درجہ تک نہیں رہتا بلکہ دن بدن طرز زندگی، غذا، سٹرین اور موسم کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ہلڈ کولیسٹرول کے لیولز میں فرق پڑتا ہے۔ بہت سے عوارضات میں ادویاتی استعمال کے زیر اثر ہلڈ کولیسٹرول میں کمی و بیشی ہوتی رہتی ہے۔

مزید براں ہلڈ کولیسٹرول کی مقدار معلوم کرنے کے مختلف طریقے رائج ہیں۔ جس بناء پر ایک ہی وقت میں لئے گئے خون کے نمونہ کو اگر مختلف لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کروایا جائے تو ہر لیبارٹری کی رپورٹ دوسری سے الگ ہوگی۔

Archives آف انٹرنل میڈیسن کی 1990 کی رپورٹ کے مطابق پیچاس سے زائد افراد کا ایک ہفتہ میں تین دفعہ ہلڈ کولیسٹرول، ٹرائی گلیسرائیڈز HDL اور LDL ٹیسٹ کیا گیا۔ ٹیسٹ کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے تھا سوموار، بدھ اور جمعہ کو ہر فرد کا ٹیسٹ کرنے سے یہ بات عیاں ہوئی کہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن اور پھر ایک دن چھوڑ کر دوسرے دن تین مرتبہ جو نتائج حاصل ہوئے ان میں کافی فرق تھا مثلاً

کولیسٹرول لیول میں پانچ فی صد، ٹرائی گلیسرائیڈز میں 20 فی صد، HDL میں دس فی صد اور LDL میں آٹھ فی صد تک فرق تھا۔

اس بات کو بنیاد بناتے ہوئے ماہرین ہلڈ کولیسٹرول اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی فرد کا بالکل ٹھیک ہلڈ کولیسٹرول جاننے کے لئے اس کے تین ٹیسٹ کروائے جائیں اور ان تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہائی ہلڈ کولیسٹرول، او ہلڈ کولیسٹرول یا نارمل ہلڈ کولیسٹرول کا فیصلہ کیا جائے۔

لیبارٹریز کی تغیراتی رپورٹس

ہمارے ملک میں لیبارٹریز شاف کی لاپرواہی اور صرف تجارتی بنیادوں پر چیکنگ نے بہت اچھے لوگوں کے کردار پر دھبہ لگا رکھا ہے۔ لاپرواہی اور غیر ذمہ دارانہ رویہ کے حامل افراد ہر جگہ موجود ہیں۔ لیکن دیانت دار، مہنتی، پیشہ ورانہ ذمہ دار افراد کی بھی کمی نہیں ہے۔

اس لئے ایک ہی ہلڈ نمونہ کو اگر مختلف لیبارٹریوں میں بھیجا جائے تو مختلف رپورٹس دیکھنے

میں آتی ہیں۔

اس کی بنیادی وجہ پیشہ ورانہ غفلت نہیں بلکہ لیبارٹری کی مختلف تکنیکی طریقوں کے باعث بھی ایک لیبارٹری کی دوسری لیبارٹری کی رپورٹ کے ساتھ مطابقت نہیں ہوگی۔

ہمارے ہاں تو اتنی جدید سہولتیں میسر نہیں ہیں بہت کم لیبارٹریوں میں جدید طرز کا سامان ہے۔

لیکن یورپ اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی مختلف لیبارٹریوں سے ایک وقت میں کئے گئے ٹیسٹوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔

آج کل زیادہ تر بلڈ کولیسٹرول ٹیسٹ بڑی فاسٹ تکنیکوں سے کئے جاتے ہیں۔ جن کو اکثر ماہر معالجین تسلیم نہیں کرتے۔ کیونکہ ان ٹیسٹ رپورٹس میں دس سے بیس فی صد تک کی غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ اور اسی دس سے بیس فی صد مقدار کی کمی یا بیشی پر ہی معالج نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مریض کو CHD یا ہارٹ ایک کا خطرہ بہت زیادہ ہے، کم ہے، یا نہیں ہے۔

اس لئے لیبارٹری ٹیسٹ رپورٹس کا بالکل ٹھیک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثلاً کسی فرد کا بلڈ کولیسٹرول ایک مرتبہ 205 ملی گرام ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ ہائی بلڈ کولیسٹرول کی جانب بڑھ رہا ہے لیکن اسی آدمی کے تین ٹیسٹوں کی اوسط نکالی گئی تو وہ 195 ملی گرام تھی جو کہ نارمل حد ہے۔

اب آپ اس بات سے اندازہ لگالیں، دس درجہ کا فرق کسی کو نارمل قرار دلا رہا ہے اور دوسری جانب مریض قرار دلوا رہا ہے۔

ایک اور مزہ کی بات بتاؤں پانچ سے دس فی صد تک ہر لیبارٹری کا دوسری لیبارٹری سے فرق ایک عمومی بات ہے۔

اب دیکھیں کہ کتنی مشکل سے بالکل ٹھیک تشخیص ممکن ہوتی ہے۔

ہمارے ہاں اس میدان میں کوئی زیادہ ریسرچ نہیں ہوئی لیکن ترقی یافتہ ممالک میں اسی ایک بات پر بڑی بڑی تحقیقات کی گئی ہیں۔

1985ء میں یو۔ ایس۔ اے میں امریکن کالج آف پیتھالوجسٹ نے ایک ہی خون کے نمونے 5,000 ہزار سے زائد مختلف لیبارٹریز کو بھجوائے جو لیبارٹریاں Dupont method کے مطابق ٹیسٹ کرتیں تھیں ان کی رپورٹس کے مطابق بلڈ کولیسٹرول لیول 222 سے 270 ملی گرام تھا۔ ایسی لیبارٹریز جو SMAE Method سے بلڈ کولیسٹرول چیک کرتی تھیں ان کی رپورٹس کے مطابق

بلڈ کولیستروں لیول 250 سے 294 ملی گرام تک تھا۔ اور اسی لیبارٹریز جو بلڈ کولیستروں لیول معلوم کرنے کے لئے Beekman کا طریقہ اپناتی تھیں ان کی رپورٹس کے مطابق بلڈ کولیستروں لیول 267 سے 297 ملی گرام تھا۔ جب کہ انما کی نہایت ہی جامع لیبارٹری کی رپورٹ 262 ملی گرام تھی۔ اب آپ ہی فیصلہ کر لیں کہ نہایت جدید آلات کے استعمال کے باوجود بھی مختلف لیبارٹریز کے رزلٹ مختلف ہیں۔

حمل کے دوران کولیستروں لیول

مورتوں میں حمل کے دوران کولیستروں لیول بڑھ جاتا ہے۔ حمل کے آخری ہفتہ کے دوران، کولیستروں لیول 40 سے 50 فی صد تک بڑھ سکتا ہے۔ یعنی آخری ہفتہ میں حاملہ عورت کا کولیستروں لیول غیر حاملہ عورت کے مقابلہ میں نارمل سے چالیس سے 50 فی صد تک بڑھ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے ہارٹ ایکٹک والے مریض کے بلڈ کولیستروں لیول کو کوئی خاص قابل اعتنا نہیں سمجھا جاتا۔

بچوں میں کولیستروں لیول

کیا بچوں کے دل کی شریانوں میں بھی بڑوں کی طرح تنگی اور سختی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی بنیاد بہت زیادہ چربی اور کولیستروں ہوتا ہے؟ یہ سوال والدین کے لئے، معالجین، سائنسدان اور تحقیقی افراد کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

ماہرین اس بات پر پوری طرح متفق ہیں کہ بچوں کو بھی بڑوں کی طرح دل کی شریانوں کی تنگی اور رکاوٹ کا ڈر ہوتا ہے، اگر ان کا بلڈ کولیستروں بڑھتا جا رہا ہو۔ عام طور پر بچوں د میں بلڈ کولیستروں یا انہوں کے مقابلہ میں 10 سے 20 فی صد تک کم ہوتا ہے۔

ایسے بچے جن کا بلڈ کولیستروں 170 ملی گرام سے کم ہو، انہیں کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ 170 سے 199 ملی گرام بلڈ کولیستروں لیول والے بچے زیادتی کی حدود میں اور 200 ملی گرام سے زیادہ والے بچوں کو بالکل پر خطرہ گروپ میں رکھا جاتا ہے۔

یہاں پر والدین اور بچوں کے لئے ایک خاص بات جو عرض کرتا چلوں، جدید تحقیقات سے

یہ بات بھی بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ جو بچے اچھی غذا کھاتے ہیں اور کھیل کود، ورزش، سیر وغیرہ سے اجتناب کرتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کے آگے فارغ وقت گزارتے ہیں ان میں بلڈ کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے کیونکہ ایسے بچے ورزش کے عادی نہیں ہوتے جس کے باعث استعمال کی گئی غذا کی فالتو چربی اور کولیسٹرول صرف ہونے کی بجائے جمع ہوتا رہتا ہے اور وہ دل کی شریانوں کو متاثر کرتا ہے۔

اگر غور کیا جائے تو حقیقت یہی ہے کہ دل کی شریانوں کی تنگی اور رکاوٹ بالغ ہونے سے کافی دیر پہلے ہی شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور جب درمیانہ عمر یا بالغ عمر والے لوگوں میں علامات ظاہر ہوتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔

اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج کا بچہ کل کا بالغ ہے اور اپنے ملک میں CHD کو کم کرنے کے لئے ہمیں بڑی محنت کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کی صحت پر خصوصی توجہ دیں کیونکہ کل ان کا ہے۔ اور صحت مند بچہ صحت مند آدمی بنے گا۔ بچوں کے بالغ عمر کو پہنچنے سے پہلے سے ہی ان کا بلڈ کولیسٹرول لیول چیک کرواتے رہنا چاہیے۔ تاکہ CHD یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز اور ہارٹ ایک کی شرح کو کم از کم کیا جاسکے اور صحت مندانہ معاشرہ قائم ہو سکے۔ بیمار معاشرہ زندگی کے کسی بھی شعبہ میں حقیقی معاشرہ کا رول ادا نہیں کر سکتا۔

معالجین کی اولین ذمہ داری ہے کہ اپنے زیر علاج مریضوں جن کا بلڈ کولیسٹرول بہت بڑھا ہوا ہو یا CHD کورونری ہارٹ ڈیزیز کے مریضوں کا علاج کرتے وقت ان کے بچوں کا بھی بلڈ کولیسٹرول لیول معلوم کیا جائے۔

اور اگر بچوں میں بلڈ کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہو تو انہیں چربی کی اور کولیسٹرول سے بھرپور غذاؤں سے روک کر سبزیاں اور فروٹ کھانے کی طرف مائل کیا جائے۔ فارغ وقت میں انہیں سیر، ورزش اور کھیل کود کی بھی تلقین کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو جائے تو ہمارے ملک میں CHD کی شرح اور ہارٹ ایک کے باعث ہونے والی اموات کی شرح میں بہت حد تک کمی واقع ہو جائے گی۔

بڑی عمر والے افراد میں کولیسٹرول لیول

ساتھ سال اور اس سے زیادہ عمر والے افراد میں موت اکثر ہارٹ ڈیزیز یا دل کے دورے سے واقع ہونے کی تعداد بہت زیادہ ہے۔

جدید تحقیقات کے مطابق جو 20 سے 74 سال کی عمر والے ہزاروں افراد پر کی گئی۔ ماہرین

اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ 240 ملی گرام سے بڑھا ہوا بلڈ کولیسٹرول لیول کسی قدر خطرناک ہو سکتا ہے اور اس کی خطرناکی مختلف عمر والے افراد میں کچھ اس تناسب سے ہوا کرتی ہے۔

مردوں میں 240 ملی گرام سے بڑھا ہوا کولیسٹرول لیول

عمر	فی صد خطرناک
20 سے 24 سال	والے مردوں میں 6.2 فی صد
25 سے 34 سال	والے مردوں میں 15.3 فی صد
35 سے 44 سال	والے مردوں میں 27.9 فی صد
45 سال 54 سال	والے مردوں میں 36.9 فی صد
55 سال سے 64 سال	والے مردوں میں 36.8 فی صد
65 سال سے 74 سال	والے مردوں میں 31.7 فی صد

بڑی عمر والے افراد میں بلڈ کولیسٹرول لیول پر بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں جو درج ذیل ہیں
 غذائی تبدیلی، دانتوں کا نہ ہونا، غذائی ذائقہ اور خوشبو میں تبدیلی واقع ہو جانا، کولیسٹرول کے جزو بدن بننے میں تبدیلی، ادویاتی اثرات اور بیک وقت پیدا ہونے والے کئی طبی پیچیدہ عوامل شامل ہیں۔

تاہم بڑی عمر والے افراد میں کولیسٹرول لیول کی مقدار میں زیادتی کی معقول اور اصل وجہ ابھی تک معمر بنی ہوئی ہے۔ شاید بڑھتی ہوئی عمر کے غلیوں کو زیادہ کولیسٹرول کی ضرورت پیش آتی ہے کیونکہ سلیز کی بیرونی حصار یعنی سیل ممبرین کے اجزائے ترکیبی میں کولیسٹرول کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ سیل ممبرین میں سیلولر کولیسٹرول کی شکل میں 95 فی صد تک کی مقدار موجود ہوتی ہے۔

خیال یہ ہے کہ بڑی عمر والے افراد کے جسمانی سیلز Celss آہستہ آہستہ کولیسٹرول کی اپنے ساتھ ملی ہوئی ترکیب کو کم کرتے جاتے ہیں۔ اس لئے ان کے مناسب کام کو جاری رکھنے کے لئے ایک مناسب مقدار کولیسٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاید اسی وجہ سے بلڈ کولیسٹرول بڑھتا ہے اور بڑی عمر والے افراد کے سیلز میں واقع کولیسٹرول کی کمی کو پورا کرتا ہے۔

جدید ریسرچ سے یہ بات عیاں ہوئی ہے کہ بڑی عمر والی خواتین 270 ملی گرام سے کولیسٹرول لیول کی زیادتی کے باعث دل کی بیماریوں کی شرح بہت زیادہ ہے۔

اس لئے اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ تمام ایسی خواتین جو 60 سے 80 سال عمر والی ہوں،

اگر ان کا بلڈ کولیسٹرول لیول 270 ملی گرام سے زائد ہو تو انہیں علاج کی فوری ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اور جدید تحقیق جو 1480 مردوں پر کی گئی جن کی عمر میں 65 سال سے زائد تھیں، ان میں ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول کے سبب 60 سے 70 فی صد تک ہارٹ اٹیک کا خطرہ تھا، ان کی نسبت جن کی عمر میں 65 سال سے زائد تھیں مگر بلڈ کولیسٹرول لیول نارمل تھا۔

اسی طرح HDL کی کمی اور LDL کی زیادتی سے بھی ہارٹ ڈیزیز لاحق ہونے کی شرح بڑھ جاتی ہے۔ فریمنگھم کی تحقیق Framingham سے یہ بات بھی واضح ہوئی ہے کہ 285 ملی گرام ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول کو کم کر کے 200 ملی گرام تک لے آنے سے 65 سے 74 سال عمر والے افراد میں ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ 33 فی صد اور 75 سے 84 سال عمر والے افراد میں ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ 23 فی صد تک کم ہو جاتا ہے۔

امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی 382 گورے افراد پر کی جانے والی تحقیق جن کی عمریں 65 برس سے زائد تھیں اور تحقیق کا دورانیہ آٹھ سالوں پر محیط تھا۔ دوران تحقیق 43 افراد فوت ہو گئے۔ ٹوٹل کولیسٹرول اور LDL بہت زیادہ بڑھا ہوا تھا۔

ہر 10 ملی گرام زیادتی کولیسٹرول سے دل کی بیماریوں کے باعث ہلاکتوں کی شرح آٹھ فی صد تک بڑھ جاتی ہے۔ تحقیق سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بڑھاپے میں بھی کولیسٹرول لیول کا کم ہونا دل کے امراض سے بچاتا ہے۔

دسمبر 1990ء میں انٹرنل میڈیسن کی سالانہ اشاعت میں سان فرنسکو میں ڈاکٹر روبن اور ان کے ساتھیوں کی کئی تحقیقات کے نتائج کچھ اس طرح سے تھے کہ انہوں نے 2746 آدمیوں پر تحقیق کی، جن کی عمریں 60 سے 79 سال کے درمیان تھیں۔ دس سال تک ان کی نگہداشت کی گئی، اس مدت کے دوران ان میں سے 260 آدمی دل کے امراض کے باعث ہلاک ہو گئے۔ اور باقی بچنے والوں اور مرنے والوں کے مسلسل دس سالہ مطالعہ سے یہ بات بالکل درست قرار پائی کہ جس قدر بلڈ کولیسٹرول بڑھتا جائے گا، اسی قدر زیادہ دل کے امراض کے سبب شرح اموات بڑھتی جائے گی، چاہے بڑی عمر والے افراد میں کیوں نہ ہو۔

ایسے افراد جن کی عمریں ساٹھ سال یا ساٹھ سال سے زائد ہوں انہیں بھی جوان افراد کی طرح اپنے بلڈ کولیسٹرول لیول کو چیک کرواتے رہنا چاہئے۔ تاکہ اس کو نارمل حدود میں رکھ کر دل کے امراض میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں جانے سے بچا جاسکے۔ ساٹھ سال یا زائد عمر والے افراد کو بھی

اپنی خوراک میں چربی اور مرغن غذاؤں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔
 اس ایجنسی میں غذائی اعتبار سے ریسرچ کی گئی۔ 846 بوڑھے افراد کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک گروپ کے افراد کو چربی اور کولیسٹرول کی کم مقدار والی خوراک دی گئی جب کہ دوسرے گروپ کو ان کی مرضی کے مطابق عام غذا پر رہنے دیا۔ آٹھ سال کی شبانہ روز محنت سے یہ پتہ چلا کہ گروپ A یعنی ایسے افراد جن کو چربی اور کولیسٹرول کی کم مقدار والی غذا دی گئی تھی، ان میں سے صرف 66 افراد کو دل کا دورہ پڑا اور گروپ B یعنی ایسے افراد جو اپنی غذا معمول کے مطابق کھا رہے تھے ان میں سے 96 افراد دل کے دورہ سے دوچار ہوئے۔ ان تمام تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی قدر کولیسٹرول لیول کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے کتنی احتیاطی تدابیر اپنانا پڑتی ہیں۔
 برصغیر کے علاقہ میں اکثریتی لوگ اس پر بالکل دھیان نہیں دیتے، اس لئے ہمارے ملک پاکستان میں دل کے امراض اور اس کے باعث شرح اموات میں کافی تیزی آتی جا رہی ہے۔
 ان پیش کی گئی تمام تحقیقات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ عمر کے کسی بھی حصہ میں ہوں بلڈ کولیسٹرول کو نارمل رینج میں رکھنا ضروری ہے۔

اور ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول لیول کو نارمل رینج میں رکھ کر نہ صرف ہارٹ ڈیزیز سے بچا جاسکتا ہے بلکہ ہارٹ ڈیزیز کے باعث ہونے والی شرح اموات کو بھی کم کیا جاسکتا ہے۔
 ترقی یافتہ ممالک مثلاً کینیڈا، جاپان، انگلینڈ، یونائیٹڈ سٹیٹ میں لوگوں کی عمریں 75 سال سے زائد ہوتی ہیں۔ جب کہ ہمارے ملک پاکستان میں اوسط عمر 60 ساٹھ کے قریب ہے۔
 لاکھوں لوگ 40 اور 55 سال کی عمر کے درمیان دل کی بیماریوں کے باعث موت کا شکار ہوتے ہیں۔ جب کہ ترقی یافتہ ممالک میں 60 سے 75 سال کے درمیان عمر والے افراد دل کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔

احتیاطی تدابیر اور بیماریوں کے لاحق ہونے کی آگہی کے سبب ان کی اوسط عمریں ہم سے 10 سے 20 سال تک زائد ہیں۔

ہمارے ملک میں لوگوں کو دل کے امراض کے بارے میں معلومات بہت ہی کم ہیں اور 42 سے 48 سال کی عمر کے درمیان ہی بہت سے لوگ ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہو کر 3 سے 5 سال کے اندر رقتِ اجل بن جاتے ہیں۔

ہمارے ذرائع ابلاغ نے اس سلسلہ میں بہت ہی کم کام کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ فضول قسم

کے کاموں میں الجھ کر قوم کی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دینے سے قاصر رہے ہیں۔

ورد دل والے افراد، مخیر افراد اور سوشل ورکروں کو عوام کو صحت عامہ کے تحفظ کی آگاہی کے لئے حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ بے شک یہ کتاب ایک میڈیکل کی کتاب ہے لیکن ہمارے ملک میں ابھی تک لوگوں میں ہارٹ ڈیزیز جس کی بنیادی وجہ ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول لیول میں اضافہ ہے اور اس کے علاوہ دیگر امراض کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہیں کہ ان امراض سے کیسے محفوظ رہا جاسکتا ہے اور کون کون سے عام احتیاطی تدابیر سے ہم صحت مندرہ سکتے ہیں۔

تندرست رہ کر ہی ہم اپنے ملک و قوم کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں۔

ہائی بلڈ کولیسٹرول

کی وجوہات

CAUSES OF HIGH
BLOOD CHOLESTEROL

وراثتی خطرہ کا عنصر

(Heredity- A Risk Factor)

ایسے افراد جن کے خاندان میں والدین یا دادا، دادی میں سے کوئی دل کے امراض کا شکار رہا ہو، دوسرے عام افراد جن کے خاندان میں کوئی ہارٹ ڈیزیز کا مریض نہ ہو۔ خاندان سے مراد دادا، دادی، والدین یا نانا، نانی وغیرہ جو قریبی خونی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کی نسبت 3 سے 5 گنا زیادہ ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہوتے ہیں یا انہیں اس نسبت سے دل کے امراض گلنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔

اگر والدین میں ہارٹ ڈیزیز موجود ہوں یا بد قسمتی سے 50 سال کی عمر سے پہلے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہو تو ان کی اولاد میں وراثتی طور پر یہ خطرہ بہت زیادہ حد تک لاحق ہوتا ہے کہ انہیں 50 سال کی عمر سے پہلے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے جینز (Genes) جو خصوصیات کنٹرول و نسل منتقل کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اچھی صحت یا بیماری دونوں کے منتقل کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ٹوٹل ہائی بلڈ کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، موٹاپا جو خاص کر ہارٹ ڈیزیز کا باعث ہوا کرتے ہیں یہ عوامل نسل در نسل منتقل ہوتے رہتے ہیں۔

اسی طرح تمباکو نوشی، سہل پسندی، ورزش کا فقدان اور زیادہ کھانے کی عادات بھی نسل در نسل منتقل ہوا کرتی ہیں۔

دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ ڈیزیز والی جگہ (Finland) ہے۔ وہاں پر ہونے والی ایک نہایت دلچسپ تحقیق سے یہ بات سامنے آئی کہ 211 آدمیوں پر جن کے خاندان میں ہارٹ ڈیزیز موجود تھیں ریسرچ کی گئی تو 211 خاندانی ہارٹ ڈیزیز ہسٹری رکھنے والوں میں سے 50 کو ہارٹ اٹیک ہوئے۔ 55 اور افراد ہارٹ ڈیزیز سے ہلاک ہوئے اور 53 افراد کو انجائنا کا درد لاحق ہوا (Angina)۔

مزید برآں ایسے افراد جن میں خاندانی ہارٹ ڈیزیز کی ہسٹری پائی جاتی تھی، ان کا ایسے بالغ افراد سے موازنہ کیا گیا جن کی خاندانی ہسٹری میں CHD موجود نہ تھیں تو پتہ چلا کہ CHD ہسٹری رکھنے والے افراد میں دوسرے افراد کی نسبت ہائی بلڈ کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر بہت زیادہ تھا۔

کیلچورنیا کے سائنسدانوں نے بڑی مہارت سے اس بات کا پتہ چلا یا ہے کہ CHD کو نسل در نسل منتقلی جینز کے ذریعہ ہوا کرتی ہے۔ وہاں پر 400 ایسے مریضوں پر تحقیق کی گئی جو CHD یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا تھے۔

ان کا موازنہ ایسے 150 افراد سے کیا گیا جو بالکل صحت مند تھے تو پتہ چلا کہ ایسے افراد جو CHD یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز میں مبتلا تھے، ان کے جینز (Genes) میں صحت مند افراد کے جینز (Genes) کے مقابلہ میں مخصوص نوعیت کی تبدیلیاں واقع ہوئیں تھیں۔

وراثتی لاپروہٹین کی خرابیاں (Genetical lipoprotein disorders) اگر غذا کی وجوہات کے علاوہ کسی خاندان میں یا کسی فرد میں اندائی طور پر ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول زیادہ ہو اور اس کی بنیاد وجہ جینز (Genes) ہوں تو ایسے افراد میں غذائی پرہیز سے ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول لیول کو نارمل سطح تک نہیں لایا جاسکتا۔

ہمارے ملک پاکستان اور ہمسایہ ملک بھارت میں ہائی بلڈ کولیسٹرول کی زیادہ وجہ Genetic یعنی جینیاتی ہے۔ اس کی بہت سی قسمیں ہیں۔ جن میں سے چند مشہور کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔

(1) ہائپر لائیپائیڈیمیا (Hyperlipidemia)

(2) ہائپر کولیسٹرولیمیا (Hypercholesterolemia)

Hyperlipidemia سے مراد خون میں چربی کی زیادتی ہے۔

Hypercholesterolemia سے مراد خون میں کولیسٹرول کی زیادتی ہے۔

یہ بات ذہن نشین رہنا چاہیے کہ خاندانی اور جینیاتی کولیسٹرول کا بگاڑ تقریباً 5 فی صد ٹوٹل آبادی میں پایا جاتا ہے۔ اور اس نتیجہ پر دنیا بھر میں ہونے والی تحقیقات سے حال ہی میں اتحاق ہوا ہے۔

ڈاکٹر میٹاکل براؤن Michael Brown اور ڈاکٹر Joseph Goldstein جن کو میڈیسن پر دو نوبل انعام مل چکے ہیں۔ ان کے مطابق کولیسٹرول ریسیپٹر Receptor سلاز اور اینزائم کی جگہ میں خرابی کے باعث کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈز میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس سے دل کے امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

تمام قسم کی چینائی خرابیوں سے نیچے بیان کردہ ایک یا زیادہ مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔

(1) ٹوٹل کولیسٹرول میں اضافہ

(2) LDL کولیسٹرول میں اضافہ

(3) ٹرائی گلیسرائیڈ لیول میں اضافہ

(4) HDL کولیسٹرول میں کمی

بد قسمتی سے ایسے افراد جن میں وراثتی طور پر کوئی بھی بگاڑ چینائی وجہ سے پیدا ہوا ہو تو اس پر مکمل قابو نہیں پایا جاسکتا۔

یہاں پر

ہومیو پیٹھی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہومیو پیٹھی ایک ایسا فطرتی طریقہ علاج ہے جو مرض کا نہیں مریض کا علاج کرتا ہے۔

مرض خواہ کوئی بھی ہو تمام علامات کو اکٹھا کر کے مریض کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے، مریض کے میازم کے مطابق بالمثل اصول کو اپنا کر دو تجویز کی جاتی ہے۔ جو مریض کی تمام علامات کو درست کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ آگے چل کر علاج کے باب میں، آپ کو اپنی پریکٹس کے دوران آنے والے بلڈ کولیسٹرول کے مریضوں کے کیس پیش کئے جائیں گے، جو بافضل خدا شفا یاب ہوئے۔

سٹریس (Stress)

بہت سے افراد سٹریس کی تعریف کرنے سے قاصر ہوتے ہیں حالانکہ وہ خود اس میں گرفتار ہوتے ہیں۔

یہ ذہنی دباؤ کی ایک قسم ہے۔ جو بے چینی، غصہ، خوف، زردی، چڑچڑاہٹ، مایوسی اور افسردگی کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جسمانی اور ذہنی توانائی کا ضیاع یا زائد استعمال ہوا کرتا ہے۔

اوپر بیان کردہ تمام کیفیات میں چھوٹری گھینڈ، ایڈرنل گھینڈ، تھائی رائیڈ گھینڈ کی رطوبات میں

اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان دلوپات کو ہارمون کہتے ہیں (Hormones)۔ بلند پریش کی زیادتی اور کولیسٹرول لیول میں اضافہ والے مریضوں میں یہ تمام کیفیات نوٹ کی جاسکتی ہیں۔ آخر کار شریانوں کی تنگی ہو کر کولیسٹرول کی زیادتی کے باعث ہوتی ہے۔ CHD کا باعث بنتی ہے۔

اگر ذہنی دباؤ stress کی مناسب تدابیر یا علاج سے کنٹرول نہ کیا جائے تو چربی کا ہموا شریانوں کو تنگ کر دیتا ہے۔

شریائیں سکڑ جاتی ہیں اور ہارٹ اٹیک کے خطرہ میں بہت حد تک اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسے بہت سے عوامل ہیں جن کی بنا پر سٹرلیس جنم لیتی ہے۔ ذہنی دباؤ stress پر بہت سی تحقیقات ہو چکی ہیں۔

دانشکون یونیورسٹی کے ڈاکٹر تھامس ہولمز Dr. Thoms Holmes اور ریچرڈ رائے Richard Rahe نے بہت سے لوگوں پر سٹرلیس کے حوالہ سے تحقیقات کیں اور سٹرلیس کا ایک پیمانہ بنایا جو پیش خدمت ہے۔

انہوں نے مختلف انواع کی سٹرلیس کی گریڈنگ کی کہ فلاں قسم کی وجہ اتنے درجہ سٹرلیس ہوتی ہے اور فلاں سے اتنے درجہ جس کو ایک چارٹ کی شکل میں کچھ اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے۔

مختلف نوعیت کی سٹرلیسز

- سٹرلیسز کی اہمیت کے اعتبار سے گریڈنگ پوائنٹ
- (1) میاں اور بیوی میں سے کسی ایک کے فوت ہو جانے پر دوسرے فرد 100 پوائنٹ کو ہونے والی سٹرلیس کے 100 پوائنٹ
 - (2) طلاق کے بعد پیدا شدہ سٹرلیس 073 پوائنٹ
 - (3) ایک دوسرے کے حق زوجیت ادا نہ کرنے پر 065 پوائنٹ
 - (4) زیر حراست جیل وغیرہ میں پیدا شدہ سٹرلیس 063 پوائنٹ
 - (5) خاندان کے کسی فرد کے فوت ہونے کی صورت میں 063 پوائنٹ
 - (6) ذاتی طور پر زخمی ہونے یا کسی بڑی بیماری کی صورت میں 053 پوائنٹ
 - (7) شادی کی پریشانی کی صورت میں 050 پوائنٹ
 - (8) کام کاج کی تنگی کی صورت میں پیدا شدہ سٹرلیس 047 پوائنٹ

- (9) جوڑے کی دوبارہ صلح کی صورت میں 045 پوائنٹ
- (10) کام سے ریٹائرمنٹ کے بعد 045 پوائنٹ
- (11) خاندان کے کسی فرد کی صحت یا رویہ میں تبدیلی کے باعث 044 پوائنٹ
- (12) حمل میں پیدا شدہ سٹرپس 040 پوائنٹ
- (13) جنسی مشکلات سے 039 پوائنٹ
- (14) خاندان میں کسی نئے فرد کی شمولیت سے خواہ آنے والا فرد ابھی پیدا ہوا ہو یا گود لیا گیا ہو یا کوئی بوڑھا فرد ہو 039 پوائنٹ
- (16) عام سطح سے ہٹ کر بہت زیادہ پیسہ آجانے پر یا پیسے کے نقصان سے پیدا شدہ سٹرپس 038 پوائنٹ
- (17) کسی قریبی دوست کے فوت ہو جانے پر 037 پوائنٹ
- (18) کام کی نوعیت بدلنے پر 036 پوائنٹ
- (19) روزمرہ سے ہٹ کر میاں کو بیوہ یا بیوی کو میاں کی جانب سے بہت زیادہ شدید کم یا زیادہ بحث و مباحثہ کے سامنا سے بچوں کے معاملہ پر یا ذاتی عادات پر 035 پوائنٹ
- (20) کاروبار یا گھر کی خریداری کے لئے رہن رکھنے پر 031 پوائنٹ
- (21) کام کاج کی ذمہ داریوں میں بڑی تبدیلی کے باعث مثلاً ترقی، تنزلی، تبادلہ وغیرہ 029 پوائنٹ
- (22) بیٹے یا بیٹی کے گھر چھوڑ دینے پر، شادی، یا کالج جانے کی صورت میں پیدا شدہ سٹرپس 029 پوائنٹ
- (23) قانونی مسائل کے باعث پیدا ہونے والی سٹرپس 029 پوائنٹ
- (24) ذاتی واجب الادا دیوٹی کے سرانجام دینے پر یا غیر معمولی اشیاء کے حصول سے 028 پوائنٹ
- (25) گھر سے باہر مصروفیات کو ترک کرنے سے یا شادی کی شروعات میں خاص کر عورتوں میں پیدا ہونے والی سٹرپس 026 پوائنٹ
- (26) سکول وغیرہ کی پابندی کے اطلاق سے یا چھوڑنے سے 026 پوائنٹ

- (27) رہن سہن کے ماحول میں بڑی تبدیلی سے مثلاً نیا مکان بنانے سے، ہمسائیوں کی تبدیلی سے یا گھریلو تبدیلیوں کی بنا پر
- (28) ذاتی اطوار کا بار بار دہرائے۔ لباس وغیرہ کے معمولات سے پیدا شدہ سٹریس
- (29) اپنے افسر سے تعلقات کشیدہ ہونے پر
- (30) کام کاج کے اوقات کار کی تبدیلیاں یا شرائط کی تبدیلیوں کے باعث پیدا شدہ سٹریس
- (31) رہائش کی تبدیلی کے باعث پیدا شدہ سٹریس
- (32) نئے سکول میں داخلہ کے باعث
- (33) مذہبی مصروفیات میں انتہائی کمی یا انتہائی تیزی
- (34) سوشل سرگرمیوں میں کوئی بڑی تبدیلی
- (35) میند میں بہت زیادہ کمی یا بہت زیادہ زیادتی
- (36) فیملی کے افراد جن کے ساتھ رہتا ہوں کی تعداد میں اضافہ یا کمی کے باعث پیدا شدہ سٹریس
- (37) کھانے پینے کی عادات میں تبدیلی سے
- (38) چھٹیوں میں وقت گزارنے سے
- (39) بڑے بڑے تہواروں پر
- (4) ٹریفک قوانین پر عمل نہ کرنے کی صورت میں پیدا شدہ سٹریس
- سٹریسز کے بارے مزید چار اہم باتیں:

- (1) صفر سے 149 تک گریڈنگ والے افراد کم سٹریس کے زمرہ میں آتے ہیں۔
- (2) 150 سے 199 تک گریڈنگ والے افراد ہلکی سٹریس کے زمرہ میں آتے ہیں۔
- (3) 200 سے 299 معتدل کے زمرہ میں اور
- (4) 300 گریڈنگ یا اس سے زیادہ والے افراد بڑی سٹریس کے زمرہ میں آتے ہیں۔

درج ذیل بیان کروہ تحقیقات کی روشنی میں اپنی شخصیات کا جائزہ لیں

بہت سے افراد پرسرپر تحقیقات کے بعد ماہرین نے تمام افراد کو دو گروپوں میں تقسیم کیا A

اور B۔

گروپ اے (Group A)

ایسے افراد جو ہمیشہ جلدی میں رہتے ہیں اور جلد باز ہوتے ہیں وہ کم از کم وقت میں بہت سے کام کرنا چاہتے ہیں۔

یہ لوگ عملی زندگی میں زیادہ کامیاب نہیں ہوتے، وہ اپنے اکثر کام ادھورے چھوڑتے ہیں۔

کیونکہ وہ ایک وقت میں بہت سے کام کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں اور نتیجتاً کئی کام ادھورے رہتے ہیں یا ٹھیک طور پر مکمل نہیں ہوتے۔

گروپ بی (Group B)

گروپ بی سے تعلق رکھنے والے افراد بردبار، حوصلہ مند، اور پراعتماد ہوتے ہیں۔ وہ تمام کام وقت پر اور باری باری حوصلہ مندی، پراعتماد اور ایماندار سے سرانجام دیتے ہیں۔ کام ان کے اعصاب پر سوار نہیں ہوتے وہ ہر کام ٹھیک طریقہ سے مکمل کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں میں خود اعتمادی کی کمی نہیں ہوتی۔

یہی لوگ عظیم ہوتے ہیں۔ ان میں بڑے بڑے ایماندار افراد جو لگن، محنت، پراعتمادی سے اپنے اپنے شعبوں میں کام کرتے ہیں، شامل ہیں۔

گروپ اے سے تعلق رکھنے والے افراد بے صبری، جلد بازی، نا عاقبت اندیشی کے سبب زیادہ سڑکیں میں رہتے ہیں۔ ایسے افراد ذرا ذرا سی بات پر لڑتے، جھگڑتے ہیں۔ اور بہت سارے معاشی، معاشرتی نقصانات کے ساتھ دل کے امراض میں زیادہ مبتلا ہوا کرتے ہیں۔

جب کہ گروپ بی سے تعلق رکھنے والے افراد اپنی حوصلہ مندی، مستقل مزاجی اور تدبیر سے کڑے سے کڑے وقت میں بھی سڑکیں کا شکار نہیں ہوتے، وہ بڑے بڑے کام پراعتمادی سے کر دکھاتے ہیں۔

طرز زندگی، طور طریقے

(Life Style Addications)

عادات اچھی ہوں یا بری ان کے اپنے اپنے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں۔ جو کسی بھی انسان کی شخصیت پر نمایاں نظر آتے ہیں۔

چائے اور کافی پینے کی عادت

دنیا کے آدھے سے زیادہ آبادی چائے پیتی ہے۔ اگرچہ دنیا کے چند علاقوں میں کافی کو پسند کیا جاتا ہے۔

چائے اور کافی دونوں میں کافین ہوتی ہے۔

کافین دماغ پر اثر انداز ہو کر جسمانی تھکاوٹ کو سکون دیتی ہے، دماغی حسوں کو تیز کرتی ہے۔

لیکن چائے اور کافی دونوں کے مسلسل استعمال سے بے خوابی، تھکاوٹ، سستی پیدا ہوتی ہے۔

یعنی پرائمری ایکشن میں چائے اور کافی دونوں کافین کی موجودگی کے باعث، تھکاوٹ میں کمی لاتی ہیں، چاک و چوبند بناتی ہیں جب کہ سیکنڈری ایکشن یعنی ثانوی عمل میں، ان کے استعمال سے تھکاوٹ، سستی، بے خوابی، حافظہ کی کمزوری واقع ہوتی ہے اور پٹھوں کی کمزوری پیدا ہوتی ہے۔

اگر کافی یا چائے کا زیادہ استعمال کیا جائے، تو چونکہ ان دونوں میں کافین موجود ہوتی ہے۔ جس کے باعث اعصابی زو وحسی، بے چینی، بے خوابی پیدا ہوتی ہے، کافین کسی بھی دوا سے کم نہیں ہے۔ ایسے افراد جو کافین کے عادی ہوں، کافین کے ترک کرنے پر سستی کا ملبی، درد، پٹھوں کی کھچاوت اور سردرد جیسے عوارض سے دوچار ہوتے ہیں۔

کافین کو یہاں بیان کیوں کیا گیا؟

کیونکہ کافین کا کولیسٹرول سے تعلق ہے، آئیں اسے ملاحظہ فرمائیں۔

سائنسدانوں اور معالجوں نے کافین اور کولیسٹرول کے تعلق بارے میں بہت سی تحقیقات کی ہیں۔ کہ کافین کے عادی افراد کے مقابلہ میں دوسرے افراد کو کولیسٹرول کی زیادتی، دل کی شریانوں کی

تنگی اور دل کے عوارض میں کم مبتلا ہوتے ہیں۔

Johns Hopkins جو زباؤں کا پکن میڈیکل سکول کی تحقیقات کے مطابق ایک دن میں پانچ یا اس سے زیادہ کافی کے کپ پینے والے افراد کو عام لوگوں کی نسبت دو گنا سے تین گنا زیادہ دل کی بیماریوں کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔ اسی طرح چائے اور کافی پینے والے دیگر افراد نہ پینے والوں کے مقابلہ میں دل کی بیماریوں میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔

اسی طرح کیلیفورنیا میں ہونے والی حالیہ ریسرچ سے یہ بات بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ جو لوگ ایک دن میں چار کپ کافی پیتے ہیں اور کئی سالوں تک جاری رکھتے ہیں، ان میں نہ پینے والوں کے مقابلہ میں دل کے دورہ کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔

سٹنفورڈ یونیورسٹی Stanford University کی تحقیقات کے مطابق، ایسے درمیانہ عمر کے افراد جو تین یا اس سے زیادہ کپ کافی روزانہ پیتے ہوں، اپنی عمر کے عام افراد کے مقابلہ میں ہائی کولیسٹرول سے زیادہ دوچار ہوتے ہیں۔ مارچ 1990 میں برٹش میڈیکل جرنل British Medical Journal میں چھپنے والی رپورٹ کے مطابق بہت زیادہ مقدار میں کافی پینے والوں اور دل کی بیماریوں کے باعث مرنے والوں میں گہرا تعلق بتایا گیا۔

1939ء اور 1966ء خواتین پر یہ تحقیق کی گئی۔ جب تحقیق شروع کی گئی تو کوئی بھی فرد دل کی کسی بیماری میں مبتلا نہ تھا۔

بلڈ کولیسٹرول لیول نوٹ کرنے سے پتہ چلا کہ ایسے افراد جو کافی پیتے تھے، ان کا بلڈ کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا تھا۔ ایسے افراد جو دن میں ایک کپ کافی پیتے تھے ان کا بلڈ کولیسٹرول لیول 223 ملی گرام اور جو تین کپ کافی روزانہ پیتے تھے، ان کا بلڈ کولیسٹرول لیول 237 ملی گرام تھا اور ایسے افراد جو نو یا اس سے زیادہ کپ کافی روزانہ پیتے تھے، ان کا بلڈ کولیسٹرول لیول 253 ملی گرام تک تھا۔

اسی طرح دل کی بیماریوں کے سبب اموات میں ایسے افراد کی بہت بڑی تعداد تھی جو زیادہ کافی پیتے تھے اور ان کی اموات دل کی شریانوں کی بیماریوں کے باعث واقع ہوئیں۔

کافین ایک ایسا کیمیکل ہے جو چائے اور کافی دونوں میں موجود ہے۔ جو دماغ اور جسم کو متحرک کرنے کا کام کرتا ہے۔ لیکن کافی کی نسبت چائے میں کافین کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس لئے چائے کو کافی سے محفوظ خیال کیا جاتا ہے۔

کافی سے خاص عمل کے ذریعہ کافین کی مقدار کو کم کیا جاتا ہے۔ اس لئے دنیا کے اکثر حصوں

میں دونوں طرح کی کافی مہیا اور مستعمل ہے۔

جو کم کافین والی کافی پسند کرتے ہیں کم کافین والی اور جو زیادہ کافین پسند کرے ہیں وہ زیادہ

کافین والی کافی کا استعمال کرتے ہیں۔

کافین کم کی ہوئی ”کافی“ جسم پر کم نقصانات ظاہر کرتی ہے، البتہ زیادہ عرصہ تک استعمال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک عام کافی والے کا بلڈ کولیسٹرول لیول کافین کم کی ہوئی کافی پینے والے کے مقابلہ میں کم ہوتا ہے۔

سٹن فورڈ لائی پیڈ ریسرچ کلینک پر کی جانے والی ڈاکٹر سپر کو Superko صاحب کی رپورٹ کے مطابق۔ درمیانہ عمر کے 188 افراد جو کافی پیتے تھے جب ان پر تحقیقات کی گئیں۔ پہلے دو ماہ ان افراد کو کافی کے تین سے چھ کپ روزانہ دیے گئے، دو ماہ کے بعد ان کو کافی سے کافین کم کی ہوئی کافی پینے کو اسی مقدار میں دی گئی تو دونوں طرح کی کافی پینے کے دوران ان کا بلڈ کولیسٹرول لیول جانچا گیا، جس سے یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ کافی پینے والوں کی نسبت وہ افراد جن کو ڈی کافینیڈ (Decaffeinated) کافی دی گئی ان کا LDL کولیسٹرول لیول سات فی صد تک زیادہ تھا۔

یہ بات بھی مسلمہ حقیقت ہے کہ کافین بلڈ پریشر کو بڑھاتی ہے۔ کافین اور سٹریس کے بلڈ پریشر پر اثر انداز یہ پہلوؤں پر بہت سی تحقیقات ہو چکی ہیں۔

جن میں سے ایک ریسرچ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔

26 مرد جو کافی پیتے تھے ان کا انتخاب کیا گیا۔ ان کو 125 ملی گرام سے 250 ملی گرام تک کافین کھلائی گئی۔ اسی طرح ایسے افراد جو کافی نہیں پیتے تھے ان کو بھی کافین کی اتنی ہی مقدار کھلائی گئی تو معائنہ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ جو افراد کافی پیتے تھے ان کا بلڈ پریشر کافی نہ پینے والوں کے مقابلہ میں 5 سے 7 درجہ زیادہ تھا۔

ایک کپ کافی پینے کے 45 منٹ بعد اگر بلڈ پریشر کو چیک کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کافی پینے سے پہلے والی ریڈنگ سے 10 سے 12 mm زیادہ ہو گیا ہے۔ اور ایسے افراد جو روزانہ 4 سے 6 کپ کافی پیتے ہوں۔ ان کا بلڈ پریشر تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور گھٹنوں تک یہی حالت رہتی ہے جس کے باعث ان کے دل، دماغ، دل کی شریانوں پر بہت ہی بڑے اثرات پڑتے ہیں۔ بلڈ پریشر بڑھانے کے ساتھ ساتھ چائے اور کافی کا زیادہ استعمال کرنے والے اس میں موجود کافین کے باعث نبض کی بے قاعدگی، دل کی دھڑکن اور دل کی ضربات میں بے قاعدگی سے دوچار ہوتے ہیں۔

کئی افراد کا فین سے زیادہ حساس ہوتے ہیں اور کئی کم۔ کم حساسیت والے افراد کا فین کی زیادہ مقدار سے اوپر بیان کردہ علامات سے دوچار ہوتے ہیں جب کہ زیادہ حساس افراد بہت کم مقدار کا فین سے ہی متاثر ہو جاتے ہیں۔ تمام تشنگو کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ چائے اور کافی کے زیادہ استعمال کے باعث اس میں کا فین کی موجودگی دل کی شریانوں کی بیماریوں کا باعث بنتی ہے۔

یہ دل کی بیماری کا فین کے کولیسٹرول لیول میں اضافہ کرنا اور بلڈ پریشر بڑھانے سے پیدا ہوتی ہیں۔ تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک آدھا کپ چائے اور کافی کا زیادہ نقصان دہ نہیں ہوتا۔ جب کہ چائے اور کافی کا زیادہ استعمال کسی صورت بھی خطرہ سے خالی نہیں ہوتا۔

ذہنی دباؤ سے یعنی سٹرلپس سے بھی بلڈ پریشر میں اضافہ ہوتا ہے اور دل اور دل کی شریانوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ذہنی مشقت، جسمانی مشقت سے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، لیکن ایسی ذہنی مشقت جس میں مسلسل ذہن پر بوجھ یا دباؤ پڑا رہے نہایت ہی خطرناک ہوتی ہے، اس سے نہ تو کوئی کام ٹھیک طور پر انجام دیا جاسکتا ہے اور نہ کسی کام کو بروقت مکمل کیا جاسکتا ہے۔ اور ایسی کیفیات اکثر جلد باز طبیعت والے افراد میں دیکھنے میں آتی ہیں۔

وہ ہر وقت خفا رہتے ہیں۔ کھیل کے وقت کام، کام کے وقت آرام اور آرام کے وقت مصروفیت ان کا معمول بن جاتا ہے کیونکہ ان کو جلد بازی کے نقصانات معلوم نہیں ہوتے، وہ ایک ہی وقت میں انتہائی قلیل مدت میں بہت سے کاموں کو مکمل کرنے کے خواہاں ہوتے ہیں مگر نہ خدا ہی ملانے وصال صنم والی مثال کی طرح ان کا کوئی کام وقت پر مکمل نہیں ہوتا۔

ایسی ذہنی صورت حال میں بلڈ پریشر اور بلڈ کولیسٹرول میں اضافہ ہو کر دل و دماغ کی شریانوں کو متاثر کرتا ہے۔ اور ایسے افراد کو روزمری ہارٹ ڈیزیز میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔ ذہنی یکسوئی ان کو میسر نہیں ہوتی، ابھی اپنے ہی ایک کام کو کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی ویسے ہی پڑا دوسرا کام چھیڑ لیا جاتا ہے۔ ان تمام ذہنی کیفیات کا حل موجود ہے۔

ان تمام کیفیات کے حل کے لئے مناسب ہومیوپیتھی علاج بھی اسی کتاب میں بیان کیا جائے گا۔

یعنی سٹرلپس، بلڈ کولیسٹرول، بلڈ پریشر، ذہنی ابتری ان تمام کے حل کے لئے ہومیوپیتھی اور طب کی ادویات کا بیان کیا جائے گا۔

لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول کی زیادتی، سٹرلپس، سگریٹ نوشی،

شراب نوشی اور جتنی بھی دیگر وجوہات جو کورونری ہارٹ ڈیزیز کا باعث بنتی ہیں اور ان کو اس کتاب میں بیان کیا جائے گا۔

اور ساتھ ہی مناسب جگہ پر ان کی روک تھام اور علاج کے لئے ہومیوپیتھی اور طب کی ادویات بھی بیان کی جائیں گی۔ تاکہ میڈیکل کے فیلڈ میں داخل ہونے والے نئے افراد وہ ہومیوپیتھ ہوں یا حکیم صاحبان اس کتاب سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔

اور اپنے طبی شعبہ میں مسلسل محنت اور لگن سے دکھی انسانیت کی خدمت کر کے نہ صرف حلال رزق کمائیں بلکہ معاشرہ میں اعلیٰ مقام حاصل کریں۔

دل کی شریانوں کی بیماریوں کے سبب میں سے ایک بڑا سبب سگریٹ نوشی ہے حالانکہ جب یہ سطور لکھی جا رہی ہیں۔ حکومتی سطح پر پبلک مقامات، دفاتر، سیرگاہوں، بسوں اور دیگر عوامی تقریبات میں سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کر دی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے لئے سزائیں بھی مقرر کی ہیں۔ اس کے باوجود کھلے عام سگریٹ نوشی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ سگریٹ نوشی کرنے والے افراد سر عام سگریٹ نوشی کو اپنا سٹینڈرڈ خیال کرتے ہیں۔

اکیلا قانون کیا کرے۔ خود آگنی و شعور سے اس بد عادت پر قابو پایا جاسکتا ہے لیکن اس کے باوجود کہ سگریٹ نوشی پر پابندی نہیں صرف پبلک مقامات پر سگریٹ نوشی کرنے والوں پر پابندی ہے۔ پھر بھی لوگ اسے معیار زندگی سمجھتے ہوئے خلاف ورزی کرتے ہیں۔

تمباکونوشی کے نقصانات

(The Perils of Smoking)

بہت سے دل کے امراض میں جتنا افراد کی تشخیص کرنے کے دوران یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی اس بیماری کا باعث کثرتِ سگریٹ نوشی ہے۔ اس عنوان پر بہت سی تحقیقات ہو چکی ہیں کہ سگریٹ نوشی دل کے امراض کی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے۔

انگلینڈ کے معروف تحقیق دان ڈول اینڈ ہل Dolland Hill نے کئی سال پہلے ایسے معالجوں پر تحقیقات کیں جن کی عمریں 35 سے 45 سال کے درمیان تھیں اور وہ تمباکونوشی کے عادی تھے۔ تو دورانِ تحقیق یہ بات عیاں ہوئی کہ ایسے معالج جو تمباکونوشی کرتے ہیں انہیں تمباکونوشی نہ کرنے والے معالجین کی نسبت چار سے پانچ گنا زیادہ دل کے عوارض سے نبرد آزما ہونا پڑتا ہے۔ تمباکونوشی کے مختلف طریقے ہیں، پرانا طریقہ حقہ ہے۔ اسی طرح سگریٹ، گارو وغیرہ کے ذریعہ بھی تمباکونوشی کی جاتی ہے۔ تمباکونوشی خواہ کسی طریقہ سے بھی کی جائے، اس کے اثرات بد ضرور پیدا ہوتے ہیں۔

البتہ مختلف افراد پر اس کے اثرات بد کی مختلف نوعیتیں اور مدت ہوا کرتی ہے۔ کئی افراد بہت کم عرصہ میں اس کے بھیاںک اثرات کا شکار ہو کر لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اور کچھ کئی سالوں بعد بھی اس کے اثرات سے کم متاثر ہوتے ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ تمباکونوشی کے مضر اثرات ضرور رنگ دکھاتے ہیں کسی پر کم، کسی پر زیادہ اور کسی پر بہت زیادہ۔

لیکن مدتِ اثر مختلف ہوتی ہے ایسے افراد جو سگریٹ نوشی ترک کر دیں تو دو سال کی مدت میں ان کا دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خطرہ کافی حد تک اور پانچ سال میں پچاس فی صد تک کم ہو جاتا ہے۔ تمباکونوشی سے زہریلا میسرمل جو کینسر پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ٹریکیا Trachea اور برونکائی Bronchi کی انتہائی اندرونی تہ اپنی تھیلیہ کم کو آہستہ آہستہ تباہ کرتا رہتا ہے۔ اس طرح آہستہ آہستہ پھیپھڑوں کی بافتیں تباہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وقتِ تنفس پیدا ہو جاتی ہے۔ پھیپھڑوں کی سانس لینے کی گنجائش کم ہوتی جاتی ہے۔

سانس چھوٹا چھوٹا آتا ہے۔ سانس کے راستہ کے اعضاء میں پیدا شدہ ویکاز اور جھلس کے پرانا ہونے کے ساتھ ساتھ، کھانسی پیدا ہو جاتی ہے جو مرض کا نتیجہ ہوتی ہے۔ بلغم خارج ہوتی ہے اور سانس کے کئی عوارضات آگھیرتے ہیں۔ یہ سارا کام تمباکو میں موجود ہر پیلے مادے نیکوٹین کے باعث ہوتا ہے۔ نیکوٹین خون کی شریانوں کو تنگ کرتا ہے اور خون کے لوتھڑے پیدا کرتا ہے۔

یہاں تک کہ یہ خون کے پلیٹ لٹس سٹیز Platelets cells کو تباہ کر دیتا ہے جو کہ خون کا خاص جزو ہیں۔

یہی ٹوٹے پھوٹے پلیٹ لٹس خون میں لوتھڑا بنانے کا کام سرانجام دیتے ہیں۔ یہ لوتھڑے دل کی شریانوں میں تنگی اور رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کا خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اور خون یمنے میں جلدی کرتا ہے یعنی ان کا clotting وقت بہت کم ہوتا ہے۔

نیکوٹین کے باعث خون میں پائے جانے والے فائبرینوجن Fibrinogen زیادہ متحرک ہو کر جو کہ خون کی ایک پروٹین سے خون کو جمانے کا کام کرتے ہیں۔

تمباکو نوشی کرنے والوں میں معائنہ خون سے یہ بات بالکل عیاں ہو جاتی ہے کہ ان میں بلڈ پروٹین فائبرینوجن بہت حد تک بڑھ جاتی ہے۔ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کے خون میں ایڈرینالین اور نار ایڈرینالین ہارمونز کی مقدار بڑھ جاتی ہے جو ہائی بلڈ پریشر، دل کے تیز دھڑکنے اور دل کو زیادہ مقدار آکسیجن کی طلب کا باعث بنتی ہے۔

اس کے علاوہ مریض ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ اگرچہ ذہنی دباؤ پر قابو پا بھی لیا جائے پھر بھی دل کے دورہ کا خطرہ اپنی جگہ موجود رہتا ہے۔ لیکن اگر ذہنی دباؤ پر قابو نہ پایا جاسکے تو مریض میں سوچن، بے چینی، نمایاں طور پر دیکھنے میں آتی ہیں۔ دل کے عضلات زودحسی کے باعث دل کی حرکات کو بے قاعدہ بنا دیتے ہیں۔

حقیقت میں جب کوئی شخص دل کے دورہ کا شکار ہوتا ہے تو دل کی بے قاعدہ حرکات کے سبب اور بہت زیادہ مقدار میں Catecholamines کیلئے کولاماگنیز کے پیدا ہو جانے سے اچانک دل کا دورہ پڑ کر اکثر جان لیوا ثابت ہوتا ہے۔

تمباکو نوشی کرنے والے افراد کے خون میں کاربن مونو آکسائیڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے، اور دل کی شریانوں کی تنگی واقع ہو جاتی ہے لیکن دل کو اپنے کام سرانجام دینے کے لئے جتنی آکسیجن کی مقدار درکار ہوتی ہے، وہ پورا نہیں ہوتی بلکہ الٹا آکسیجن کی بجائے خون کی پروٹین ہیموگلوبن کاربن مونو

آکسائیڈ سے لبریز ہو جاتی ہے جو جسم اور دل دونوں کے لئے خطرناک حالت ہوتی ہے۔

دل کو آکسیجن کے نہ پہنچنے سے سانس میں تنگی، ہونٹوں کا نیلا پن اور دل کی حرکات کی بے قاعدگی نوٹ کی جاسکتی ہے۔

ایسے میں دل ہی نہیں تمام جسم کے خلیات مناسب مقدار میں خون اور آکسیجن کی سپلائی سے محروم ہو کر متاثر ہوتے ہیں۔ خاص کر دل کی حرکات باقاعدہ اور مناسب وقفہ میں واقع نہیں ہوتی۔

تمباکو نوشی کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھنے والوں پر ظاہر ہونے والے اثرات بد اگر آپ تمباکو نوشی نہیں کرتے لیکن تمباکو نوشی کرنے والے افراد کے ساتھ بیٹھتے ہوں تو ان کی تمباکو نوشی سے پھیلائے ہوئے دھواں سے آپ ضرور مضر اثرات کے حامل اجزاء اپنے سانس کے ذریعہ اندر لے جاتے ہیں۔

تمباکو نوشی کے مضر اثرات پر دنیا بھر میں تحقیقات ہو چکی ہیں۔ ڈاکٹر این برگ (Dr. Anne Berg) صاحب کی ریسرچ کے مطابق جن بچوں کے باپ تمباکو نوشی جیسی بد عادت میں مبتلا ہوں، ان میں دماغ اور خون کے کینسر کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔

ڈاکٹر این برگ صاحب کے مطابق تمباکو نوشی کے اثرات بد باپ کے سپرم تک پہنچ کر اس کو بھی متاثر کر دیتے ہیں تبھی اس کی اولاد میں خون اور دماغ کے کینسر کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔

تمباکو نوشی اور زیادتی کولیسٹرول

تمباکو نوشی اور بائی بلڈ پریشر کولیسٹرول میں بڑا گہرا رشتہ ہے، کیونکہ تمباکو نوشی کرنے والے اور بائی بلڈ کولیسٹرول والے دونوں طرح کے افراد کو دل کی بیماریوں کا خطرہ یکساں لاحق ہوتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو زیادہ مثالیں پیش نہیں کروں گا۔ صرف ایک واضح اور اہم تحقیق پیش خدمت ہے۔

جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن کی 19 دسمبر 1990 کی شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق جن کی عمریں 15 سے 24 سال کے درمیان تھیں۔

تمباکو نوشی کرنے والے 390 مردوں کا بعد از مرگ مائیکروسکوپ کے ذریعہ شریانی معائنہ کرنے سے پتہ چلا کہ ان کی شریانیوں کولیسٹرول سے متاثرہ تھیں اور تمباکو نوشی کے باعث شریانیوں کی

بیماری Atherosclerosis کا شکار ہو کر موت کے منہ میں پہنچے تھے۔

تمباکو نوشی اور ہائی بلڈ کولیسٹرول دونوں مل کر شریانوں کی اندرونی سطح کو تباہ کرتے ہیں، ان میں تنگی، جھٹی اور پافٹوں کی تباہی پھیلاتے ہیں۔ مسلسل تمباکو نوشی سے شریانوں کی دیواریں توڑ پھوڑ کا شکار ہو جاتی ہیں اور ساتھ ہائی بلڈ کولیسٹرول بھی شامل ہو جائے۔ تو شریانوں میں جمع ہو کر انہیں مزید تنگی سے دوچار کر کے ہائی بلڈ پریشر پیدا کرتا ہے۔

سیدھی سی بات ہے کہ اگر ایک فرد ہائی بلڈ کولیسٹرول سے نبرد آزما ہے تو اسے 8 سے 10 سال میں دل کا دورہ پڑ سکتا ہے، لیکن ایک دوسرا فرد جو ہائی بلڈ کولیسٹرول میں مبتلا ہے اور ساتھ ساتھ تمباکو نوشی بھی کرتا ہے تو اس کی یہ مدت کم ہو کر 4 سے 5 سال رہ جاتی ہے، اس بات سے آپ تمباکو نوشی اور ہائی بلڈ کولیسٹرول کے اکٹھے ہو جانے کے مضمرات سے بخوبی آگاہ ہو گئے ہوں گے۔

بس میرا تمباکو نوشوں اور ہائی بلڈ کولیسٹرول والے افراد کو پیغام مسرت ہے کہ ان دونوں سے ہوش مندی، مستقل مزاجی اور مناسب ہومیو پیتھی اور طبی علاج سے چھٹکارا ممکن ہے۔

موٹاپا (Obesity)

موٹاپا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں موٹاپا تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کے بعد ازاں اثرات بہت خطرناک ہیں۔

امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک کو بھی اس سے کافی پریشانی لاحق ہے، کیونکہ وہاں پر ہر تین افراد میں سے ایک کو موٹاپا لاحق ہے خاص کر موٹاپا ہائی کلاس اور درمیانہ کلاس کے لوگوں کو زیادہ پسند فرماتا ہے۔ کیونکہ ان گھرانوں کے افراد اچھا کھاتے پیتے ہیں مگر محنت اور مشقت کی قرب نہیں جاتے، جس کے نتیجے میں جسم میں فالٹو چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے۔

عام طور پر موٹاپا کے باعث، شوگر، ہائی بلڈ کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر جیسے عوارضات زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور یہ تینوں بیماریاں دل کے دورہ کا راستہ ہموار کرتی ہیں۔ ایسے افراد جو موٹاپا کا شکار ہوں اگرچہ وہ ہائی بلڈ کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر نہ بھی رکھتے ہوں تب بھی انہیں دل کی شریانوں کی بیماریوں کا زیادہ خطرہ رہتا ہے۔

لیکن اکثر موٹاپا والے افراد ہائی بلڈ کولیسٹرول، ہائی لیول آف ٹرائی گلیسرائیڈ اور ہائی LDL یا Bad Cholesterol رکھتے ہیں۔

بہت سے بڑھے ہوئے وزن والے افراد میں HDL یا گڈ کولیسٹرول لیول کم سطح پر ہوتا ہے۔

موٹاپا یا وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا بہت زیادہ مقدار میں چربی کی غذاؤں اور حرارے والی غذاؤں کے استعمال کے بعد ورزش نہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔

کہ انہیں اتنی زیادہ خوراک کی ضرورت نہیں ہوتی جس قدر وہ محنت مشقت کرتے ہیں زائد چربی بلڈ کولیسٹرول کی صورت میں جمع ہوتی رہتی ہے، اسی طرح جزو بدن بن کر جسم کو موٹا بنا دیتی ہے۔ موٹاپا کا شکار اکثر افراد ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایسے ہائی بلڈ پریشر مریضوں کو اپنا وزن گھٹانے کی ضرورت ہے اور صرف از صرف مناسب معتدل خوراک اور ورزش سے ایسا ممکن ہے۔ اسی طرح موٹے افراد اگر اپنا وزن کم کر لیں تو ہائی بلڈ کولیسٹرول سے بھی نجات مل سکتی ہے۔

یہ بات میرے اپنے کلینک کی مشاہدہ میں بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ ایسے افراد جو زیادہ وزن کے حامل ہوں، اپنے ہائی بلڈ پریشر کو اور ہائی بلڈ کولیسٹرول کو کم حراروں والی غذا اور مناسب

باقاعدہ جسمانی ورزش سے کم کر لیتے ہیں، انہیں کسی دوا کی ضرورت سوائے شروع شروع میں پیشانی نہیں آتے، بس مناسب یا قاعدہ ورزش، اور کم خوراک کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ زیادہ وزن والے موٹے افراد کو اگر دل کا دورہ پڑے اور ان کے مقابلہ میں ایک عام نارمل وزن والے افراد بارت ایک سے دو چار ہوں تو دونوں دہش سے زیادہ وزن والے موٹے فرد کو موت واقع ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے یعنی جتنا زیادہ وزن نارمل سے زیادہ ہوگا، اتنا ہی دل کا دورہ پر از خطر ہوگا۔ کیونکہ موٹے افراد میں خون میں تو خمر سے زیادہ سے زیادہ بننے کا رجحان ہوتا ہے، یہ تو خمر سے پورے جسم میں پھیل جاتے ہیں مثلاً دل، دماغ اور پیچھڑوں میں جدید تحقیقات سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے۔ دوسرے عوامل کے علاوہ آرام دہ زندگی گزارنا، سہل پسند ہونا اور مناسب ورزش نہ کرنا۔

CHD کو روزمرہ بارت ڈیزیز کا سبب بنتا ہے۔

ایسی بیماریاں جو کولیسٹرول لیول میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں

میں نے بلڈ کولیسٹرول لیول کی زیادتی کی بہت سی وجوہات بیان کی ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ میں یہاں ضروری خیال کرتا ہوں کہ ان بیماریوں کا بھی ذکر کیا جائے جو ہائی بلڈ کولیسٹرول کا باعث بنتی ہیں۔

اور آگے چل کر CHD کو روزمرہ بارت ڈیزیز کی راہ ہموار کرتی ہیں، ویسے تو بہت سی بیماریاں ہیں۔ لیکن چند خاص اور زیادہ پائی جانے والی بیماریوں کا ذکر کرنا ہی مناسب ہے۔ جن کی بنا پر دل کی شریانوں کی بیماریوں میں جتنا ہو کر دل کا دورہ پڑنے سے موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔

مگر عام طور پر ان کے متعلق مریض یہ خیال نہیں کرتا کہ اس کی بیماری آگے چل کر کتنی خطرناک صورت حال سے دوچار کر دے گی اور اس کی زندگی کا چراغ گل کر دے گی، اگر اسے ان بیماریوں کی ہولناکیوں کا علم ہو تو وہ ان کے مناسب علاج پر ضرور توجہ دے۔

شوگر (Diabetes)

اس سلسلہ میں تو 76 سال پہلے کی گئی تحقیق آج بھی اپنی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے جو نامی گرامی ماہر شوگر جس کا نام دنیا بھر میں میڈیکل سے وابستہ افراد جانتے ہیں۔ Joslin صاحب نے لکھا ہے کہ میں بالکل پوری طرح یقین رکھتا ہوں میری اتنی پختہ یقینی کا سبب میری شوگر پر کی جانے والی تحقیق ہے کہ جسم میں چربی کا بہت زیادہ جمع ہو جاتا جسے مونیا بھی کہا جاتا ہے اور خوراک میں بہت زیادہ چربی

کا شامل ہونا شوگر کو جنم دیتا ہے اور پھر شوگر والے مریض کو چکنائی سے بھرپور غذا کا استعمال ابتدا میں ہے ہوشی اور پھر شریانوں کی سختی لاتا ہے۔

بد قسمتی سے 76 سال پہلے سے معلوم حقائق کی روشنی میں آج تک میڈیکل کا شعبہ پوری طرح سے شوگر اور کولیسٹرول اور چربی سے بھرپور غذا خاص کر شوگر والے مریضوں کو ان سے پوری طرح روک نہیں سکا۔

شوگر والے مریض کو انسولین کی گولیاں یا ٹیکے لگاتے جاتے ہیں۔ جو اتنی دیر تک زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوتے جتنی دیر تک مریض پر ہیزی غذا استعمال نہیں کرتا۔

چربی، سارچ اور شوگر سے بھرپور غذا علاج میں بہت بڑی رکاوٹ بنی نہیں بلکہ بہت سی پیچیدگیاں بھی پیدا کر دیتی ہے۔ اگر مرض پر تھوڑا بہت ہی کنٹرول کیا جائے تو نتیجتاً جسم لاغر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تھکاوٹ عام ہو جاتی ہے جس کو مریض نمایاں طور پر بیان کرتا ہے۔ شوگر کی خون میں زیادتی کے سبب پیشاب بار بار آتا ہے۔ رات اور دن باری نہیں بندھتی۔ مریض کا وزن کم ہوتا جاتا ہے لیکن بھوک بڑھتی جاتی ہے۔ ساتھ ساتھ پیاس بھی بہت زیادہ لگتی ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟

اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ جسم کی بافتیں گلوکوز کو استعمال میں لانے کے قابل نہیں رہتی اور نہ ہی مریض کو مناسب حرارت مہیا ہوتی ہے۔

جب شوگر سے بھرپور خون گردوں سے گزرتا ہے، تو گردے خون سے اس شوگر کو دو بارہ قابل جذب بنانے سے قاصر رہتے ہیں۔

اس طرح جسم کو توانائی ملنے کی بجائے یہ توانائی گلوکوز کی زیادتی کی شکل میں پیشاب کے ذریعہ خارج ہو جاتی ہے۔

شوگر کی پیچیدگیاں (Complications of Diabetes)

شوگر والے مریض کو درج ذیل اقسام کی پیچیدگیاں بھی آگھیرتی ہیں۔

(1) انجائنا پیکٹورس

دل کی شریانوں میں تنگی کے باعث دل کا دورہ ہو سکتا ہے۔

(2) ہارٹ ایٹیک

دل کی شریانوں میں رکاوٹ کے باعث دل کا دورہ ہو سکتا ہے۔

(3) پیری فیئرل واسکولر ڈیزیز (Peripheral Vascular Diseases)

اس کی نشانیوں میں معتبر نشانی چلتے وقت پاگوں میں درد کا ہونا ہے۔

اسے آرام کرانے سے سکون ملتا ہے، جب مریض سکون محسوس کرنے کے بعد خود کو چلنے کے

قابل سمجھتا ہے اور چلتا پھرتا ہے تو درد دوبارہ لوٹ آتا ہے۔

اس حالت میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

شوگر اور بلڈ کولیسٹرول پر قابو پانے سے اس درد سے نجات ممکن ہے ورنہ یہ حالت بڑھتی

رہتی ہے۔

(i) Nephropathy: نضر و پتھسی یعنی گردوں کا ٹھیل ہونا۔

(ii) Neuropathy: نیور و پتھسی اعصاب کا ناکارہ ہو جانا۔

(iii) Retinopathy: رٹینو و پتھسی: بصارت کا کمزور ہو جانا۔

شوگر میں مبتلا افراد بائی ٹرائی گلیسرائیڈز لیول رکھتے ہیں، جس کے باعث انہیں ہارٹ اٹیک

کا خطرہ لاحق رہتا ہے۔

اسی طرح ہائی کولیسٹرول لیول، ہائی لیول LDL یعنی Bad Cholesterol اور ٹرائی

گلیسرائیڈز اور HDL کی کمی جیسے Good Cholesterol کہا جاتا ہے، مل کر شوگر کے مریض کو دل

کی بیماریوں سے دوچار کرتے ہیں۔

اسی طرح موٹا پانچھی شوگر والے مریض کی پیچیدگیوں کو بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔

جدید تحقیقاتی مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر شوگر کے مریضوں کا علاج باقاعدہ نہ کیا جائے

اور انہیں پرہیزی غذا کی ترغیب نہ دلائی جائے، کیونکہ غذائی بے اعتدالیوں کے سبب ہائی بلڈ کولیسٹرول،

ہائی بلڈ پریشر اور موٹاپا شامل ہو کر شوگر کے مریض کو CHD کو روزمری ہارٹ ڈیزیز کی جانب لے جاتا

ہے۔

بہت سے شوگر کے مریض اور لواحقین بد قسمتی سے ایسی باتوں سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں،

اس بے خبری کے سبب مریض اور لواحقین بہت سی پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔

اگر شوگر کا مریض اپنی خوراک میں چربی اور کولیسٹرول کا زیادہ استعمال کرے گا تو بہت جلد

دل کی شریانوں کی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔

مختلف تحقیقاتی مواد کا مطالعہ کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شوگر والے مریضوں کو اپنی خوراک میں چکنائی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

شوگر والے مریض کے بلڈ کولیسٹرول لیول میں اضافہ سے گردے فیل ہو جاتے ہیں۔
ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول کا باعث کئی ایلو پیٹھک ادویات بھی ہوتی ہیں مثلاً Beta Blockers اور Thiazide وغیرہ شوگر کے مریض کے بلڈ کولیسٹرول لیول میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔

ہائی بلڈ پریشر

اگر بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو کنٹرول نہ کیا جائے تو آخر کار یہ کورونری ہارٹ ڈیزیز کا باعث بن سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک ایسا فرد جس کا سسٹولک پریشر 196mm ہو یا اس سے بڑھا ہوا ہو اور اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو ایسے آدمی کو ایک نارمل بلڈ پریشر رکھنے والے کی نسبت 5 گنا زیادہ ہارٹ اٹیک کا خدشہ ہوتا ہے۔

بہت سی بلڈ پریشر پر ہونے والی تحقیقات سے یہ بات بالکل عیاں ہوئی ہے کہ ہائی پریٹینشن کے مریضوں کے خون کا اگر معائنہ کیا جائے تو ہائی بلڈ کولیسٹرول کا پتہ چلتا ہے۔

اور ہائی پریٹینشن میں جتنا اکثر مریض تمباکو نوشی، شوگر اور موٹاپا میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔
پس مختصر یہ بات بالکل واضح ہے کہ ایسے افراد جو ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا ہوں اور شوگر کے مریض بھی ہوں، ان کو عام لوگوں کی نسبت اور ہائی بلڈ کولیسٹرول والے افراد کو عام لوگوں کی نسبت 4.2 گنا زیادہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہوتا ہے۔

اور ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لئے استعمال ہونے والی ادویات مثلاً Beta Blocker، Thiazide اور پیشاب آور ادویات آخر کار ہائی بلڈ کولیسٹرول کا باعث بنتی ہیں۔

ہائی بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول پاکستان اور ہندوستان میں 15 سے 25 فی صد تک ہو چکا ہے۔ اور ہائی بلڈ پریشر 20 سے 30 فی صد تک پھیل چکا ہے۔

دیگر بیماریاں

شوگر اور ہائی بلڈ پریشر کے علاوہ دیگر کئی بیماریاں بھی ہائی بلڈ کولیسٹرول کا سبب بنتی ہیں۔

تھائی رائیڈز کی خرابیاں

تھائی رائیڈ گھینڈ ایک رطوبت خارج کرتا ہے جس کی کمی بیشی جسم کے تمام اعضاء پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اس رطوبت کو تھائی روکسن Thyroxine کہتے ہیں۔ اسکی نارمل سے کم مقدار پیدا ہونے کی صورت میں جسم کا مینابولزم سست پڑ جاتا ہے۔ ایسی حالت کو ہائپو تھائی رائیڈزم Hypothyroidism کہتے ہیں۔

مریض کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دل، دماغ اور نظام انہضام اور بلڈ کولیسٹرول پر اثر پڑتا ہے۔ ہائپو تھائی رائیڈزم والے مریضوں میں بلڈ کولیسٹرول لیول 250 سے 350 ملی گرام تک بڑھ جاتا ہے۔

حالیہ ہونے والی جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ تھائی روکسن کی کمی کے باعث تھیشل ریسیپٹر آف باڈی جو LDL کو وصول کرتے ہیں سست پڑ جاتے ہیں جن کی بنا پر کولیسٹرول کی جسم میں بھر مار ہو جاتی ہے اور موٹاپا چھا جاتا ہے۔

اس طرح ہائی بلڈ کولیسٹرول اور موٹاپا دونوں مل کر کورونری ہارٹ ڈیزیز کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے افراد جن کا بلڈ کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہو اور وہ موٹاپا کا شکار ہوں، ساتھ ہائپو تھائی رائیڈزم بھی ہو تو انہیں دوسرے افراد کی نسبت جو صرف ہائی بلڈ کولیسٹرول اور موٹاپا کا شکار ہوں، دل کی شریانوں کی بیماریوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔

دوسری طرف اگر تھائی رائیڈ گھینڈ کی رطوبت تھائی روکسن زیادہ مقدار میں پیدا ہونے لگے جسے اصطلاح میں ہائپر تھائیرائیڈزم کہتے ہیں تو جسم کے مینابولک نظام میں تیزی آ جاتی ہے۔ جس سے بلڈ کولیسٹرول لیول میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ جب کافی دیر پہلے تھائی رائیڈ کے ٹیسٹ کی سہولتیں میسر نہ تھیں تو کولیسٹرول لیول کے اعتبار مل ہونے سے ہی تھائی رائیڈ گھینڈ کی کارکردگی میں فرق تصور کیا جاتا تھا۔

گردوں کی بیماریاں

50 سے زیادہ گردوں کی بیماریوں کی طبی علامات کے مجموعہ کو نیر وٹک سائینڈرم کا نام دیا جاتا ہے۔ Nephrotic Syndrome ایسے افراد جو Nephrotic Syndrome کا شکار ہوں، ان کو پیشاب میں کافی مقدار پر وٹین خارج ہوتی ہے، جب کہ ایک عام آدمی جو نارمل ہو 100 ملی گرام

سے بھی کم 24 گھنٹوں میں پروٹین پیشاب کے راستہ خارج کرتا ہے۔

Nephrotic Syndrome میں مبتلا مریض ایک دن میں 5 سے 20 گرام پروٹین پیشاب کے راستہ خارج کرتا ہے۔ گردوں کی خرابی کے باعث اتنی مقدار میں پروٹین کا پیشاب کے ذریعہ خارج ہونا خون میں پروٹین کی کمی کا باعث بنتا ہے، تقریباً ایسے تمام مریضوں کو سوجن، پاؤں اور ٹانگوں پر استسقاءی ورم ہو جاتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر بھی عام پایا جاتا ہے۔ ستر فی صد سے زیادہ مریضوں میں ہائی بلڈ کولیسٹرول پایا جاتا ہے۔ اسی طرح LDL بڑھا ہوا اور ٹرائی گلیسرائیڈ بھی بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور مریض کا جگر بہت زیادہ مقدار میں کولیسٹرول اور ٹرائی گلیسرائیڈ پیدا کرنے لگتا ہے۔ ایسی حالت میں ان مریضوں کو دل کی شریانوں کی بیماریوں CHD کا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

ملاوہ ازیں ٹانگوں پر سوجن ہونے کے باعث زیادہ سے زیادہ پیشاب آور ادویات کا استعمال بھی بلڈ کولیسٹرول لیول کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔

لہلہ کی بیماریاں اور ہائی بلڈ کولیسٹرول

لہلہ جسم کا ایک بہت ہی اہم غدود ہے۔ اس کا بڑا کام انسولین پیدا کرنا ہے۔ یہی انسولین بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتی ہے۔

لہلہ کی سوزش کو Pancreatitis کہتے ہیں جو ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول کی وجوہات میں سے ایک ہے۔

چونکہ لہلہ کی سوزش مناسب علاج سے دس دن سے بھی کم مدت میں درست ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس سوزش سے بڑھا ہوا بلڈ کولیسٹرول لیول دل کی بیماریوں کا سبب نہیں بنتا۔ شوگر ہائی پریشر، تھائی رائیڈ گلیٹنڈ کی خرابیاں بلڈ کولیسٹرول لیول کو بڑھاتی ہیں۔

اس لئے ان بیماریوں پر قابو پانا ضروری ہوتا ہے ورنہ اسے زندگی سے ہاتھ دھونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

ایسی ادویات جو کولیسٹرول لیول کو بڑھاتی ہیں

ایسے افراد جو کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوں انہیں مناسب علاج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ علاج میں ادویاتی استعمال ایک لازمی امر ہے لیکن بہت سی ادویات کے مابعد استعمال برے اثرات ہوتے ہیں۔

ان کا زیادہ استعمال ایک مرض سے نجات دلاتے ہوئے، دوسری مرض میں مبتلا کر دیتا ہے اس لئے معالج کے لئے ادویاتی اثرات کا مکمل علم رکھنا ضروری ہوا کرتا ہے تاکہ کم از کم دوا کے استعمال سے زیادہ اچھے نتائج حاصل کرے نہ کہ ۱۰۰ یات کا اندھا دھند استعمال کیا جائے۔

یوں تو ایسی بہت ادویات میں جو بعد از استعمال اضافی علامات بھی پیدا کر دیتی ہیں۔

لیکن میں یہاں اس کتاب میں صرف پہلے سے بیان کی گئی امراض میں استعمال ہونے والی چند بڑی دواؤں کا ذکر کروں گا۔

پیشاب آور (Diuretics)

یہ ایسی ادویات ہیں جو بہت زیادہ بڑھے ہوئے بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہیں اور بہت زیادہ مقدار میں پیشاب لاتی ہیں۔

اس کے علاوہ پیشاب آور ادویات دل کے قیل ہونے میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔

ان کے استعمال سے بلڈ کولیسٹرول لیول میں اضافہ ہوتا ہے۔

پیشاب آور کے طور پر عام استعمال ہونے والی ادویات

کلوروتھائازائیڈ (Chlorthiazide)

ہائیڈروکلوروتھائازائیڈ (Hydrochlorthiazide) جس کا برانڈ نام Ebidrex ہے۔

کلوروتھالائیڈون (Chlorthalidone) برانڈ نام Hythalon

فروسامائیڈ (Fruesamide) عام نام Lasix

بیومیتینائیڈ (Bumetinide) برانڈ نام Bumet اور

اتھاکرائینک ایسڈ (Ethacrynic Acid) وغیرہ۔

یہ تمام ادویات ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول میں اضافہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔

اس لئے اگر بلڈ کولیسٹرول لیول بڑھا ہوا ہو تو اسے یہ ادویات سوچ سمجھ کر مناسب مقدار میں استعمال کروانا چاہیے۔ ان تمام ادویات کے مقابلہ میں ہومیوپیتھتی ادویات اور عام ویسکی ادویات جنہیں آگے چل کر ذکر کروں گا نہایت ہی کارگر اور مضر اثرات سے پاک ہوتی ہیں۔

وہ اضافی مشکلات پیدا کئے بغیر حقیقی شفاء سے ہمکنار کرتی ہیں۔

میں بنیادی طور پر ہومیوپزیشن ہوں لیکن میں ویسکی ادویات کا ذکر کیوں کر رہا ہوں اس لئے

کہ میرا ضمیر کہتا ہے حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے۔

اور ایسی ادویات خواہ ان کا تعلق ہومیوپیتھی سے ہو، خواہ یونانی طب سے دیکھی انسانیت کے دکھ کو کم کرنے اور اپنا پیشہ وارانہ فریضہ ادا کرنے کے لئے حقیقت کا اعتراف کیا جائے اور ان تمام سے بیمار یوں کے خاتمہ کے لئے بھرپور استفادہ کیا جائے اور نئے آنے والے افراد کو بھی بتایا جائے۔

تاکہ یہ عمل جاری و ساری رہے اور دیکھی انسانیت کی خدمت ہوتی رہے لیکن اسلامی طب کی ایسی ادویات جن کے خواص رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہیں۔ ان کا استعمال عام کیا جائے۔ میرے ذاتی تجربہ کی بات ہے کہ طبِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ کر رہا تھا کہ کشتِ شریں کے متعلق پڑھا اس کو رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گلے کی خرابی کے لئے استعمال کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ میں نے اس کے مطالعہ کے بعد اسے گلے کی مہلک نوعیت کے امراض میں بھی استعمال کیا مریض کو شفا ملی نصیب ہوئی۔

بیٹا بلاکراڈویات (Beta Blockers Medicine)

یہ سیشل ادویاتی گروپ 1970 کے عشرہ میں متعارف کروایا گیا اور آج لاکھوں افراد ہائی پریٹینشن کے لئے انہیں استعمال کر رہے ہیں۔ ہائی پریٹینشن، اجائزہ، یاد دل کی بے قاعدگیوں میں ان کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔

ان کے استعمال سے ہائی بلڈ کولیسٹرول سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ درج ذیل ادویات اس گروپ سے تعلق رکھتی ہیں۔

Propamole برانڈ نام (Inderal)

Metopropanolol برانڈ (Metolar)

Atenolol عام نام (lonol)

Lebetalol Timolol عام نام (Normadate) اور

Pindolol کو عام طور پر مارکیٹ میں Visken کے نام سے جانا جاتا ہے۔

ہائی پریٹینشن کیلئے استعمال ہونے والی خاص ادویات جو بلڈ کولیسٹرول لیول کو بڑھاتی ہیں

Captopri، Prazosin عام نام (Aceten) اور Methyldopa عام نام

Aldomet ہائی بلڈ پریشر کے لئے عام استعمال ہونے والی ادویات ہیں جو بلڈ کولیسٹرول لیول کو بڑھانے کا باعث بن سکتی ہیں۔

اس طرح ان دواؤں کے علاوہ ہائی بلڈ پریشر انجانا، اور دل کے قیل ہونے کی صورت میں استعمال کی جانے والی ادویات

(I) اینابولک سٹیرائڈ (Anabolic Steroids)

(II) اینڈروجنک ہارمون (Androgenic Hormones)

(III) کارٹیکو سٹیرائڈ (Cortico Steroids)

وہ گنٹھیا جوڑوں کے ورم اور کئی اقسام کی الرجی میں ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ان تمام ادویات کا سوچ سمجھ کر اور کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہی استعمال کر سکتا ہے اور انتہائی ضرورت کے تحت استعمال کی جاتی ہیں۔

میں بیان کر چکا ہوں کہ کون کون سے عوامل بلڈ کولیسٹرول لیول بڑھاتے ہیں یا بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ اور بلڈ کولیسٹرول لیول کا بڑھا ہوا رہتا آخر کار دل کی شریانوں کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے اور دل کی شریانوں کی بیماریوں CHD کے باعث دل کا دورہ پڑتا ہے۔

دل کا دورہ (Heart Attack)

اگرچہ دل کا دورہ یا کارڈیو تھرمبوس اچانک واقع ہوتا ہے لیکن یہ کارڈیو آرٹری ڈیزیز CAD کا ہی نتیجہ ہوتا ہے جو اپنا کام دکھانے میں کئی سال تک محرم رہتی ہیں۔

جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی جاتی ہے اس کے خون کی نالیوں کی پلم کم ہوتی جاتی ہے۔ اور کولیسٹرول اور چربی کا خون کی شریانوں میں جمع ہو جانا انہیں تنگ اور سخت بنا دیتا ہے۔ جس کے باعث ان سے خون کو گزرتے وقت کافی مزاحمت کا سامنا ہوتا ہے۔ جس کے باعث خون کا تیزی سے گزرنا محال ہو جاتا ہے اس لئے جب خون ان نالیوں سے گزرتا ہے تو اسے اپنا بہاؤ جاری رکھنے کے لئے بہت زیادہ مزاحمت پیش آتی ہے، اسی مزاحمت کے باعث خون کا دباؤ نالیوں پر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، دل کو اپنے کام کاج کے لئے جتنا خون درکار ہوتا ہے اور جتنی آکسیجن چاہیے ہوتی ہے وہ اسے نہیں پہنچتی، جس کی وجہ سے انجانا کا درد ہوتا ہے۔

سینے میں درد اس لئے اٹھتا ہے کہ دل کو مطلوبہ مقدار میں آکسیجن نہیں ملتی۔ سانس کی تنگی ہوتی

ہے اور بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ دل کی شریانوں کی مکمل رکاوٹ کے باعث خون کی مکمل سپلائی رک جاتی ہے اور ہارٹ ایٹیک واقع ہوتا ہے۔

ایتھروسکلیروسس (Atherosclerosis)

تمام شریانیں نرم اور لچکدار ہوتی ہیں۔ شریان تین خاص تہوں سے مرکب ہے۔ جن کو انگریزی میں Media, Intima اور Adventitia کہتے ہیں۔

(Intima) یہ سب سے اندرونی تہہ ہے اس کی سطح بالکل ہموار ہوتی ہے جس کی وجہ سے خون کا بہاؤ مسلسل یقینی ہوتا ہے۔

اگر اس میں چربی کولیسٹرول جمع ہوتا جائے تو اس کا راستہ آہستہ آہستہ تنگ ہو کر رکنا جاتا ہے۔ اس چربی اور کولیسٹرول کے جمع ہونے سے فیٹی ایسڈ بننے سے شریانوں میں ڈی جنریشن ہونے لگتی ہے۔ ایسی حالت کو Athrosclerosis کہتے ہیں۔ اگر دل کی شریانوں میں Atherosclerosis واقع ہو جائے تو دل کا دورہ پڑتا ہے۔

اگرچہ تیس سال کی عمر سے پہلے بہت کم ہارٹ ایٹیک ہوتا ہے۔ Atherosclerosis فوراً نہیں ہو جاتا اس کو مکمل ہونے میں کئی کئی سال گزر جاتے ہیں، شریانوں کی جب اندرونی تہہ Intima میں چربی اور کولیسٹرول جمع ہوتے جاتے ہیں تو نتیجتاً چربی کی لکیریں ہی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔

اور بد قسمتی سے بہت سے افراد میں ایسا 20 سال کی عمر میں ہو جاتا ہے۔ پھر ان چربی کی ساختوں کا سائز آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایسی حالت کو Fibrous Plaquer کہتے ہیں۔

پھر اس Fibrous Plaques کو بڑھتے بڑھتے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ جب یہ پھٹ جاتے ہیں تو اسے جریان خون ہوتا رہتا ہے۔ اس سے زخم، تھرمبوسس اور چوٹ کی مقدار بڑھتی رہتی ہے۔ شریانوں کی رکاوٹ بتدریج بڑھتی رہتی ہے۔ اسے کئی سال تک کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ یہ تمام عمل بتدریج آہستہ آہستہ چلتا ہے۔ اسے 10 سے 20 سال بھی لگ سکتے ہیں۔

جس قدر شریانوں میں چربی یا کولیسٹرول جمع ہوتا جاتا ہے۔ جیسے ہی خون کے بہاؤ میں رکاوٹ ہوتی جاتی ہے۔ لیکن بہت کم مقدار میں شریانوں کی رکاوٹ کے باعث خون کے بہاؤ میں کوئی فرق نہیں آتا۔

رکاوت زیادہ ہوتی جائے تو متاثر شخص کو درج ذیل علامات سے بیماری کا احساس ہوتا جاتا ہے۔ ورزش کرنے کے دوران دل کو آکسیجن اور زیادہ خون کی ضرورت ہوتی ہے لیکن شریانوں میں رکاوت کے باعث دل کو نہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پہنچتی ہے نہ خون۔ دل کی حرکات میں زبردست اضافہ ہو جاتا ہے۔

ایسے حالات میں مریض کو سینہ میں درد ہوتا ہے۔ سانس چھوٹا چھوٹا آتا ہے، اسے آنجنائٹ کا حملہ کہا جاتا ہے۔

تصویر کے ذریعہ شریانوں میں رکاوت کو واضح کیا جاسکتا ہے۔



2- سینے میں اور درمیان سینہ بھاری وزن محسوس ہوتا ہے۔

3- سینے کے اندرونی حصہ میں کھچاؤ محسوس ہوتا ہے۔

4- درد بائیں بازو تک پھیل جاتا ہے۔

5- درد بائیں جبڑے، بائیں کمر، گردن اور سینے کے نچلے حصہ تک پھیل جاتا ہے۔

6- سانس کا چھوٹا چھوٹا آنا اور تنگی انجانا میں عام ہوتی ہے۔

7- انجانا کا درد ایک سے پندرہ منٹ کے دورانیہ تک رہتی ہے۔

8- خاص علامات

انجانا کے درد کو آرام کرنے اور GTN یعنی Glyceryl Trinitrate، Tab زبان کے نیچے رکھنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں کہ انجانا والے تمام مریضوں کو مستقبل میں ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا ہے۔

اگر ایٹروسیکلیر وکس، بلڈ کولیٹسٹرول لیول کو کنٹرول کر لیا جائے تو انجانا کا درد سے نجات مل جاتی ہے۔ کئی مریضوں میں آہستہ آہستہ اس کی شدت میں کمی آ جاتی ہے بشرطیکہ اوپر بیان کردہ پر خطر عوامل کو کنٹرول کیا جائے۔

آپ کو ایک دلچسپ اور معلومات پر مبنی تحقیق کے متعلق بتانا چلوں۔

انگلینڈ میں 200 مریضوں پر کئی سالوں تک تحقیقات کی گئی جس کے نتیجہ میں درج ذیل معلومات حاصل ہوئیں۔

1- 25 فی صد مریضوں کو درد سے نجات مل گئی۔

2- 27 فی صد کو کبھی کبھار انجانا کا درد ہوتا جو GTN Tab سے کنٹرول کر لیا جاتا۔

3- 6 فی صد درد کی شدت کی وجہ سے اپنا حج ہو گئے۔

4- 45 فی صد مریض تحقیقات کے 25 سال کے بعد۔

دل کے دورہ یا دل کے فیل ہو جانے سے فوت ہوئے۔

CHD میں مبتلا مریضوں کے لئے ضروری نہیں کہ انہیں انجانا کا درد ہو۔ کچھ مریضوں کو

درد اور کچھ کو درد کے بغیر ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔

ہارٹ اٹیک کی عام علامات میں اچانک اور شدید درد سینہ، جس میں تنگی تنفس، دم گھٹنا، سینے کے درمیان میں بوجھ اور سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہونا، درد دبانے والی اور پھاڑنے والی جو مسلسل جاری

رہے۔ جو چند منٹ جاری رہے پھر رک جائے لیکن منٹوں بعد دوبارہ شروع ہو جائے۔

درد عام طور پر اکثر بائیں بازو میں پھیل جائے۔ درد جڑے، گردن اور دانتوں تک پھیل جائے۔ خاص کر بائیں جانب ہارٹ ایکٹک کا درد کمر تک بھی پھیل سکتا ہے۔

اگر ہارٹ ایکٹک کی درد کا انجائکٹا کی درد سے موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہارٹ ایکٹک کی درد عام طور پر شدید اور زیادہ دورانیہ کی ہوتی ہے۔

جب ہارٹ ایکٹک کنفرم ہو جائے تو 24 سے 48 گھنٹے انتہائی خطرناک ہوتے ہیں۔ اکثر ابتداء میں ہی دل کے نقصان زدہ حصہ سے بے قاعدہ حرکت کے سبب دل کی معطلی پر موت واقع ہو جاتی ہے۔

بغیر وارننگ ہارٹ ایکٹک یا (Silent Ischaemia)

اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ہارٹ ایکٹک کے دوران مریض کو سینہ کے درمیان میں بوجھ، درد اور ٹھنڈے پسینے آتے ہیں۔ سانس کی تنگی اور وقت ہوتی ہے اور مٹکی اور قے ہوتی ہے، لیکن حالیہ تازہ ترین تحقیقات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بغیر خاص علاماتی ظہور کے بھی ہارٹ ایکٹک ہو جاتا ہے۔ علامات مرض ظاہر نہیں ہوتیں جس سے معالج اور مریض دونوں دھوکے میں رہتے ہیں۔

اس کو میڈیکل اصطلاح میں Ischaemia, Silent, Myocardial کہتے ہیں۔ بعض اوقات علامات بالکل ظاہر ہی نہیں ہوتیں صرف ای۔ سی۔ جی معائنہ سے پتہ چلتا ہے کہ مریض کو ہارٹ ہوا تھا یا ابھی ہارٹ ایکٹک میں ہے۔

جدید تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 3 سے 10 فی صد 50 سال سے زیادہ عمر والے افراد اس Silent Ischaemia سے دوچار ہیں۔

ساتھ سال سے زیادہ عمر والے افراد میں سے دل کے دورہ کا شکار ہونے والے 50 فی صد مریض بغیر کسی درد کے ہارٹ ایکٹک کا شکار ہوتے ہیں۔

بڑی عمر والے اکثر افراد سینہ کے شدید درد کے سوائے، سانس کی تنگی، سانس کی دقت، تھکاوٹ بے رغبتی جیسی کم شدید علامات رکھتے ہیں۔ ان میں صرف ای۔ سی۔ جی اور خون کے مختلف معائنوں سے ہارٹ ایکٹک کی تشخیص ممکن ہوتی ہے۔

خاص کر Silent Myocardial Ischaemia شوگر والے مریضوں میں کافی زیادہ

دیکھنے میں آیا ہے۔

ہمارے پیارے وطن پاکستان میں دیگر کئی مسائل کی طرح صحت کا مسئلہ بھی بڑی شدت پکڑتا جا رہا ہے۔

حکومتی کوششوں کے باوجود ابھی تک صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم لوگوں کی کمی نہیں۔ حکومت ہومیوپیتھی اور یونانی طب سے سوتیلی ماں جیسا سلوک کر رہی ہے۔ اس کے باوجود ایلوپیتھک طریقہ علاج کی سہولت بھی بہت کم آبادی کو حاصل ہے۔

آپ نے اکثر سنا اور دیکھا ہوگا کہ فلاں شخص اچھا بھلا اپنے کام کاج سے واپس لوٹا یا دفتر پہنچا اور بیٹھے بیٹھے اس کا انتقال ہو گیا۔ ایسے واقعات روزانہ ہوتے رہتے ہیں۔ میڈیکل ایسے واقعات کی وجہ Silent Myocardial Ischemia ہوتی ہے۔

اس پر پوری دنیا میں بہت سی تحقیقات کی گئیں ہیں۔ آپ کی خدمت میں ان میں سے صرف ایک یہاں پیش کروں گا۔

صرف امریکہ میں 350,000 سے لے کر 400,000 افراد ہر سال اچانک بغیر کسی دل کی بیماری کی ہسٹری کے باوجود مر جاتے ہیں۔

صرف پوسٹ مارٹم رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں CHD کافی حد تک شدید ہو گئی تھی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دنیا بھر میں Silent Myocardial Ischaemia کس قدر پھیل رہا ہے۔

بعض اوقات اکثر بالغ افراد جو بڑے پرسکون زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ لیکن وہ ورزش اور محنت و مشقت کے عادی نہیں ہوتے، وہ سخت نوعیت کی ورزش شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان کی اکثریت ہارٹ اٹیک سے دوچار ہو جاتی ہے۔

ان کی اچانک موت واقع ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی اسے کیا ہو گیا اچھا خاصا کھانا پیتا صحت مند معلوم ہونے والا ایک دم مر گیا کیا وجہ ہو سکتی ہے۔

ایسے تمام افراد جن کی عمر 35 سال یا اس سے زیادہ ہو اور وہ سہل زندگی کے عادی ہوں انہیں کسی بھی قسم کی ورزش سے پہلے اپنے معالج سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے۔

سینے میں اٹھنے والی ہر درد ہارٹ اٹیک والی نہیں ہوتی

دل کے مقام پر اٹھنے والی تمام دردیں دل کے دورہ یا انجائنا کی ہی نہیں ہوتی۔ ایک مدہم یا تیز نوعیت کی دل کے ایریا میں درد کا پیدا ہونا یا بائیں جانب چھاتی میں واقع کئی دفعہ اعصابی خرابی کے باعث بھی ہوتا ہے۔ زیادہ محنت اور مشقت، تھکاوٹ، پیٹ کی خرابیوں، کھانے پینے کی بے اعتدالیوں اور معدہ کے السر کے باعث بھی دل کے قریب درد محسوس ہو سکتی ہے۔ پتے کی پتھریوں، لہلہ کی سوزش، حتیٰ کہ اینڈکس کی سوزش سے بھی بعض اوقات اٹھنے والی دردیں دل کے قریب محسوس ہوتی ہیں۔ لیکن چھاتی میں درد کی بروقت 100 فی صد تشخیص کے لئے E.C.G اور خون کے دیگر کئی ٹسٹوں سے مدد لی جاسکتی ہے۔

اگر کسی کو چھاتی میں درد ہو، سانس میں دقت ہو اور چلنے پھرنے سے سانس پھولتا ہو تو کسی مستند معالج سے رجوع کرنا چاہیے۔

ہارٹ اٹیک کے ذریعہ واقع ہونے والی اموات کی بنیادی وجہ بلڈ کولیسٹرول کی زیادتی ہی ہوتی ہے۔

آج پورے امریکہ میں خاص کر اس بات پر بہت ہی زور دیا جا رہا ہے کہ CHD کا رونی ہارٹ ڈیزیز کا سبب خاص ہائی کولیسٹرول ہی ہے۔ ہائی بلڈ کولیسٹرول خاموش قاتل ہے، اس کو بے نقاب کرنے کے لئے بہت سی تحقیقات کی گئی ہیں جو اس کتاب میں پیش کر دی ہیں۔

15 سے 20 سال کی عمر والے بالغوں میں ہائی بلڈ کولیسٹرول ان کو CHD کی جانب لے جاتا ہے اور ہر سال لاکھوں افراد CHD میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔

بالغ افراد فن لینڈ اور روس میں کا بلڈ کولیسٹرول لیول مطالعہ سے پتہ چلا کہ وہ 30 سے 50 ملی گرام اٹلی اور جاپان والے لوگوں سے زیادہ پایا گیا۔ جب مزید تحقیقات کی گئی تو پتہ چلا کہ روس اور فن لینڈ کے لوگوں میں جاپان اور اٹلی کے باشندوں کی نسبت CHD کی شرح بہت زیادہ ہے۔

امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں پچاس فی صد سے زیادہ بالغ آبادی کا بلڈ کولیسٹرول لیول 200 ملی گرام سے زیادہ ہے جب کہ 200 ملی گرام سے کم بلڈ کولیسٹرول لیول کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ جب بلڈ کولیسٹرول لیول 200 ملی گرام سے 1 فی صد اوپر جاتا ہے تو دل کے امراض میں مبتلا ہونے کے خطرات میں 2 فی صد اضافہ ہو جاتا ہے۔

اسی طرح اگر کسی کا بلڈ کولیسٹرول لیول 200 ملی گرام سے 10 درجہ بڑھ جاتا ہے تو اسے

CHD کا خطرہ بیس فی صد تک بڑھ جاتا ہے۔

اس بات سے 200 ملی گرام سے اوپر بڑھتے ہوئے بلڈ کولیسٹرول لیول کے خطرناک ہونے کا اندازہ بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔ اسی طرح اگر 200 ملی گرام سے 1 فی صد بلڈ کولیسٹرول کم کیا جائے تو CHD کا خطرہ 2 فی صد کم ہو جاتا ہے۔

امریکہ میں ہائی بلڈ کولیسٹرول کے نقصانات کو اجاگر کر کے عام عوامی سطح پر شعور بیدار کرنے کے لئے بہت کچھ کیا جا چکا ہے۔ لیکن ہمارے وطن پاکستان میں عوامی سطح پر لوگوں کو اس خاموش قاتل کے بارے کوئی خاص معلومات نہیں۔

ہمارے غیر حضرات کو دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبہ میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ تاکہ پیارے پاکستان کو مستحکم اور مضبوط بنانے میں ہر فرد اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ صحت مند افراد ہی جہد مسلسل اور لگن سے ملک کو بحران سے نکال سکتے ہیں۔

بیمار افراد نہ صرف اپنے لئے کچھ نہیں کر پاتے بلکہ اپنے خاندان اور ملک کے لئے بھی ناکارہ ثابت ہوتے ہیں۔ ملک خداداد پاکستان میں ابھی دوسرے شعبوں کے ساتھ ساتھ صحت کے شعبہ میں بھی بہت کارنامے سرانجام دینے کی ضرورت ہے تاکہ بیماریوں سے محفوظ رہ کر ایک صحت مند معاشرہ قائم کر کے اپنے ملک کی بھرپور خدمت کی جاسکے۔

ذیل میں چارٹ کی مدد سے ٹوٹل کولیسٹرول لیول

واضح طور پر آپ کو اپنے بارے معلومات فراہم کرتا ہے

عمر	کم خطرہ	اوسط درجہ کا خطرہ	زیادہ خطرہ
20 سال سے 29 سال	150 سے 169 ملی گرام	170 سے 200 ملی گرام	200 ملی گرام سے زیادہ
30 سال سے 39 سال	155 ملی گرام سے	175 ملی گرام سے	200 ملی گرام سے زیادہ
40 سال سے 49 سال	160 ملی گرام سے	180 سے 200 ملی گرام	200 ملی گرام سے زیادہ
50 سال اور زیادہ عمر والے افراد میں	170 سے 189 ملی گرام	190 ملی گرام سے	200 ملی گرام سے زیادہ

LDL Cholesterol Level

عمر	کم خطرہ	اوسط درجہ کا خطرہ	زیادہ خطرہ
20 سے 29 سال	90 ملی گرام سے	110 ملی گرام سے	130 ملی گرام سے زیادہ
	109 ملی گرام	130 ملی گرام	مقدار
30 سال سے 39 سال	95 ملی گرام سے	115 ملی گرام سے	130 ملی گرام سے زیادہ
عمر	114 ملی گرام	130 ملی گرام	مقدار
40 سال سے 49 سال	100 ملی گرام سے	120 ملی گرام سے	130 ملی گرام سے زیادہ
	119 ملی گرام	130 ملی گرام	مقدار
50 سال اور اس سے زیادہ	105 ملی گرام سے	125 ملی گرام سے	130 ملی گرام سے زیادہ
	124 ملی گرام	130 ملی گرام	مقدار

HDL Cholesterol Level

عمر سالوں میں	کم خطرہ	اوسط درجہ کا خطرہ	بہت زیادہ خطرہ
20 سال سے 29 سال	46 ملی گرام سے	40 ملی گرام سے	30 ملی گرام سے
	60 ملی گرام	45 ملی گرام	39 ملی گرام
30 سال سے 39 سال	46 ملی گرام سے	40 ملی گرام سے	30 ملی گرام سے
	60 ملی گرام	45 ملی گرام	39 ملی گرام
40 سال سے 49 سال	46 ملی گرام سے	36 ملی گرام سے	25 سے 35 ملی گرام
	55 ملی گرام	45 ملی گرام	
50 سال اور اوپر	46 سے 55 ملی گرام	36 سے 45 ملی گرام	25 سے 35 ملی گرام

تمام جدید و قدیم تحقیقات کا مجموعہ یہ ہے کہ

ہائی بلڈ کولیسٹرول، تمباکو نوشی، خاندانی طور پر دل کی بیماریوں کی ہسٹری رکھنا، سٹریس لیول کی زیادتی، مشقت نہ کرنا یا بہت زیادہ حاوی مشقت کرنا، شوگر اور بلڈ پریشر یہ تمام عوامل CHD کا باعث بنتے ہیں۔

اور CHD کا روزمرہ ہارٹ ڈیزیز دل کے دورہ کا باعث ہوتی ہیں اور دل کا دورہ جان لیوا

ثابت ہوتا ہے۔

یہ الفاظ نیویارک کے پروفیسر آف میڈیسن Isadore Rosenfeld کے ہیں۔

ایسے افراد جو تباہ کن کونوٹی کرتے ہوں، ہائی بلڈ پریشر یا ہائی بلڈ کولیسٹرول ان تینوں عوامل میں سے کسی دو سے بھی واسطہ رکھتے ہوں، عام آدمی کی نسبت دل کے امراض میں مبتلا ہونے کا آٹھ گنا زیادہ خطرہ رکھتے ہیں۔

اگر کسی کو ان تینوں نے گھیر رکھا ہو تو اسے عام آدمی کی نسبت دل کے امراض میں مبتلا ہونے کا 20 گنا زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔

پچھلے کئی عشروں سے CHD مشرق و مغرب کے ہر خطے میں کافی حد تک پھیل چکی ہے۔ اگر اس کا مغربی دنیا کے لوگوں اور مشرقی یا مشرقی دور دراز ممالک سے موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ جاپان، چائنا، تائیوان اور کوریا جیسے ممالک یورپ اور مغربی امریکہ کی نسبت CHD کا کم شکار ہیں۔ لیکن جدید نوعیت کی صنعتی ترقی کے باعث اب ہر جگہ CHD پہلے سے زیادہ پھیل رہی ہے۔

ہمارے خطے میں یعنی ہمارے پیارے ملک پاکستان میں CHD بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ اسی طرح بحالیہ ملک بھارت میں بھی CHD (کاروہری ہارٹ ڈیزیز) کا پھیلاؤ زوروں پر ہے۔

اور زیادہ تر درمیانہ عمر والے افراد اس کا شکار ہیں۔

امریکہ میں پچھلے کئی عشروں سے حیوانی چربی اور تیل کا استعمال بہت کم ہو گیا ہے، یہاں تک کہ اس میں 45 فی صد تک کمی واقع ہو گئی ہے۔

ہمارا پیارا وطن پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے لوگوں کی خوراک بہت زیادہ چربی لحمیات اور پروٹین سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔

وہی گھی کا استعمال بے دریغ کیا جاتا ہے لیکن پہلے جتنی محنت نہیں کرنا پڑتی۔ مشینری نے زمیندار کو بھی آسان بنا دیا ہے۔ دیگر بہت سی آسائشوں کے ساتھ سہل پسندی اور عمدہ خوراک صحت کو نقصان دے رہی ہے۔

کھانے پینے کی ان بے اعتدالیوں کے باعث بھی ہمارے ہاں CHD کی شرح بڑھ رہی ہے۔ ہمارے دوست ملک چائینہ میں اس کے برعکس لوگ سبزی اور پھلوں کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔

گوشت پر دہن اور حیوانی چربی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں۔ جس کی بناء پر ہماری نسبت چائے والے CHD کا کم شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تمباکو نوشی بہت حد تک بڑھ چکی ہے جو CHD میں اضافہ کرنے میں بہت نمایاں ہیں۔

جس وقت میں یہ سطور لکھا رہا ہوں اس وقت پبلک مقامات پر عوامی جگہوں دفاتر، بسوں، ویکونوں اور پارکوں میں سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ لیکن اس پر کوئی عمل نہیں ہو رہا ویسے کی ویسے سگریٹ نوشی جاری ہے بلکہ ذاتی مشاہدہ کے مطابق سرکاری دفاتر، بینکوں وغیرہ میں بھی ابھی تک الکار سگریٹ نوشی سے نہیں رکتے۔ اکیلا قانون کیا کرے گا؟

ہمیں باحیثیت قوم سوچنا ہوگا۔ اپنے اچھے برے میں تمیز کرنا ہوگی۔

پچھلے 20 سال میں امریکہ میں سگریٹ نوشی 30 فی صد کم ہو گئی ہے جب کہ ہمارے ہاں سگریٹ نوشی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اسی طرح موٹر انداز میں چلائی گئی مہم کے باعث امریکہ میں پچھلے 25 سالوں میں پچاس ملین افراد سگریٹ نوشی ترک کر چکے ہیں۔ جب تک ہم پختہ یقینی سے تمباکو نوشی پر اپنی گرفت مضبوط کر کے اسے کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتے CHD میں اضافہ روکا نہیں جاسکتا کیونکہ دیگر کئی عوامل کے ساتھ سگریٹ نوشی CHD کے اضافہ کا سبب ہے۔

ہمارے ملک پاکستان اور ہمسایہ ملک ہندوستان میں بلڈ پریشر کی زیادتی بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے۔ لاکھوں کے حساب سے لوگ اس کی زد میں آ گئے ہیں اور مزید لاکھوں لوگ ہائپر ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں۔

پہلے پہل ہائپر ٹینشن کوئی خاص علامات ظاہر نہیں کرتا۔ بہت سے لوگوں کو اپنے ہائی بلڈ پریشر کے متعلق پتہ ہی نہیں ہوتا۔

اسی طرح بلڈ کولیسٹرول کی زیادتی کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہائی بلڈ کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر ساتھ ساتھ بڑھتے جاتے ہیں اور آخر کار CHD کا سبب بنتے ہیں۔

ہمارے پیارے وطن پاکستان میں بلڈ پریشر اور بلڈ کولیسٹرول کی زیادتی کی دیگر کئی وجوہات کے ساتھ ورزش نہ کرنا بھی ایک وجہ ہے۔

ہمارے ہاں جسمانی محنت کے متعلق لوگوں میں شعور آگئی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں سپورٹس ٹیمپلکس کی کمی بھی ہے اور لوگوں میں ورزش اور ورزشی کھیلوں کا رجحان بہت کم ہے۔

دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لئے بہتری طرز زندگی گزارنے اور علاج کروانے کے مواقع عورتوں کے مقابلہ میں مردوں کو زیادہ حاصل ہیں اور مرد مہنگا علاج بھی کروا لیتے ہیں۔ جب کہ عورتیں مہنگا علاج کروانے سے گریزاں ہوتی ہیں۔

اور ان کی دل کی بیماریوں کی شدت مردوں کے مقابلہ میں زیادہ ہوا کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں تو ویسے ہی لڑکیوں کے مقابلہ میں لڑکوں کو ترجیح دی جاتی رہی ہے لیکن اب ملک پاکستان میں اسلامی تعلیمات کو فروغ مل رہا ہے، اس لئے پڑھے لکھے والدین لڑکوں اور لڑکیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے۔

لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی لڑکوں کی تربیت کی طرح توجہ کرتے ہیں۔

آپ بلڈ کولیسٹرول کو کم کیسے کر سکتے ہیں

1- غذائی تبدیلیوں سے

ہائی بلڈ کولیسٹرول اور ہائی LDL جو کورونری ہارٹ ڈیزیز کا سبب بنتا ہے اگر اس کو کم سطح پر رکھا جائے تو دل کی بیماریوں کے خدشات کم ہو جاتے ہیں۔

جدید تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی فرد اپنا بلڈ کولیسٹرول لیول دس فی صد تک کم کر لیتا ہے تو اسے دل کے دورہ کا خطرہ 20 فی صد کم ہو جاتا ہے۔

اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلڈ کولیسٹرول لیول کو کم کرنے کی اہمیت کیا ہے؟ کسے غذائی احتیاط کی ضرورت پیش آتی ہے۔

اس سلسلہ میں نیشنل کولیسٹرول ایجوکیشن پروگرام (NCEP) نے چند سال پہلے جو تحقیقات کیے ہیں ان کے مطابق تمام بالغوں کو تین گروپس میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایسا LDL کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ بہت زیادہ، زیادہ اور کم اس طرح تین گروپوں میں بالغ افراد کو رکھا جاتا ہے تاکہ مسئلہ کی سنگینی واضح ہونے پر ان تینوں گروپس میں رکھے گئے افراد اپنا الگ الگ نوعیت کا علاج و پرہیز کر سکیں۔ اور مناسب غذائی تبدیلیوں سے اپنے مرض پر قابو پا سکیں۔

NCEP نیشنل کولیسٹرول ایجوکیشن پروگرام کا مرتب کردہ چارٹ ملاحظہ فرمائیں۔

کولیسٹرول لیول

200 ملی گرام سے کم اچھا کولیسٹرول خیال کیا جاتا ہے۔

200 ملی گرام سے 239 ملی گرام تک ہائی بلڈ کولیسٹرول کی حد کو چھوٹا ہوا۔

240 ملی گرام یا اس سے زیادہ ہائی بلڈ کولیسٹرول

200 ملی گرام سے کم کولیسٹرول والے افراد اپنی خوراک میں چکنائی کی کمی سے اپنے آپ کو

ہائی بلڈ کولیسٹرول سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ اور اپنے بلڈ کولیسٹرول کا معائنہ کم از کم سال میں ایک مرتبہ

ضرور کروانا چاہیے۔

200 ملی گرام سے 239 ملی گرام مقدار بلڈ کولیسٹرول والے افراد کو دل کے عوارضات میں

بتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے مگر بہت زیادہ نہیں۔

لیکن اگر آپ کا بلڈ کولیسٹرول لیول 240 ملی گرام ہے یا اس سے زیادہ ہے تو مزید LDL، HDL اور ٹرائی گلیسرائیڈ ٹیسٹ کروانے چاہیے۔

LDL جسے عرف عام Bad Cholesterol کہتے ہیں۔ اگر 200 ملی گرام سے زیادہ بلڈ کولیسٹرول ہو تو LDL ضرور چیک کروانا چاہیے۔

کیونکہ LDL کی زیادتی خون کی شریانوں کی تنگی اور سختی کا باعث بنتی ہے۔ بلڈ کولیسٹرول کے دیئے گئے چارٹ کے مطابق۔

اگر ساتھ درجہ ذیل عوامل بھی شامل ہوں یا درجہ ذیل عوامل سے ایک یا دو شامل ہوں تو CHD کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

مثلاً تمباکو نوشی، ہائپر ٹینشن، شوگر، فیملی ہسٹری آف CHD شدید نوعیت کا موٹاپا اور 30% سے زیادہ وزن کا بڑھ جانا۔

غذا کے ذریعہ بلڈ کولیسٹرول لیول کو کم کرنا

30 فی صد ٹوٹل کلوریز	ٹوٹل چکنائی
10 فی صد ٹوٹل کلوریز	سچو ریٹیفائی ایسڈز
10 فی صد سے زیادہ ٹوٹل کلوریز	پولی آن سچو ریٹیفائی ایسڈز
10 فی صد سے 15 فی صد ٹوٹل کلوریز	مونو سچو ریٹیفائی ایسڈز
300 ملی گرام روزانہ	کولیسٹرول
50 فی صد سے 60 فی صد ٹوٹل کلوریز	کاربو ہائیڈریٹ
10 فی صد سے 20 فی صد ٹوٹل کلوریز	پروٹین
7 فی صد سے زیادہ ٹوٹل کلوریز	سچو ریٹیفائی ایسڈز
30 فی صد سے زیادہ ٹوٹل کلوریز	ٹوٹل چکنائی
10 فی صد سے زیادہ	پولی آن سچو ریٹیفائی ایسڈز
10 فی صد سے 15 فی صد آف ٹوٹل کلوریز	مونو آن سچو ریٹیفائی ایسڈز
200 ملی گرام سے زیادہ روزانہ	کولیسٹرول

کاربوہائیڈریٹ
پروٹین

50 فی صد سے 60 فی صد آف ٹوٹل کلوریز
10 فی صد سے 20 فی صد آف ٹوٹل کلوریز

اپنی خوراک میں تبدیلی لانے کے لئے مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوا کرتی ہے کیونکہ چند دن کی تبدیلی سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔

پہلے چارٹ کے مطابق خوراک کی تبدیلی کو اگر کم از کم چھ ماہ تک جاری رکھا جائے تو آفاقہ ہو سکتا ہے۔ اور بلڈ کولیسٹرول لیول کو نارمل سطح پر لایا جاسکتا ہے۔

اگر چھ ماہ تک اس پریسز خوراک سے آفاقہ نہ ہو تو چارٹ نمبر 2 کو اپنانا چاہیے۔ اور اسے بھی تقریباً چھ ماہ سے 9 ماہ تک جاری رکھنا چاہیے۔

اگر پھر بھی مطلوبہ نتائج برآمد نہ ہوں تو پھر ادویات کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ آگے چل کر ایک الگ باب میں ہم ادویاتی استعمال پر روشنی ڈالیں گے۔

فیٹ فری غذا

جربنی یا روغنیات والی خوراک زیادہ مزیدار ہونے کے باعث کم کرنا یا ترک کرنا مشکل ہوتی ہے۔

اس لئے اس کو کم مقدار میں استعمال کرنے میں کافی دقت پیش آتی ہے۔ اس بات کا اندازہ امریکن نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کی رپورٹ سے کیا جاسکتا ہے کہ

امریکہ میں تعلیم عام ہونے اور مختلف تحقیقاتی پروگراموں کا عوامی سطح پر تعارف ہونے کے باوجود امریکن لوگ اپنی خوراک کا 37 فی صد کلوریز فیٹ سے حاصل کرتے ہیں۔

اور پچھلے چند سالوں میں زور دار تبلیغ کے بعد لوگ 25 فی صد تک کلوریز فیٹ سے حاصل کرتے ہیں۔

حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ کورونری شریانیں چکنائی کے استعمال سے تنگ ہو جاتی ہیں۔ چکنائی کو دو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

(1) سچورےٹڈ (2) آن سچورےٹڈ

سچورےٹڈ (سیرشدہ)

چکنائیاں گلیسرول اور فٹی ایسڈز سے بنی ہوئی ہوتی ہیں۔ مختلف اقسام کی چکنائیوں میں

فیٹی ایسڈز کی ترکیب مختلف ہوتی ہے۔

کئی فیٹی ایسڈز میں کاربن کے تمام ایٹم ہائیڈروجن ایٹم سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا اسے بھرپور ہوتے ہیں۔ ایسی چکنائیاں سچو ریٹ فیٹی ایسڈز والی ہوتی ہیں۔

اُن سچو ریٹڈ (غیر سیر شدہ)

اگر فیٹی ایسڈز کے چند کاربن ایٹم ہائیڈروجن ایٹم سے ملے ہوئے نہ ہوں تو ایسے فیٹی ایسڈز کو اُن سچو ریٹڈ (غیر سیر شدہ) فیٹی ایسڈز کہتے ہیں۔

اگر غیر جڑے ہوئے کاربن ایٹم کی تعداد سنگل ہو تو ایسے فیٹی ایسڈز کو Monounsaturated کہتے ہیں اور اگر غیر جڑے ہوئے کاربن ایٹم زیادہ ہوں تو انہیں Polyunsaturated فیٹی ایسڈز کہتے ہیں۔

Saturated سیر شدہ چکنائی زیادہ تر مکھن، گھی، دودھ اور گوشت میں پائی جاتی ہے۔ لیکن چند نباتاتی تیل مثلاً ناریل کا تیل، پام آئل بھی سیر شدہ چکنائیوں کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔

سیر شدہ چکنائی ہی ایٹھرو سکلیروسیس Atherosclerosis کا باعث بنتی ہیں۔ انہیں کی بدولت ایٹھرو سکلیروسیس اور کورونری ہارٹ ڈیزیز پھلتی پھولتی ہیں۔ غیر سیر شدہ چکنائیاں خاص کر آئلز یعنی تیلوں میں پائی جاتی ہیں۔ یہ چکنائیاں عام کمرہ کے درجہ حرارت میں مائع ہی رہتی ہیں جب کہ سیر شدہ چکنائیاں پام آئل، کوکانٹ آئل وغیرہ عام کمرہ میں عام درجہ حرارت پر ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان میں دیسی گھی، مکھن وغیرہ شامل ہیں۔ غیر سیر شدہ چکنائیوں کو پھر دو اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

Monounsaturated اور Polyunsaturated اگر غیر سیر شدہ چکنائیوں کا سیر شدہ چکنائیوں سے دل کے معاملہ میں موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ Monounsaturated اور Polyunsaturated۔

دونوں قسم کی چکنائیاں دل کے عوارضات سے محفوظ رکھنے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ غیر سیر شدہ چکنائیوں کا محدود استعمال بلڈ کولیسٹرول لیول کو خفگی سطح پر رکھتا ہے۔ جس کی بناء پر دل کی شریانوں کی بیماریوں CHD کے خدشات معدوم ہو جاتے ہیں۔

ان Monounsaturated چکنائیوں کے ذرائع میں زیتون کا تیل، کینولا آئل، اور بادام روغن شامل ہیں۔ جب کہ Polyunsaturated چکنائیوں کے ذرائع میں کارن آئل، سن فلاور آئل اور مچھلی کا تیل سرفہرست ہیں۔

نئی تحقیقات سے یہ بات بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ Monosaturated زیتون کا تیل دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ بلڈ کولیسٹرول لیول کو بڑھنے نہیں دیتا اور سکھروسس سے بھی روکتا ہے۔ جب کہ دیسی گھی، مکھن اور ڈالڈا گھی، ہائی بلڈ کولیسٹرول کا باعث بنتا ہے اور آخر کار دل کی بیماریوں سے دوچار کرتے ہیں۔

ان کے مقابلہ میں زیتون کا تیل، روغن بادام، کینولا آئل، سورج مکھی کا تیل غیر سیر شدہ چکنائیاں ہیں جو دوسری سیر شدہ چکنائیوں کے مقابلہ میں بے حد مفید ہیں۔ ہمیں خوراک میں دیسی گھی اور مکھن کا اعتدال سے استعمال کرنا چاہیے جب کہ Polyunsaturated چکنائیاں جن میں زیتون کا تیل، بادام روغن، مچھلی کا تیل، کینولا آئل، سورج مکھی کا تیل شامل ہیں۔

ان کا استعمال روزمرہ کی خوراک میں کرنا چاہیے تاکہ بلڈ کولیسٹرول لیول نہ بڑھنے پائے اور دل کی شریانوں کی تنگی جو آخر کار ہارٹ اٹیک کا باعث بنتی ہے سے بچا جاسکے۔

دیسی گھی کے نقصانات

دیسی گھی اور مکھن دونوں ہی خاص اور نمایاں سیر شدہ چکنائیاں ہیں، اور یہ دونوں ہی ہمارے ملک پاکستان اور ہمسایہ ملک ہندوستان میں کافی استعمال کئے جاتے ہیں۔

بلکہ ہمارے ہاں دیسی گھی اور مکھن کو استعمال میں لا کر فخر یہ انداز میں لوگوں کو بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم دیسی گھی اور مکھن استعمال کرتے ہیں۔ ان دونوں کا استعمال امیرانہ ٹھاٹھ ہاتھ کی علامت سمجھا جاتا ہے۔

کوکنگ آئل کے فوائد

Monounsaturated اور Polyunsaturated چکنائیاں بلڈ کولیسٹرول لیول کو نارمل رکھتی ہیں اور بڑھنے نہیں دیتی۔

Unsaturated چکنائیوں کے ذرائع بہت سے تیل ہیں۔ البتہ ان میں سیر شدہ چکنائیوں کی کچھ مقدار بھی ضرور ہوتی ہے، پچھلے کئی سالوں سے زیتون

کاتیل میڈیکل کے شعبہ میں زیر بحث رہا ہے کیونکہ اس کا استعمال دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
یورپ میں اس پر بہت سی تحقیق کی گئی لیکن ریتون کے تیل کا استعمال خاصا مہنگا ہوتا ہے۔

مختلف کوکنگ آئلز میں سیر شدہ، غیر سیر شدہ اجزاء کی ترکیب

پولی سیر شدہ	مونو غیر سیر شدہ	سیر شدہ	آئل
Polyunsaturated	Monounsaturated	Saturated	Oil
18	73	9	بادام کا تیل
4	30	65	کھن
31	62	7	کینولا تیل
2	6	92	کوکا نٹ تیل
62	25	13	کارن تیل
54	19	27	بنولا تیل
34	48	18	مونگ پھلی تیل
10	39	51	پام آئل
78	13	9	سافلاور آئل
43	42	15	سیسم آئل
61	24	15	سویا بین آئل
69	20	11	سورج کھجی آئل
9	77	14	زیتون آئل
27	45	28	ویگی نیبل آئل

اس دیئے گئے چارٹ کی مدد سے مختلف آئلز میں سیر شدہ، مونو غیر سیر شدہ، پولی غیر سیر شدہ
چکنائیوں کی مقدار کا پتہ چلتا ہے۔

اچھی غذا کا چناؤ

ایک محاورہ یاد آگیا، کہا جاتا ہے کہ معالج ہمیشہ آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لئے کام کرتا
ہے۔ اور باورچی اسے ناکام بنانے کے لئے، لیکن باورچی اس میں اکثر کامیاب رہتا ہے۔

اس باب میں ہم غذا کے چناؤ پر بحث کریں گے۔ کیونکہ غذائی تبدیلیوں سے بہت سی دیگر بیماریوں کی طرح ہارٹ اٹیک پر بھی قابو پایا جاسکتا ہے۔

یہ شغلی چابی آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے اپنی صحت کو برقرار رکھنے اور روزمرہ کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآں ہونے کے لئے متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے استعمال سے کمزوری اور بیماری دونوں سے بچا جاسکتا ہے۔

ویسے بھی کم بولنا، کم کھانا، کم سونا بڑے آدمیوں کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اچھی غذا کے چناؤ کے لئے سب سے پہلے پھل اور سبزیوں کا ذکر کیا جائے گا، پھل اور سبزیاں ہمارے ملک میں عام ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ مہنگی بھی نہیں۔ ان کے مناسب استعمال سے جسم کو صحت مند اور توانا رکھا جاسکتا ہے۔

پھلوں اور سبزیوں میں نہ صرف وٹامن اور معدنیات ہوتی ہیں بلکہ ان میں ہمارے لئے ریشوں کی بہت بڑی مقدار بھی پائی جاتی ہے۔

ریشوں کی زیادہ مقدار کا استعمال بلڈ کولیسٹرول لیول کو نارمل رکھنے اور ہارٹ ڈیزیز CHD کو کم از کم سطح پر رکھنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتا ہے۔

ہمارے پیارے ملک پاکستان میں خوش قسمتی سے ہر موسم میں سبزیوں کی پیداوار کثرت سے ہوتی ہے۔ اس لئے ہمیں ان کا استعمال کثرت سے کرنا چاہیے، سبزیاں زیادہ مہنگی بھی نہیں جو عام آدمی کی پہنچ میں نہ ہوں۔

سبزیوں میں حرارے کم ہوتے ہیں اور کولیسٹرول اور چکنائی نہیں ہوتی، اس لئے یہ دل کے مریضوں کے لئے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کے لئے بہت مفید ثابت ہوتی ہیں۔

اکثر ماہر قلب سبزیوں اور پھلوں کے استعمال پر زور دیتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ سبزیوں کو زیادہ پکانے سے ان کے اجزاء مٹ جاتے ہیں۔ اور ان میں دہکی گئی یا دوسرے گھی کا بہت زیادہ ملاپ غذائیت کو محفوظ نہیں رہنے دیتا۔ اور سبزیوں کے استعمال کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔

بہت سے لوگ سبزیوں کو ابال کر استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت ضروری خیال کریں تو کم مقدار میں کوئنگ آئل سے سبزی کو فرائی کر لیں۔ کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ مقدار میں گھی یا دہکی گھی کا استعمال کریں گے تو سبزی مزید ارتقا بن جائے گی لیکن اتنی زیادہ چکنائی جو اس میں ڈال دی گئی ہے۔ اس کی قیمت آپ کے دل کو ادا کرنا پڑے گی۔

پھل بھی ہماری صحت اور خاص کر دل کے عوارض سے محفوظ رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون کون سے پھل دل کے لئے مفید ہے اور ان کا استعمال CHD کی کمی کا باعث ہوا کرتا ہے۔

(1) مالٹا

مالٹا میں حرارے کم ہوتے ہیں اور چکنائی سے پاک ہوتا ہے، اس میں کولیسترول بھی نہیں پایا جاتا۔ اس لئے مالٹا کے جوس کا استعمال دل کے لئے بہت مفید ہے۔

(2) لیمن

لیمن جوس بھی دل کے لئے بہت مفید ہے۔ اس میں چکنائی اور کولیسترول بالکل نہیں ہوتا۔ اس میں وٹامن سی کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔ لیمن کا رس دل کے لئے نہایت ہی موزوں ہے۔

(3) انگور

انگور میں بہت زیادہ وٹامن کی مقدار موجود ہونے کے باعث اور کولیسترول اور چکنائی نہ ہونے کے باعث دل کے لئے بہت مفید ہے۔

(4) دودھ

دودھ میں بہت زیادہ مقدار میں پروٹین پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کینیشیم، فاسفورس اور وٹامن کی بہت زیادہ مقدار پائی جاتی ہے۔

ہمارے پیارے ملک میں اور پورے برصغیر میں دودھ کثرت سے استعمال ہوتا ہے، دودھ تو مغرب میں بھی کافی مقدار میں استعمال ہوتا ہے، وہاں پر چار اقسام کا دودھ ہوتا ہے۔ 1 فی صد، 2 فی صد اور 4 فی صد چکنائی والا دودھ ہر جگہ آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔ اور دل کے عوارض سے بچاؤ کے لئے Skimmed Milk یعنی کریم نکالا ہوا دودھ بہت مفید ہوتا ہے۔

کریم یا بالائی نکالے ہوئے دودھ کے ایک کپ میں ساٹھ حرارے ہوتے ہیں۔ جب کہ کریم سے بھر پور دودھ گئے ایک کپ میں 160 حرارے ہوتے ہیں۔

اسی طرح لسی کا استعمال بھی بہت سے ممالک میں ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان

میں اور پورے برصغیر میں کسی کو شوق سے پیا جاتا ہے لیکن ایسی کسی جو مکھن سے پاک ہو یعنی کسی سے مکھن کو نکال لیا جائے تو تب حاصل شدہ کسی دل کے عوارض والوں کے لئے اور دل کے عوارض سے بچنے کے لئے مفید ہوتی ہے جب کہ مکھن والی کسی جسے ہماری زبان میں کڑکڑ کہتے ہیں، دل کے عوارض میں مفید نہیں ہوگی۔

(5) چپاتی یا روٹی

اس کے مختلف نام ہیں روٹی، چپاتی یا بریڈ۔ دنیا میں ہر جگہ پر کھائی جاتی ہے۔ ہمارے وطن میں روٹی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ روٹی گندم کے آٹا سے پکائی جاتی ہے۔ اس میں بہت ہی ریشے ہوتے ہیں جو ہماری صحت اور خاص کر دل کے لئے بہت ہی مفید ہوتے ہیں۔

ان چھنے آٹے کی روٹی غذائی اعتبار سے بہت مفید ہوتی ہے۔ اور ایسے آٹے کا استعمال ہی بہتر ہوتا ہے جس سے چوکر، سوچی اور میدہ نہ نکالا گیا ہو۔ جب کہ سفید آٹے یعنی میدہ کی روٹی کی وہ خاصیت نہیں جو آٹے کی روٹی میں ہوتی ہے۔ روٹی مکئی، جوار، اور باجرہ سے بھی تیار کی جاتی ہے۔

(6) چاول

قدرتی براؤن چاول ریشے سے بھرپور ہوتے ہیں جب کہ صاف کئے جانے پر ان میں سے ریشہ کی مقدار بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ کئی ممالک میں ایسی چاولوں کی مصنوعات دستیاب ہیں جن پر واضح طور پر درج ہوتا ہے کہ اس میں ریشہ دار اجزاء ہیں یا نہیں ہیں۔

(7) ریشہ دار غذائیں

ریشہ دار غذائیں یہ خاصیت رکھتی ہیں کہ دل کے عوارض سے چھٹکارا دلانے میں مدد کر سکیں۔ شوگر موٹاپا اور ہائی بلڈ کولیسٹرول والے افراد کے لئے ریشہ دار غذائیں بہت مفید ہوا کرتی ہیں اور CHD کے خدشات کو بہت حد تک کم کرتی ہیں۔

(i) جو کا چوکر: بہت ہی مفید شے ہے یہ ڈائجسٹو اعضاء میں سے کولیسٹرول کو مل کر لیتا ہے۔

(ii) اسبغول: ہمارے ملک میں بڑے پیمانہ پر آسانی سے دستیاب ہوتا ہے اور یہ ریشہ دار اجزاء کا

حامل ہونے کی وجہ سے جو کہ 5 سے 8 گنا زیادہ بلڈ کولیسٹرول کو کم کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔

حقیقت میں غلہ اور اناج والی غذائیں، ریشہ دار ہونے کے باعث دل کیلئے بہت مفید ہوتی ہیں۔

(8) بادام اور دیگر مغزیات

بادام اور دیگر بہت سی مغزیات فیٹی ایسڈز اور پروٹین سے بھرپور ہوتی ہیں لیکن بادام کی خاصیت ہے کہ اس میں بہت زیادہ مقدار میں Monounsaturated فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں۔ Monounsaturated چکنائیوں کے استعمال سے ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول اور LDL جیسے Badcholesterol کہتے ہیں کو کم کیا جاسکتا ہے۔

کلی فورنیا میں بادام روغن پر تحقیقات کی گئی اور خوراک میں چکنائی کے طور پر بادام روغن کو کافی مقدار میں استعمال کیا گیا جب کہ دوسری چکنائیوں کو بہت کم مقدار میں 4 ہفتوں کے بعد یہ بات عیاں ہو گئی کہ مردوں اور عورتوں دونوں میں بلڈ کولیسٹرول لیول کم ہوا۔ اس مطالعہ کے دوران دوسری چکنائی کا استعمال بہت ہی کم کیا گیا تھا۔

اس کے بعد ماہرین نے یہ فیصلہ دے دیا کہ بادام روغن کا استعمال کولیسٹرول کو کم کرتا ہے۔ اور عام طور پر 11 سے 21 بادام کا روزانہ کا استعمال جسم اور دل دونوں کے لئے مفید ہے۔

ان کے استعمال کا طریقہ کچھ اس طرح سے ہے کہ 11 سے 21 مغز بادام رات کو کسی صاف کپے برتن میں بھگو دیں اور صبح اس کے پھلکے اتار کر حسب منشا استعمال کر لیں۔

باداموں کے علاوہ اخروٹ اور مونگ پھلی کے مغز بھی اسی زمرہ میں آتے ہیں۔

لیکن پاکستان جیسے غریب اور ترقی پذیر ملک میں لوگ باداموں اور اخروٹ کے مغز کو کھانے کے وسائل نہیں رکھتے۔ کیونکہ یہ دونوں منگنے ہونے کے باعث عام آدمی کی قوت خرید سے باہر ہیں، ہم ان دونوں کی جگہ آپ کو ان سے سستی ترین چیز بتا دیتے ہیں۔

مونگ پھلی کا تیل غیر سر شدہ چکنائی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس لئے یہ دیکھی گئی اور ڈالڈا گھی دونوں کے مقابلہ میں دل کے لئے مفید ہوتا ہے۔

کون کون سی چیزوں سے پرہیز کیا جائے

لوگ چربی اور مصالحہ جات والی خوراک کے دلدادہ ہو کر بہت زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ غریب آدمی غیر متوازن غذا کے باعث بیمار پڑ جاتا ہے اور غذا میسر نہیں ہوتی لیکن ایک امیر آدمی زیادہ کھا کر اور ورزش سے منہ موڑ کر بیمار پڑتا ہے۔

زیادہ مقدار میں چکنائیاں پروٹین استعمال کرنے کے بعد محنت مشقت نہ کرنے سے جسم میں چربی کی مقدار بڑھ جاتی ہے، جس سے موٹاپا، شوگر، ہائی بلڈ کولیسترول اور آخر کار دل کے عوارض جنم لیتے ہیں۔ ایسی غذا کا استعمال کیا جائے جو روہضم ہو اور سستی بھی۔ ضرورت سے بڑھ کر حراروں سے بھرپور غذا کا استعمال نقصان سے خالی نہیں ہوتا۔

(1) بڑا گوشت

بڑا گوشت یعنی چھڑے اور بھینس کا گوشت کولیسترول اور سیر شدہ چکنائیوں سے بھرپور ہوتا ہے۔

ایسے افراد جن کا بلڈ کولیسترول لیول پہلے ہی زیادہ ہو، انہیں اس بھرپور کولیسترول اور سیر شدہ چکنائی والی خوراک سے پرہیز کرنا چاہیے۔

البتہ بہت کم بلڈ کولیسترول لیول والے افراد اس بھرپور چکنائی والی خوراک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

انڈا

انڈے میں موجود سفیدی میں پروٹین بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے جب کہ زردی میں تمام کا تمام کولیسترول ہی ہوتا ہے۔

ایک اوسط سائز کے انڈے میں 250 سے 300 ملی گرام کولیسترول موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی فرد کا بلڈ کولیسترول لیول نارمل سے بڑھ رہا ہو تو اندازہ کر لیں اس کے لئے انڈوں کا استعمال کس قدر نقصان دہ ہے۔

جب کہ کمزور افراد کیلئے انڈوں کا استعمال مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور کم کولیسترول والے افراد انڈے کا استعمال مسلسل کر سکتے ہیں۔

نیر

نیر میں پروٹین اور حراروں کی بہت بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ اس لئے مونیا، اور ہائی بلڈ کولیسترول لیول والے افراد اس کے استعمال سے پرہیز کریں۔

کافی، چائے اور کولا

کافی اور چائے میں کافین کی موجودگی کے باعث اس کے استعمال سے بلڈ کولیسترول لیول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس لئے پہلے سے ہائی بلڈ کولیسترول والوں کیلئے انتہائی مضرت ہے۔ کافی اور چائے کے علاوہ بہت سے مشروبات جن میں کوکا کولا اور پیپسی کولا شامل ہے ان میں بھی کافین شامل ہوتی ہے۔

اس لئے کافی، چائے اور کولا کا استعمال ہائی بلڈ کولیسترول، بے چینی اور دل کی بے قاعدہ ضربات کا باعث بنتا ہے۔

ناریل اور ناریل کا تیل

ناریل کے ایک سو گرام میں 14 گرام چکنائی ہوتی ہے۔ بد قسمتی سے یہ چکنائی سیر شدہ ہوتی ہے۔ ناریل اور پام کے تیل میں بہت زیادہ مقدار میں سیر شدہ چکنائی ہوتی ہے۔

اس لئے ان کا استعمال بلڈ کولیسترول لیول میں اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ اس سے بڑھتے ہوئے کولیسترول والوں اور موٹے افراد کو پرہیز کرنا چاہیے۔

ذیل میں مختلف کھانے پینے والی اشیاء میں کولیسترول کی مقدار دی جاتی ہے

مختلف غذاؤں میں کولیسترول کی مقدار

غذا	کولیسترول ملی گرام فی سو گرام	غذا	کولیسترول ملی گرام فی سو گرام
غذا کا نام اور اس کے سو گرام میں کولیسترول کی مقدار ملی گراموں میں		غذا کا نام اور اس کے سو گرام میں کولیسترول کی مقدار ملی گراموں میں	
مغز	2000	بھینٹ کا جوس	0
بڑا گوشت	70	کیلے کا جوس	0

0	انڈے کی سفیدی	550	انڈا سارے کا سارا
0	جام چیلی	70	مچھلی
0	ینگو	375	گردے
0	بہزیوں میں	300	کبجی
0	چائے کافی	250	کھن
0	بھنڈی توری	150	دل
0	پالک	100	خیر
0	آلو	85	سوکھا دودھ تمام کا تمام
0	مٹر	65	چھوٹا گوشت
0	کوکبر	60	چکن
0	بادام	45	آکس کریم
0	گاجر	34	دودھ بغیر کھن نکالے
0	چاول بغیر پکنائی شامل کیے ہوئے		ایک کپ میں
0	گو بھی	05	کریم نکالے ہوئے دودھ
			کے ایک کپ میں

مچھلی کھائیں اور بلڈ کولیسٹرول نارمل رکھیں

ایسے بہت سے افراد جو مچھلی کو کثرت سے کھاتے ہیں اور تندرست و توانا بھی رہتے ہیں۔ حالانکہ مچھلی میں بہت زیادہ مقدار میں پکنائی موجود ہوتی ہے، لیکن مچھلی میں موجود پکنائی کولیسٹرول سے پاک ہوتی ہے۔ اس لئے مچھلی کھانے والوں کے بلڈ کولیسٹرول میں اضافہ نہیں ہوتا اور مچھلی خور افراد CHD یعنی کوروٹری ہارٹ ڈیزیز سے محفوظ رہتے ہیں۔

اس بات پر بہت سی تحقیقات ہو چکی ہیں، مچھلی کھانے والے افراد کے خون میں سسٹکے یا ٹوٹھڑے نہیں بنتے بلکہ ان کا خون اس قدر پتلا ہو جاتا ہے کہ ان کا بلڈ گوانٹک دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ایسے افراد جو مچھلی کا کثرت استعمال کرتے ہوں ان کے بلڈ کولیسٹرول لیولز بھی نارمل رہتے ہیں اور وہ دل کے دورہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور ایسے افراد جن کو دل کا دورہ پڑ چکا ہو مچھلی کا استعمال

انہیں دو بارہ دورہ سے محفوظ بنانا ہے اور ان کی موت ہارٹ اٹیک سے واقع نہیں ہوتی۔

امریکن جرنل آف کارڈیالوجی کی نومبر 1990 کی رپورٹ کے مطابق ایسے افراد جو مچھلی اور مچھلی کا تیل استعمال کرتے ہیں، CHD سے محفوظ رہتے ہیں۔ 107 مریضوں کو مچھلی کھانے سے کچھ دیر بعد اسٹیپو گرافی کے ذریعہ پتہ چلا کہ ان کی دل کی شریانوں کی تنگی نہ صرف مزید بڑھنے سے رکی ہے بلکہ کم ہو گئی ہے۔ اسی طرح خوراک میں مچھلی کا تیل استعمال کرنے یا مچھلی کے استعمال سے LDL اور ٹرائی گلیسرائیڈز جو دونوں کو Bad Cholesterol کے نام سے یاد کیا جاتا ہے میں نمایاں طور پر کمی واقع ہوتی ہے اور یہ کمی دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنے میں انتہائی مددگار ہوتی ہے۔

ہفت روزہ برطانوی میڈیکل میگزین جو پوری دنیا میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اس کی رپورٹ کے مطابق 12000 ایسے افراد پر تجربہ کیا گیا جو دل کے دورہ سے دو چار ہو چکے تھے۔

ان مریضوں میں سے آدھے مریضوں کو ہفتہ میں کم از کم دو مرتبہ مچھلی کھانے کا پابند کیا گیا۔ دو سال تک اس تجویز پر عمل کرنے کے بعد ان مریضوں کا مچھلی نہ کھانے والے مریضوں سے موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ جو مریض مچھلی کھاتے تھے وہ نہ کھانے والے کی نسبت بہت کم ہارٹ اٹیک سے مرے۔ اسی طرح بہت سی تحقیقات سے ہر بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ ایسے افراد جو مچھلی کا بکثرت استعمال کرتے ہیں اور افراد کی نسبت CHD کا بہت کم شکار ہوتے ہیں جو مچھلی نہ کھاتے ہوں یا بہت کم کھاتے ہیں۔

یہاں تک کہ دل کے دورہ پڑ جانے کے بعد جن مریضوں نے مچھلی کا استعمال ہفتہ میں دو مرتبہ جاری رکھا، دو سال بعد ان میں ہارٹ اٹیک سے شرح اموات میں بہت نمایاں حد تک کمی واقع ہو گئی۔

اومیگا تھری فیٹی ایسڈز

مچھلی کا تیل مچھلی کے زرم اور فیٹی ٹشوز سے حاصل کیا جاتا ہے اور اس کی زیادہ مقدار بکھرے حاصل کی جاتی ہے۔

یہ چربی دیگر حیوانی چربی سے بالکل مختلف ہوتی ہے، اگرچہ فیٹی ایسڈز کی بہت سی اقسام مچھلی کے تیل میں موجود ہوتی ہیں۔ ان میں سے دو خاص کر بلڈ کولیسٹرول کو کم رکھنے میں مفید ہوتی ہیں۔

(1) EPA) Eicosapentaenoic Acid

Polyunsaturated Fatyy Acid (2)

یہ دونوں چکنائیاں ہوتی ہیں۔

EPA میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ خون کے لوتھڑوں نہیں بننے دیتا۔ مزید یہ LDL کو کم کرتا ہے اور HDL کو بڑھاتا ہے۔

اس بنا پر شوگر کی تھگی میں کمی واقع ہوتی ہے اور خون کی شریانوں میں کولیسٹرول کا جماؤ نہ ہونے Atherosclerosis سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

EPA کی ایک اور قابل ذکر اور نمایاں خاصیت کا یہاں ذکر کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ یہ جگر سے ٹرائی گلیسرائیڈز کی پیداوار کو کم کرتا ہے۔ اسی بنا پر ہم کہتے ہیں کہ کوڈ اور آئل ایک بہترین غذا اور دوا ہے جو ہمیں تندرست و توانا رکھنے کے ساتھ ساتھ CHD یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔

مچھلی خور افراد کی گوشت خور افراد کے مقابلہ میں اوسط عمر کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ بات تو بالکل عیاں ہے اور ذائقے کی چوٹ پر کبھی جاسکتی ہے کہ گوشت خور افراد مچھلی خور افراد کے مقابلہ میں زیادہ ہارٹ ڈیزیز کا شکار ہو کر دل کے دورہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔

جب کہ دل کے دورہ سے بچ جانے والے افراد اپنی خوراک میں مچھلی کو شامل کر کے دوبارہ دورہ سے بچ سکتے ہیں۔

تمام اقسام کی مچھلی یکساں خاصیت کی حامل نہیں ہوتی، میرا مطلب ہے کہ کسی قسم میں یہ کولیسٹرول کم کرنے والے اجزاء کم، کم یا زیادہ اور کسی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔

میں ایسے مریض جو بائی بلڈ کولیسٹرول والے تھے انہیں چار ہفتوں تک مچھلی کا تیل استعمال کروایا گیا لیکن فیش آئل سالن نامی قسم کی مچھلی سے حاصل شدہ تھا۔

اس کے بعد خون کا معائنہ کرنے سے پتہ چلا کہ ان مریضوں کا بلڈ کولیسٹرول لیول 27 فی صد تک کم ہوا ہے جب کہ ان کا ٹرائی گلیسرائیڈز 64 فی صد تک کم ہوا ہے، تمام اقسام کے کوڈ اور آئلز میں ملکی نوعیت کی بلڈ کولیسٹرول کم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

عام طور پر گہرے خنڈے پانی والے سمندروں کی مچھلی میں ٹرائی او میگا فیٹی ایسڈز بہت زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں اور یہی اجزاء ہمارے دل کے لئے موزوں ہوتے ہیں اور ہارٹ ڈیزیز سے بچاتے ہیں۔

اپنی اجزاء کی بدولت بلڈ کو لائٹک ٹائم میں اضافہ ہو جاتا ہے اور خون میں لوتھڑے نہیں بنتے، نہ ہی دل کی شریانوں کی تنگی واقع ہوتی ہے۔

فٹس آئل کی بدولت صرف کولیسٹرول لیول ہی کم نہیں ہوتا بلکہ ہائی بلڈ پریشر میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔

ان تمام باتوں کے پیش نظر ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ مچھلی اور مچھلی کا تیل نہ صرف بلڈ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ ہائی بلڈ پریشر، خون میں لوتھڑے، بنا، دل کی شریانوں کی تنگی کو بھی روکتا ہے۔

مچھلی کا استعمال ایک ہفتہ میں دو سے تین مرتبہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس کا استعمال غذائی ضرورت پوری کرنے کے ساتھ ساتھ CHD کی کمی کا باعث بھی بنتا ہے۔

اگر مچھلی نہ کھائی جائے یا آپ سبزیوں کو زیادہ پسند کرتے ہوں تو مچھلی کے تیل کے کپسول بازار میں آسانی سے سستے مل جاتے ہیں ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن مچھلی کے کھانے سے جو فوائد حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ وہ ان کپسول سے نہیں حاصل کئے جاسکتے۔

پروفیسر ڈاکٹر آف میڈیسن آف بوسٹن یونیورسٹی جناب ولیم لی کینل جو فریمنگہم ہارٹ سٹڈی کے بانی ہیں کہتے ہیں کہ

میرا مشورہ ہے کہ مچھلی کے تیل کی بجائے پوری مچھلی کھائی جائے۔

بلڈ کولیسٹرول لیول کو کم کرنے، خون کے لوتھڑے بننے سے روکنے، ہائی بلڈ پریشر کے کنٹرول اور دل کی شریانوں کی تنگی کو روکنے کے لئے ایک عام گھریلو اور روزمرہ مشاہدہ میں آنے والی چیز کے متعلق جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ عام چیز اتنی خوبیوں کی مالک ہے اور اس کے اثرات اتنے تیز ہوتے ہیں، جس کے استعمال سے CHD میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے، جی ہاں وہ ہے لہسن۔

لہسن میں پائے جانے والے مفید اجزاء کی کہانی

اگرچہ برصغیر میں لہسن کے استعمال سے ہر فرد واقفیت رکھتا ہے۔ مگر یورپ میں لہسن کو کیفیر کنٹرول بلڈ پریشر کو کم کرنے، بلڈ کولیسٹرول کو نارمل سے بڑھنے نہ دینے، CHD کے تدارک اور خون کو مٹنے سے روکنے کے لئے استعمال کرنے پر بہت سی تحقیقات ہو چکی ہیں۔

اسی لئے تو 1990ء میں دنیا بھر سے 50 کے قریب سائنسدان اور مچھلیین اکٹھے ہوئے اور

انہوں نے واشنگٹن میں بیٹھ کر صحت برقرار رکھنے اور CHD بیمار یوں پر قابو پانے والے لہسن کے خواص پر اپنے اپنے تجربات پیش کئے۔

لہسن میں تقریباً 200 کے قریب مختلف کیمیکل اجزاء موجود ہیں۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر ایشیا، جاپان، چائنا اور یورپ، برصغیر میں لہسن کی ادویاتی حیثیت کے پیش نظر اسے روزانہ کی خوراک میں شامل کیا گیا ہے۔

لیکن یورپی ممالک میں حال ہی میں اس کا استعمال شروع ہوا ہے، ہمارے پیارے وطن پاکستان میں لہسن کی کاشت پورے ملک میں ہوتی ہے اور عام گھروں میں بھی لہسن اور پیاز کاشت کر لئے جاتے ہیں۔

جرمنی میں 20 فی صد سے زیادہ بالغ افراد لہسن کی گولیاں استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اسے کپا استعمال نہیں کر سکتے۔

جگر میں کولیسٹرول کی پیدائش کو روکنا

لہسن جگر میں کولیسٹرول کی پیداوار کو روکتا ہے۔

ایک عام آدمی میں 70 سے 80 فی صد کولیسٹرول جگر سے ترکیب پاتا ہے جب کہ 20 سے 30 فی صد باقی ماندہ کولیسٹرول غذائی ذرائع سے آتا ہے۔

لہسن میں موجود اس کا ایک جز سلفر جگر سے ترکیب پانے والے کولیسٹرول کو روکتا ہے، اس لئے ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے۔

LDL اور ٹرائی گلیسرائیڈز میں کمی واقع ہوتی ہے جب کہ HDL میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس تمام عمل سے دل کی بیماریاں پیدا ہونے کے خدشات معدوم پڑ جاتے ہیں۔ لہسن کے ان اجزاء کی اس خاصیت کی بنا پر اس پر بہت سا کام ہوا ہے۔

432 مریض جو دل کے دورہ کا شکار ہوئے تھے ان کو دو گروپوں میں تقسیم کیا گیا، ایک گروپ کے افراد کو روزانہ لہسن کا جوس استعمال کروایا گیا، جب کہ دوسرے گروپ کو لہسن کا جوس نہ دیا گیا۔

کچھ مدت بعد ان دونوں گروپوں کا موازنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ لہسن کا جوس استعمال کرنے والوں میں بلڈ کولیسٹرول لیول اور بائی بلڈ پریشر میں بہت ہی نمایاں کمی واقع ہوئی۔

ان میں ہارٹ ڈیزیز کے باعث ہارٹ ایک کا دوبارہ حملہ بہت کم ہوا۔ اور ہارٹ ایک کے باعث ان کی شرح اموات لہسن نہ استعمال کرنے والوں کے مقابلہ میں 50 فی صد کم تھی۔ لہسن نہ صرف بلڈ کولیسٹروئل اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے بلکہ عام جسمانی صحت اور جنسی صحت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔

لہسن کے استعمال سے جوڑوں کی دردوں اور دمہ کو کم کیا جاسکتا ہے۔

خون کے لوتھڑے نہ بننے دینا

ہر سال لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ CHD سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ لہسن خون میں لوتھڑے بننے سے روکتا ہے۔ بلڈ کولائنگ کے پورے عمل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ فائبر-ٹوجین کی پیدائش کے عمل کو کم کرتا ہے جو کہ خون جمانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یہ ایک طرح کی خون کی پروٹین ہوتی ہے۔

فائبروینوجین کی زیادتی اور Thromboxone کے باعث وریدوں میں تھرمبوسس کا عمل ہوتا ہے۔ ٹلموٹری ایسولزم ہوتا ہے اور دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔

اب پوری دنیا میں یہ بات مانی جا چکی ہے کہ اسپرین کی نسبت لہسن خون کو پتلا کرنے میں زیادہ خاصیت رکھتا ہے۔ اور اسپرین کی طرح سائیکلوفکسٹ یعنی مابعد اثرات بھی نہیں رکھتا۔

نائیٹروسیمانن Nitrosamine کی پیداوار میں رکاوٹ

لہسن میں موجود کچھ کیمیکل جسم میں نائیٹروسیمانن Nitrosamine کی پیداوار کو روک دیتے ہیں۔

نائیٹروسیمانن Nitrosamine ایک ایسی تباہ کن چیز ہے، جو کیسر یعنی سرطان پیدا کرتی ہے، خاص کر معدہ کا سرطان اسی کی پیداوار ہوتا ہے۔

بننے ہوئے اور تلے ہوئے گوشت میں بھی نائیٹروسیمانن پیدا کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

اٹلی اور چین میں بہت سے افراد لہسن کے متوازن استعمال سے اپنے آپ کو معدہ کے سرطان سے محفوظ رکھتے ہیں۔

لہسن کا استعمال نہ صرف معدہ کے سرطان سے بچاتا ہے بلکہ تحقیقات سے اس بات کے

مکمل شواہد ملتے ہیں کہ ایسوفلیس، منہ لیرنگس، معدہ، قولون کے سرطان سے بھی لہسن کا استعمال محفوظ رکھتا ہے۔

دیگر کئی چھوٹے دارا امراض سے بچاتا ہے

لہسن کا استعمال قوت مدافعت بڑھاتا ہے اور بہت سی انفیکشن سے جسم خود بخود مقابلہ کر کے محفوظ رہتا ہے۔

لہسن کا متواتر استعمال نزلہ، کھانسی جیسی امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ مغربی دنیا میں اسے بہت ہی مقبولیت حاصل ہو گئی ہے اور آپ پڑھ کر حیران ہوں گے کہ نیویارک میں ہر سال لہسن اگانے والے 14 ستمبر کو لہسن کا دن مناتے ہیں۔

لہسن کی بدبو اس میں موجود سلفر کے باعث ہوتی ہے۔

استعمال لہسن کے بارے ہدایات

اگر لہسن کو خالی معدہ لیا جائے گا تو یہ معدہ میں السر بھی پیدا کر سکتا ہے۔

بہت سے افراد میں مختلف غذاؤں سے الرجی کا رجحان ہوتا ہے، اسی طرح کچھ لوگ لہسن کے استعمال سے بھی الرجی کا شکار ہو سکتے ہیں۔

اگر آپ لہسن سے الرجک ہیں تو اس کے استعمال کرنے سے پہلے ضرور اپنے معالج سے رجوع کریں۔

لہسن کا استعمال اعتدال سے کریں بہتر یہ ہے کہ شروع میں ایک عدد۔

ریشہ دار غذاؤں کے فوائد

(Fiber) ریشہ سے بھرپور غذاؤں کی بیماریوں کے خدشات کو بہت حد تک کم کر دیتی

ہے۔

جس سے زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں ہونے والی ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ ایسے افراد جو Fiber سے بھرپور غذا استعمال کرتے ہیں وہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جاپان میں لوگ زیادہ تر ریشہ دار غذاؤں کا استعمال کرنے کے باعث CHD کی بیماریوں سے بہت زیادہ محفوظ رہتے ہیں۔

جب کہ اس کے برعکس امریکہ میں لوگ ریشہ دار غذا نہیں جاپانیوں کی نسبت کم استعمال

کرنے کے باعث CHD یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز میں بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں۔
 جو لوگ ریشہ دار غذائیں استعمال نہیں کرتے ان کو ایسے افراد کی نسبت جو ریشہ دار غذائیں
 استعمال کرتے ہیں ہوں 4 سے 5 گنا زیادہ ہارٹ ڈیزیز کے خدشات ہوتے ہیں۔
 ریشہ دار غذاؤں کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایسے افراد جو 17
 گرام حل ہونے والے ریشہ استعمال کریں ان کے بلڈ کولیسترول لیول میں چند ہفتوں میں 13 سے 26
 فی صد تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔

اوپر بیان کردہ تمام تحقیقات کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ریشہ دار
 غذائیں ہارٹ ایک سے بچاتی ہیں۔

Fiber فائبر کی اقسام

ان کی دو بڑی اقسام ہیں۔

(1) پانی میں حل ہونے والے فائبر (2) پانی میں حل نہ ہونے والے فائبر

(1) پانی میں حل ہونے والے فائبر (Water Soluble Fiber)

تمام اقسام کی گوند پیکٹین Pectin اور چپ دار فائبر پانی میں حل ہونے والے ہوتے
 ہیں۔

تمام وائٹریلولوئل فائبرز بائیل ایسڈ کو انترویوں میں جکڑ کر جگر کو بائیل ایسڈ بنانے کے لئے
 کولیسترول کی ضرورت ہوتی ہے۔ جگر مزید بائیل ایسڈ بنانے کے لئے کولیسترول کو کام میں لاتا ہے
 اور بائیل ایسڈ کے ساتھ وائٹریلولوئل فائبر جز کر پاخانہ کے ذریعہ خارج ہوتے رہتے ہیں۔

اس طرح جگر کولیسترول کا استعمال بڑھا دیتے ہیں۔ اور کولیسترول لیول میں بہت حد تک کمی
 واقع ہو جاتی ہے۔ یاد رہے کہ صرف از صرف پانی میں حل پذیر فائبر ہی کولیسترول کی مقدار کو کم کرتے
 ہیں۔

(2) پانی میں نا حل پذیر فائبرز

یہ فائبر خاص کر ہاضمہ کی خرابیوں کے لئے مفید ہوتے ہیں یعنی ان کا زیادہ استعمال بلڈ
 کولیسترول لیول کو تو کم نہیں کرتا البتہ نظام انہضام کی خرابیوں کو دور کرنے کا باعث بنتا ہے۔

یہ قبض کو دور کرتے ہیں قولون کے کینسر کو روکتے ہیں اور Diverticular بیماری کو روکتے

ہیں۔

پانی میں حل ہو جانے والے فائبرز

Water Soluble Fibers

اقسام	پودوں میں پائے جانے والے	خوراک میں موجودہ	عمل یا کام
Pectin	سیل وال میں ہوتے ہیں ایک خاص قسم کی جل افروز کرتے ہیں	بھلوں میں کچھ بزیوں اور پھلیوں میں	بائیکل ایسڈ کو جکڑ لیتا ہے پانی کو کھینچتا ہے
پائٹ گم پودوں کی گوند	چمکدار مواد پودہ کے کٹ لگائے حصہ سے حاصل ہوتا ہے	بھلوں اور بزیوں میں بھی پایا جاتا ہے	شیرہ بناتا ہے
Mucilages یعنی سریش	یہ مواد بھی پودوں کی گوند جیسا ہی ہوتی ہے	بھلیوں میں بیج دار پودوں میں اور بیج دار بزیوں میں	پلازمہ ، انسولین اور گلوکوز لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔

سوگرام خوراک میں فائبرز کی مقدار گراموں میں

پھل

ایک سوگرام سیب میں	1.42 گرام
ایک سوگرام کیلا میں	3.40 گرام
ایک سوگرام انجور سفید	0.90 گرام
ایک سوگرام گریپ فروٹ	0.60 گرام
ایک سوگسترہ مالٹا	1.90 گرام
ایک سوگرام ناشپاتی	2.44 گرام
ایک سوگرام آڑو جھلکے سمیت	2.28 گرام

1.52 گرام	ایک سوگرام آلو بخارا چھلکوں سمیت
2.12 گرام	ایک سوگرام سٹاروری
1000 گرام	ایک سوگرام تربوز

سبزیاں

2.90 گرام	ایک سوگرام پھلیاں
3.10 گرام	ایک سوگرام چقندر
3.44 گرام	ایک سوگرام گوبھی بند
2.90 گرام	ایک سوگرام گاجر
2.10 گرام	ایک سوگرام پھول گوبھی
0.40 گرام	ایک سوگرام کھیرا
2.50 گرام	ایک سوگرام مش روم
1.30 گرام	ایک سوگرام پیاز
3.41 گرام	ایک سوگرام آلو
6.30 گرام	ایک سوگرام پالک
2.20 گرام	ایک سوگرام شلجم
7.75 گرام	ایک سوگرام مٹر
2.20 گرام	ایک سوگرام موٹھ

انانج اور گندم کی مصنوعات میں

7.66 گرام	ایک سوگرام جو کا دلیا
0.80 گرام	ایک سوگرام پاش شدہ چاول
44.00 گرام	ایک سوگرام گندم کا چوکر
13.51 گرام	ایک سوگرام گندم کا آٹا
3.45 گرام	ایک سوگرام میدہ

مغزیات

ایک سو گرام مغز بادام	14.30 گرام
ایک سو گرام ناریل	13.60 گرام
ایک سو گرام مونگ پھلی	7.60 گرام

سو گرام مختلف خورا کوں میں فائبرز کی مقدار گراموں میں

ایک سو گرام مغز اخروٹ میں	5.20 گرام
ایک سو گرام دودھ گائے	0 گرام
ایک سو گرام دودھ بھینس	0 گرام
ایک سو گرام مکھن	0 گرام
ایک سو گرام پنیر	0 گرام
ایک سو گرام بڑا گوشت	0 گرام
ایک سو گرام چھوٹا گوشت	0 گرام
ایک سو گرام مرغی کا گوشت	0 گرام
ایک سو گرام مچھلی تمام اقسام کی	0 گرام
ایک سو گرام انڈے	24 گرام
ایک سو گرام خوبانی خشک	8.9 گرام
ایک سو گرام خوبانی تازہ	8.7 گرام
ایک سو گرام انجیر خشک	18.5 گرام

پانی میں نہ حل ہونے والے فائبرز (Water Insoluble Fibers)

قسم	نباتاتی ذرائع	غذائی ذرائع	کام
سیلولوز	پودوں کی سیل وال میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے	آٹے کے چوکر میں لہور 2.5 فی صد پلانٹ فائبر میں	معدہ اور انتڑیوں کی حرکاتی رفتار بڑھاتا ہے

لگین Lignin	یہ بھی سیلوز کیساتھ سیل وال بناتا ہے سیل اور کیسل والا کے درمیان دوڑنے والا میٹرمل ہوتا ہے۔	سبزیوں اور پھلوں میں بھی لگین پایا جاتا ہے۔	بائیل ایسڈز اور دیگر کئی میٹرمل کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔
Hemicellulose ہیمی سیلولوز	سیل والے کے کئی حصوں میں یہ مادہ پایا جاتا ہے یہ آسانی سے سادہ شکر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔	50 سے 70 فی صد تک اناج اور سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔	یہ مادہ قبض کو دور کرتا ہے۔

اسپغول کا کردار

اسپغول کا استعمال لوگ صدیوں سے کرتے ہیں۔ اسپغول ثابت اور چھلکا دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔

اسپغول پر ہونے والی دنیا بھر کی تحقیقات سے یہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے کہ اسپغول زخموں کو مندمل کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا بلکہ بلڈ کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے۔

اسپغول کا مسلسل آٹھ دس ہفتوں تک کا استعمال چھلکا کی صورت میں 15 سے 20 فی صد LDL کولیسٹرول کو کم کر دیتا ہے۔ اسپغول زیادہ مہنگا نہیں نہ ہی حاصل کرنے میں کوئی دقت آتی ہے البتہ چند نا عاقبت اندیش لوگ اس میں ملاوٹ کر کے اسے کم اہمیت والا بنا دیتے ہیں۔ ان ملاوٹ کرنے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔

اسپغول کا مسلسل استعمال 10 سے 25 فی صد تک بلڈ کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے۔

جو: اور جو کی مصنوعات

جو کا دلیا پورے یورپ میں مقبولیت حاصل کر چکا ہے۔ کیونکہ اس میں فائبر سولوبوٹری کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جو کا چوکر یا بھوسا اس سے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس میں فائبر کی

مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے۔

امریکہ میں لاکھوں لوگ ناشت میں اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس پر بہت سی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ جس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جو کھانسی کا چوکریلڈ کولیستروں لیول کو نہایت مستعدی سے کم کر دیتا ہے۔

امریکہ کے مایہ ناز ڈاکٹر Dr. Anderson نے اس پر بہت سی تحقیق کی۔

کیونکہ جو کھانسی کا چوکریلڈ عام طور پر کھانسی کے آنے بنانے والے پلانٹوں پر انگ کیا جاتا تھا اور اس کا استعمال جانوروں میں کیا جاتا تھا۔

ڈاکٹر اینڈرسن صاحب نے وہاں سے کافی مقدار میں جو کھانسی کا چوکریلڈ حاصل کیا۔ اور بہت سے لوگوں کو استعمال کروایا، خود ڈاکٹر صاحب کا بلڈ کولیستروں لیول 180 ملی گرام تھا۔

انہوں نے 100 گرام تک جو کھانسی کا چوکریلڈ روزانہ لگا تا 5 ہفتوں تک استعمال کیا تو ان کا بلڈ کولیستروں 30 فی صد تک کم ہو گیا۔

ہمارے ہاں تو جو کھانا اور دوا بہت دیر سے استعمال ہوتا آیا ہے۔ امریکہ میں تو آج کل یہ بات رواج پائی اور تحقیق ہوئی کہ جو کھانسی کا دوا اور چوکریلڈ کولیستروں کے لئے بہت مفید ہے۔

میں قربان جاؤں رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر آپ کے فرمان کی روشنی میں طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کھانسی کا دوا کی اہمیت سے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے سے لوگ آگاہ ہو چکے ہیں۔

جب کہ میڈیکل سائنس آج اس کی افادیت بتا رہی ہے۔

جوار (Guar)

اس میں بہت زیادہ حل پذیر فائبرز ہوتے ہیں۔ اس کی گوند میں بلڈ کولیستروں کو کم کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔

13 سے 18 گرام گوند کا روزانہ استعمال تین ماہ میں بلڈ کولیستروں لیول کو 15 سے 20 فی

صد کم کر دیتا ہے۔

ریشہ دار یعنی فائبرز سے بھرپور غذاؤں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے

روزانہ ایک صحت مند انسان کے لئے تقریباً 40 سے 50 گرام فائبرز کی ضرورت ہوتی

ہے اور لوگوں کی اکثریت اس سے واقف نہیں۔

ہاں البتہ روزمرہ کی غذاؤں سے 40 فی صد تک فائبرز کی مقدار اکثر لوگ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور پرسکون سہل اور شہری زندگی گزارنے والے لوگوں میں یہ شرح اس سے بہت کم ہے۔

روزانہ کون کون سی غذا استعمال کرنے سے مطلوبہ مقدار فائبرز حاصل ہوگی

1- مکمل آٹے یعنی چوکرو سبجی سمیت آٹے کی روٹی کھائی جائے۔

2- آلو کا کثرت سے استعمال کیا جائے روٹی اور آلو دونوں کو ایک ساتھ استعمال بھی کیا جاسکتا ہے ان میں گھی یا مکھن کا استعمال نہ کیا جائے۔

3- گوشت کا استعمال کم کریں۔ پھلیوں، مٹر، موٹھ وغیرہ کا استعمال بڑھا دیں۔

4- سبزیوں کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ خاص کر ایسی سبزیاں جو پتوں والی ہوں۔

یادر ہے کہ سبزیوں کو زیادہ نہ پکائیں اور پھران میں گھی، مکھن کا کم از کم استعمال کریں۔

اُپلی ہوئی پٹر گھی، مکھن کے سبزیاں زیادہ کارگر ہوتی ہیں۔ ان میں فائبرز کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن زیادہ پکانے سے وہ ضائع ہو جاتی ہے، اور مکھن گھی وغیرہ زیادہ استعمال ویسے ہی اس کی بلڈ کولیسترول کم کرنے کی افادیت کم کر دیتا ہے کیونکہ جس قدر کولیسترول سبزی کے استعمال سے کم ہوگا۔ اس سے زیادہ آپ اس میں گھی ڈال کر حاصل کر لیتے ہیں۔

5- تازہ پھلوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ سنگترے اور تریبوز میں بھی فائبرز موجود ہوتے ہیں۔

سبزیوں اور پھلوں میں فائبرز اور پانی کی موجودگی دونوں ہی مل کر آپ کو سمارٹ بنانے میں مدد گار ہوں گے۔

6- آٹے کو چھان کر دیکھ لیں اس میں کوئی چھوٹا موٹا کیڑا مکوڑا نہ ہو لیکن چھننے سے جو چوکرا حاصل ہو اس کو دوبارہ آٹے میں مکس کر کے گوند کر پھر روٹی تیار کریں۔

7- بہت سی سبزیوں اور پھلوں کو چھیل کر استعمال نہ کریں مثلاً آلو، شکر کنڈی، آڑو، آلو بخارا وغیرہ سبزیوں میں شلجم، آلو، ٹینڈے وغیرہ

کیونکہ ان کے پھلکوں میں بہت ہی مفید اجزاء ہوتے ہیں جو انسانی صحت اور تندرستی کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔

اپنا وزن کم کیجئے

موٹاپا صحت کا دشمن اور بہت سی بیماریوں کی جڑ ہے۔ موٹاپا سے یہاں جسمانی طور پر انسان کی خوبصورتی میں فرق آ جاتا ہے، اس کے ساتھ صحت میں بہت فرق پڑتا ہے۔ اس باب میں ہم موٹاپا کو کم کرنے کے بارے ضروری اور سیر حاصل گفتگو کریں گے۔

نہ صرف ہمارے ملک پاکستان میں موٹاپا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے بلکہ یہ تو بہت سے ترقی یافتہ ممالک جن میں امریکہ بھی شامل ہے پھیلتا جا رہا ہے۔

اس کی بہت سی وجوہات میں غیر متوازن خوراک، سہل پسندی اور زیادہ کھانا شامل ہے۔ تمام ذی شعور افراد یہ جاننا چاہیں گے کہ ان کی عمر اور قد کے مطابق ان کا وزن کتنا ہونا چاہیے۔

اس سلسلہ میں یہاں پر ایک چارٹ دیا جاتا ہے جس کی مدد سے عمر اور قد کے حساب سے تمام افراد اپنے بالکل ٹھیک وزن کے متعلق جاننے میں دقت محسوس نہیں کریں گے۔

عورتوں اور مردوں دونوں کے بلحاظ عمر اور قد وزن کے چارٹ الگ الگ پیش

کئے جاتے ہیں

بالکل مناسب لمبائی اور وزن کا چارٹ عورتوں کیلئے

لمبائی یا اونچائی		وزن	
انچ	سینٹی میٹر	پونڈ	کلوگرام

25 سال کی عمر سے زائد عورتیں

4 10	147.3	96 107	43.5 48.5
4 11	149.9	98 110	44.5 49.9
5 0	152.4	101 113	45.8 51.3
5 1	154.9	104 116	47.2 52.6
5 2	157.5	107 119	48.9 54.0

5 3	160.0	110 122	49.9 55.3
5 4	162.6	113 126	51.3 57.2
5 5	165.1	116 130	52.6 59.0
5 6	167.6	120 135	54.4 61.2
5 7	170.2	124 139	56.2 63.0
5 8	172.7	128 143	58.1 64.9
5 9	175.3	132 147	59.9 66.7
5 10	177.8	136 151	61.7 68.5
5 11	180.3	140 155	63.5 70.3
6 0	182.9	144 159	65.3 72.0

25 سال سے زائد عمر والے مردوں کیلئے

نوٹ: مرد اور عورت دونوں کیلئے قد کی لمبائی بغیر جوتے کے ہے

لمبائی یا اونچائی		وزن	
فٹ	انچ	پونڈ	کلوگرام

25 سال سے زائد عمر والے مردوں کے لئے

5 2	157.5	118 129	53.5 58.5
5 3	160.0	121 123	54.9 60.3
5 4	162.6	124 136	56.2 61.7
5 5	165.1	127 139	57.6 63.0
5 6	167.6	130 143	59.0 64.9
5 7	170.2	134 147	60.8 66.7
5 8	172.7	138 152	62.6 68.9

5 9	175.3	142 156	64.4 70.8
5 10	177.8	146 160	66.2 72.6
5 11	180.3	150 165	68.0 74.8
6 0	182.9	154 170	69.9 77.1
6 1	185.4	158 175	71.7 79.4
6 2	188.0	162 180	73.5 81.6

وزن کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے ہلکا لباس پہنا ہو، کوٹ، اوور کوٹ، سویٹر وغیرہ اتار کر وزن کرنا چاہیے۔

دن کے وقت وزن گھٹتا بڑھتا رہتا ہے اور رات کے وقت اکثر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لئے بہتر ہوگا کہ صبح سویرے ناشتہ سے پہلے وزن کرنا چاہیے۔

کیا موٹاپا وراثتی بھی ہوتا ہے؟

بہت سے عام لوگوں کا خیال ہے کہ موٹاپا نسل در نسل چلتا رہتا ہے اور بہت سے لوگ اس خیال سے متفق نہیں ہیں۔

حالیہ ہونے والے تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ موٹاپا جنٹیک ڈیزیز نہیں ہے۔ ڈاکٹر ڈیوڈ جوکار نیل یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، ان کے مطابق آپ بہت آسانی سے وزن کو کم کر سکتے ہیں، اپنی خوراک میں چربی اور حراروں والی خوراک کا استعمال روک دیں، انتہائی ضرورت کے مطابق حراروں والی خوراک استعمال کریں۔

وزن کم کرنے کے 20 طریقے

اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقین مانیں آپ کو دل کے دورہ کے خدشات بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔

کچھ لوگ بہت آسانی سے بڑھتے ہوئے وزن کو قابو کر کے اسے کم کر لیتے ہیں لیکن چند ہفتوں بعد دوبارہ پہلی حالت پر آ جاتے ہیں۔ مکمل اور متوازن کمی وزن کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اپنے کھانے پینے کی عادات کو یکسر بدلا جائے۔

تیزی سے وزن کا کم ہوتے جانے اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ جسم میں پانی اور پروٹین کی مقدار کم ہو گئی ہے۔ یعنی جسم میں پروٹین کی مقدار میں کمی اور پانی کی کمی سے وزن بہت تیزی سے کم ہوتا جاتا ہے۔ لیکن یہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس لئے درج ذیل ہدایات پر عمل پیرا ہو کر اپنے وزن کو احسن طریقہ سے بغیر کسی نقصان کم کر سکتے ہیں۔

کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں اور انہیں تولیے سے صاف نہ کیا جائے ویسے ہی خشک ہونے دیں۔

کھانا کھانے سے پہلے پانی ضرور پی لیں۔ اسلامی طریقہ کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھانا چاہیے۔

کھانے سے پہلے پانی پینا سونا، درمیان میں پانی پینا چاندی اور بعد میں پانی پینے کو پتھر فرمایا گیا ہے۔

- 1- اپنی خوراک میں حراروں والی غذاؤں کی کمی کریں۔ اس کے بغیر وزن میں کمی ممکن نہیں۔
- 2- ورزش کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ ورزش سے زائد کلوریزی یعنی حرارے جل جاتے ہیں۔ چربی بھی پگھل کر استعمال میں آ جاتی ہے اور اگر ورزش نہ کی جائے تو یہ چربی ذخیرہ ہو جاتی ہے۔
- 3- جب آپ اپنی خوراک میں کلوریزی والی غذاؤں کا استعمال گھٹائیں تو ضروری ہے کہ آپ وٹامن اور معدنیاتی خوراک کا استعمال زیادہ رکھیں۔
- 4- چربی اور کولیسٹرول سے بھرپور غذاؤں کا استعمال کم کر دیں اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز رکھیں۔
- 5- بازار میں دستیاب غیر معیاری وزن کم کرنے والی غذاؤں سے پرہیز کریں۔
- 6- اپنی خوراک کا چارٹ مرتب کر لیا کریں کون کون سی چیز کتنی مقدار میں استعمال کی ہے کیونکہ اگر آپ کا وزن کم نہ ہو رہا ہو تو آپ اس میں مزید ردوبدل کر سکتے ہیں۔
- 7- سٹیکڈ اور چاکلیٹ سے پرہیز رکھیں۔

8- باورچی خانہ میں وقت کم گزاریں۔ کیونکہ اس سے کھانے کی عادت بڑھتی ہے۔

9- کھانے سے پہلے اپنے ذہن کو اس بات پر آمادہ کر لیں کہ آپ نے کم کھانا ہے۔ بے شک آپ کی پسندیدہ ڈش کیوں نہ ہو۔

10- کسی پارٹی میں فنکشن میں جانے پر گھر والوں کے اصرار پر زیادہ کھانے سے گریز کریں کیونکہ ہمارے ہاں وضع داری میں ہم مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ کھانے کے لئے کہتے ہیں۔ کہ جی اور کھائیں۔ یہ لیجئے خاص کر آپ کے لئے ہے۔ آپ کو یہ چیز پسند ہے وہ پسند یہ کھالیں تو ان کو ناراض کئے بغیر کم کھائیں۔

11- کھانا تھوڑا تھوڑا ڈال کر کھائیں اور آخر پر برتن کو اچھی طرح صاف کر لیں۔

12- چینی سے بھرپور کھانوں سے پرہیز رکھیں کیونکہ ایک چمچ چینی میں 16 حرارے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مشروبات کے ذریعہ روزانہ چینی کی بہت بڑی مقدار کھا لیتے ہیں مگر انہیں احساس نہیں ہوتا۔

13- اپنی رہ زمرہ کی خوراک میں دلیا، پھل اور سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔

14- اپنی سمارٹ ہونے کی ایک عدد تصویر اپنے پاس رکھیں، اسے کبھی بکھار دیکھتے رہیں اور اپنے آپ سے کہیں کہ آپ نے ایسے ہی رہنا اور اس کے لئے بے شک بہت زیادہ کوشش ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔

15- آپ یہ کبھی بھی خیال نہ کریں کہ موٹے نازے آدمی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔

16- بہت سے لوگ درمیانہ عمر میں ورزش چھوڑ کر موٹے ہو جاتے ہیں۔ ورزش کو جاری رکھنا چاہیے لیکن عمر کے مطابق۔

17- ایسے لوگوں کی صحبت سے گریز کریں جو کھانے کے لئے جیتے ہیں وہ آپ کی عادات کو ضرور بگاڑ دیں گے، ویسے بھی آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔

18- وزن کو کم رکھنے کا مسلسل خیال کریں۔

19- جب آپ کا وزن کم ہو جائے تو اپنا لباس اپنے جسم کے مطابق تبدیل کریں۔

اور پہلے استعمال شدہ لباس ترک کر دیں۔

ورزش کی عادت

روزانہ ورزش کرنے کے بے حد فوائد ہیں۔ اس سے پورے جسم پر اثر پڑتا ہے۔ پسینہ کے ذریعہ فالٹو مادوں کا اخراج ہوتا ہے اور خون صاف ہوتا ہے۔

نظامِ انتظام سمیت تمام نظامِ مہائے جسم اپنے کاموں کو احسن طریقہ سے سرانجام دیتے ہیں۔ ورزش سے تمام صحت جسم خاص کر دل پر نہایت ہی بہتر اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن یاد رہے ورزش عمر پیشے اور اپنی صحت عامہ کو مد نظر رکھ کر کریں۔ زیادہ سخت ورزش بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ خاص کر دل کے امراض والے افراد میں سخت نوعیت کی ورزش موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس لئے مریضوں کو اپنی بیماری کے حساب سے اپنے معالج سے مشورہ کر کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔

صرف ورزش کے فوائد پڑھ کر تمام لوگوں یعنی مریضوں کو بھی ورزش کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ عام صحت مند افراد کا صحت مند افراد سے موازنہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے جو افراد ورزش سے جی چراتے ہیں وہ ایسے افراد کی نسبت جو ورزش کرتے ہوں بہت زیادہ تعداد میں دل، گردوں اور دیگر کئی بیماریوں، موٹاپا، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ کولیسٹرول وغیرہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کسی بھی قسم کی ورزش کا پروگرام ترتیب دینے سے پہلے اپنے معالج سے ضروری مشورہ کر لیا جائے وہ آپ کو آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر مشورہ دیں گے۔

اگر آپ کے دل کی حرکات بے قاعدہ ہوں اور آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہو، آپ کسی بھی قسم کی ورزش سے اجتناب کریں۔

اس کے بعد آپ باقاعدہ اپنے معالج سے مشورہ کرتے رہیں اگر آپ کا معالج مشورہ دے تو ورزش شروع کریں ورنہ اپنا علاج جاری رکھیں۔

اگر آپ درج ذیل علامات رکھتے ہوں تو ورزش نہ کریں۔

1- کبھی بھی آپ کے معالج نے آپ کو دل کے کسی عارضہ میں مبتلا ہونے کے بارے آگاہ کیا ہو۔

2- اگر آپ کی چھاتی کے کسی حصہ میں درد محسوس ہوتا ہو۔

3- اگر آپ کی E.C.G میں کوئی نقص ظاہر ہوا ہو۔

4- اگر آپ کے دل کی حرکات بے قاعدہ ہوں۔

5- اگر آپ کو اکثر غشی طاری ہو جاتی ہو۔

6- اگر آپ کے خاندان میں ہائی بلڈ پریشر، شوگر، ہائی کولیسٹرول، دل کے امراض کی ہسٹری پائی جاتی ہو اور آپ سگریٹ نوشی کی عادت بھی رکھتے ہوں تو ورزش کے لئے اپنے معالج سے رجوع کریں۔

7- اگر آپ کا معالج بتائے کہ آپ کا بلڈ پریشر بہت بڑھا ہوا ہے۔

8- اگر آپ کو کوئی ہڈیوں یا ریڑھ کی شکایت ہو تو ایسے میں ورزش نقصان دہ ہوتی ہے۔

9- اگر آپ کی عمر 60 سال یا اس سے زیادہ ہو اور آپ ورزش کے عادی نہ ہوں۔

ورزش کی اقسام: ورزش کی دو بڑی اقسام ہیں۔

(1) Aerobic Exercises (2) Non- Aerobic Exercises

(1) Aerobic Exercises

یہ ایسی ورزش ہے جس میں آکسیجن کی زیادہ مقدار اندر لے جانے کے لئے کئی طریقے استعمال کئے جاتے ہیں۔ مثلاً تیز چلنا، تیراکی، جوگنگ اور دوڑنا وغیرہ۔

اس قسم کی ورزش سے میٹابولک نظام میں کافی تیزی آ جاتی ہے اور اس کے لئے کافی توانائی درکار ہوتی ہے۔ اس قسم کی ورزش سے دل اور دورانِ خون کی نالیوں کو کافی فائدہ پہنچتا ہے۔

اس میں سائیکل چلانا، ڈانس، بسکیٹنگ وغیرہ بھی شامل ہے، اس قسم کی ورزشوں میں وزن میں کمی، چربی میں کمی اور پٹھوں کی مضبوطی ہوتی ہے۔

100 کلوریزی جلانے کے لئے آپ درج ذیل ورزشیں کر سکتے ہیں۔

1- 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 10، سے 20 منٹ تک چلیں۔

2- 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 20 سے 25 منٹ چلیں۔

3- 6.5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 17 منٹ تک چلیں۔

4- 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ دس منٹ میں دوڑ کر طے کریں۔

5- 20 منٹ تک تیز، تیز چلیں۔

6- اعتدال پسندانہ رفتار سے 4 کلومیٹر تک سائیکل چلانا۔

7- دس منٹ تک سیر چلیں اعتدال کی رفتار سے بار بار چڑھتے رہیں۔

- 3- ایک کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے 20 سے 25 منٹ تک تیرا کی کریں۔
 9- اکیلے 20 منٹ تک بیڈ منٹن کھیلیں۔

Non - Aerobic Exercises (2)

اس قسم کی ورزش باڈی بلڈنگ کیلئے کی جاتی ہیں۔

ان میں مختلف نوعیت کی ورزش مختلف پٹھوں کو مضبوط بناتی ہیں۔ ویٹ لفٹنگ بھی اسی مرہ میں آتا ہے لیکن ایسی ورزشوں میں بلڈ پریشر بڑھنے کے امکانات کو رد نہیں کیا جاسکتا۔
 ایسی ورزشیں دل کے عوارض والے افراد اور ہائی بلڈ پریشر والے افراد کے لئے موزوں نہیں ہوتی بلکہ نقصان دہ ہوتی ہیں۔

مسلل ورزش کے فوائد

مسلل لگاتار باقاعدگی سے مختلف انواع کی ورزشیں جو زیادہ سخت نوعیت کی نہ ہوں اور کرنے والے فرد کو دل یا دیگر کسی ڈیزیز کا عارضہ نہ ہو تو فوائد ضرور حاصل ہوتے ہیں اور پورے جسمانی نظام میں بہتری آتی ہے۔ خون کی گردش تیز ہو کر ہر سیلز تک خون کی سپلائی ہوتی ہے اور فالتو مادے پسینہ اور پیشاب کی صورت میں خارج ہو جاتے ہیں، آدمی چاک و چوبندر رہتا ہے۔
 درجہ ذیل فوائد مسلل ورزش سے حاصل ہوتے ہیں۔

(1) وزن کی کمی

مسلل اور لگاتار ورزش کا مطلب ہے کہ آپ ایسی فالتو چربی اور اضافی حراروں کو خرچ کر لیں گے۔ اگر آپ بسیار خوری کو ترک کر دیں اور متوازن غذا کا استعمال جاری رکھ کر ورزش کریں تو یقیناً وزن میں کمی واقع ہو جائے گی۔

وزن میں مستقل کمی کا انحصار ورزش کی اقسام پر منحصر ہے۔ لاکھوں بالغ جو درمیانہ عمر والے ہوں 9 سے 18 کلو گرام وزن معتدل ورزش سے کم کر سکتے ہیں لیکن یہ مقاصد 12 سے 18 ماہ میں حاصل ہوتے ہیں۔

اس قدر وزن میں کمی سے دل کی بیماریوں سے محفوظ رہا جاسکتا ہے اور دل کے دورے کا خدشہ تقریباً جاتا رہتا ہے۔

بلڈ کولیسٹرول میں کمی

باقاعدگی سے جسمانی ورزش تمام جسمانی نظام کے لئے فائدہ مند ہوتی ہے اور خاص کر دل اور دل کی نالیوں پر اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔

ورزش سے HDL لیول میں اضافہ اور LDL میں کمی واقع ہو جانے سے دل کے امراض سے بچاؤ میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔

ورزش کرنے سے لائی پیڈ میٹابولزم میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ اضافہ ورزش کر نیچے دوران اور بعد جاری رہتا ہے۔ جس سے بلڈ کولیسٹرول لیول میں کمی واقع ہوتی ہے۔

اور فالتو چربی کا استعمال ہو کر جسم سے چربی کی مقدار کم ہونے لگتی ہے جس کے باعث وزن میں نمایاں حد تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔

مختلف انزائم جو اعصاب اور فیٹی نشوز کی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں ان کی سرگرمیوں میں اضافہ کے باعث یہ عمل وقوع پذیر ہوتا ہے۔

مختصر اُتین انزائم مثلاً لائی پوپروٹین لائی پیاز (Lipoprotein Lipase) - لیسیٹھین (Lecithin cholesterol - Acyl - Transferase) اور ہپٹک لائی پیاز (Hepatic Lipase) اس پیچیدہ ساخت میں شامل ہے۔ جن کی بنا LDL کولیسٹرول میں کمی اور HDL کولیسٹرول میں زیادتی ہو جاتی ہے جو ایک خوش کن عمل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جسم میں فالتو چربی اور حرارے کا مآ کر جسم کو چاک و چوبند بناتے ہیں اور موٹاپہ نہیں چھانے دیتے۔

ورزش بلڈ پریشر کو قابو میں رکھتی ہے

خون کے دباؤ کی زیادتی خون کی نالیوں کو کمزور کرتی ہے ایسی خون کی نالیاں جو خون کے دباؤ سے متاثر ہو کولیسٹرول کو اپنے اندر بھرنے کی بہت زیادہ صلاحیت رکھتی ہیں۔

کولیسٹرول کی خون کی نالیوں میں موجودگی ان کی اندرونی سطح میں کمی لاتی ہے جس کی وجہ سے خون کی نالیاں سکڑی ہوئی یا تنگ ہو جاتی ہیں اور خون کا دباؤ مزید بڑھنے لگتا ہے۔

اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں کہ باقاعدہ ورزش سے کولیسٹرول لیول میں کمی واقع ہوتی ہے، فالتو چربی خارج ہوتی ہے، اور موٹاپا جانے لگتا ہے، اس لئے خون کی نالیوں میں کولیسٹرول کی کمی

اور جسے ہوئی چربی کے جل جانے سے ہائی بلڈ پریشر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔

ورزش دل کی شریانوں کی بیماریوں کے خدشات کم ہو جاتے ہیں

باقاعدگی سے ورزش کی عادت سے دل کے پٹھے بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں۔ آکسیجن کی مطلوبہ مقدار نہ صرف پورے جسم کو پہنچتی ہے بلکہ دل کے اپنے تمام پٹھوں اور شوز تک مطلوبہ مقدار آکسیجن پہنچتی رہتی ہے۔ دل تندرست اور توانا رہتا ہے اور اس کے پٹھوں میں مضبوط واقع ہوتی ہے۔ دل کی حرکات مستحکم رہتی ہیں اور اختلاج قلب کا عارضہ بھی نہیں ہونے پاتا۔ باقاعدگی ورزش دل کی شریانوں کو سخت اور تنگ نہیں ہونے دیتی جس کی بنا پر انسان ایقرو سکیروسس Atherosclerosis سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

دیگر امراض کا تدارک بذریعہ ورزش

ورزش سے پہلے سے بیان کردہ امراض کے علاوہ بہت سے دیگر کئی امراض ہیں جن سے بچا جاسکتا ہے۔

لیکن ان کی فہرست بہت طویل ہے اگر ان کو تحریر میں لایا جائے تو ایک مکمل کتاب کی ضرورت پیش ہوگی۔ اس کتاب میں صرف بڑے بڑے اور چیدہ امراض کا ذکر کیا جائے گا۔

ذیابیطس شکر (Diabetes Mellitus)

باقاعدگی سے ورزش کی عادت شوگر سے بچاتی ہے، پورے جسمانی نظام کی طرح لہلہ بھی اپنے فرائض عمدگی سے ادا کرتا ہے۔

عام طور پر 35 سال کی عمر کے بعد اکثر مونیا یا شکر لوگ شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ باقاعدگی سے ورزش مونیا کو روکتی ہے اور شوگر کا بھی امکان نہیں رہتا۔

پتے اور گردوں کی پتھریاں

مولے لوگوں میں پتے کی پتھریوں کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔

اسی طرح ورزش نہ کرنے والے افراد اور سہل پسندی والے افراد بھی گردوں اور پتے کی پتھریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن ورزش کے فوائد میں سے یہ بھی ہے کہ انسان پتے اور گردوں کی پتھریوں سے محفوظ رہتا ہے۔

باقاعدہ ورزش کرنے والے افراد میں گروے اور پختے کی پتھریاں نہ ورزش کرنے والوں کے مقابلہ میں بہت کم بنتی ہیں۔

دوران خون کی بیماریوں میں کمی

روزانہ ورزش سے دل اور دوران خون کی نالیوں کی صحت پر بہت زیادہ مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور دوران خون کی بہت سی بیماریوں سے بچا جاسکتا ہے۔

قوت مدافعت میں اضافہ

روزانہ اور باقاعدہ ورزش سے تمام جسم انسانی میں مضبوطی کے ساتھ قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں پر خود بخود قابو پالیتا ہے۔ ورزش کرنے والے افراد ڈیپریشن اور خوف کا بھی شکار نہیں ہوتے۔

ورزش ہڈیوں اور جوڑوں کو طاقت بخشتی ہے

ورزش سے ہڈیاں، جوڑے، پٹھے اور بندھن مضبوط ہوتے ہیں اور ان کی کارکردگی بہتر رہتی ہے۔

ورزشی اجسام کی ہڈیاں بھر بھری نہیں ہوتی اور نہ جلد ٹوٹتی ہے جلد ٹوٹنے سے مراد بھر بھری ہو کر ٹوٹنا یا ہڈیوں کی کمزوری اور امراض کے باعث ذرا سی چوٹ سے یا بغیر چوٹ ٹوٹ جانا ہے۔

ورزش جنسی طاقت کا بھی باعث بنتی ہے

دیگر اُن گنت فوائد کے علاوہ یہ بات مشاہدہ میں آئی ہے کہ جنسی زندگی پر بھی اس کے خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔

سیدھی سی بات ہے کہ جب ورزش دل و دماغ اور پورے جسم پر مثبت اور صحت مندانہ اثرات مرتب کرے گی تو آٹومیٹکلی جنسی زندگی میں بھی بہتری رہے گی۔

ورزش کے دوران رفتار بدل

ایک عام آدمی کی حالت صحت اور آرام کی حالت میں نبض کی رفتار 70 سے 75 ضربات فی منٹ ہوا کرتی ہے۔

لیکن مسلسل اور باقاعدہ ورزش کرنے والوں میں تقریباً 2 ماہ کی مدت کے بعد تبدیلی آجاتی

ہے۔ اور حالت سکون میں ان کی نبض 60 سے 70 ضربات فی منٹ ہو جاتی ہے۔

20 سے 30 منٹ تک ورزش کرنے کے دوران نبض کی رفتار بڑھ جائے گی۔ اور اگر آپ کی عمر 40 سال ہو تو آپ اپنی نبض کی رفتار 220 سے 240 سے دوران ورزش بڑھنے نہ دیں کیونکہ آخری دوران ورزش نبض بڑھنے کی حد 180 ضربات فی منٹ دوران ورزش ہوتی ہے۔

اور 180 ضربات نبض والے افراد کی دل کی ضربات تقریباً 126 ضربات فی منٹ ہوتی ہیں اور یہ ستر فی صد افراد کی شرح نبض و دل ہے۔ لیکن ایسے افراد جو CHD ہائپر ٹینشن کی ادویات خاص کر بیٹا بلاکنگ لے رہے ہوں تو ورزش کے دوران ان کی نبض میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا کرتا اسی طرح بوڑھے افراد میں بھی دوران ورزش نبض زیادہ تیز نہیں ہوا کرتی۔

ورزش کے متعلق غلط پروپیگنڈہ کا توڑ

عام لوگ خیال کرتے ہیں کہ اگر وہ ورزش کی عادت ڈال لیں گے تو انہیں زیادہ بھوک لگے گی اور وہ زیادہ کھائیں گے جس کی وجہ سے موٹا پا آ جائے گا، یہ خیال بالکل غلط ہے۔

کیونکہ ورزش سے جسم میں موجود زائد چربی اور حرارے جل جاتے ہیں، ورزش بھوک کو نہیں بڑھاتی ہاں البتہ مسلسل ورزش وزن میں کمی کا باعث بنتی ہے، ایسے افراد باقاعدگی سے ورزش نہیں کرتے کبھی کر لی اور کبھی چھوڑ دی، ان کے پٹھوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے اور وہ کمزوری محسوس کرنے لگتے ہیں، کم از کم 20 سے 30 منٹ روزانہ کی اپنی جسمانی حالت کے مطابق ورزش کی عادت دل، دماغ، پھیپھڑوں اور دیگر اعضاء بدن کے لئے مفید ہوتی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی شخص اپنی روزانہ کی مصروفیات کی بناء پر تھکا ماندہ رہے اور کمزوری محسوس کرے تو اس کے لئے کیا تجویز ہے۔

ایسے افراد جو اپنی روزمرہ کی مصروفیات سے اپنے آپ کو تھکا ماندہ سمجھ کر ورزش چھوڑ دیں اور کہیں کہ ان کی مصروفیات ہی ایسی ہے کہ وہ سارا دن کام کاج سے تھک جاتے ہیں، انہیں ورزش کی کیا ضرورت ہے تو یہ بات غلط ہے۔

باقاعدگی سے ورزش کی بنا پر دل کے پٹھوں اور جسمانی پٹھوں کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے اور ورزش کرنے سے اعضاء، ریسہ دل اور پھیپھڑوں کو صاف خون مہیا ہو کر ان اعضاء کی کارکردگی بہتر بنتی ہے۔ آکسیجن تمام ششوز تک آسانی سے اور مطلوبہ مقدار میں پہنچ کر پورے جسم کو تندرست و توانا بنا دیتی ہے لہذا ایسے افراد کو بھی ورزش کی عادت پڑنی ضروری ہے۔

یہ تمام فوائد بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں کہ اپنی خوراک اور جسمانی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ ورزش شروع کریں اور اعتدال سے نہ بڑھیں۔ زیادہ سخت ورزش نقصان کا باعث بنتی ہے۔ کیونکہ ہر چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی۔

ورزش کو خوشی خوشی سرانجام دیں زیادہ تھکا دینے والی ورزش سے گریز کریں۔ ورزش باقاعدہ ہونی چاہیے ایک دو دن ورزش کے بعد قفل اور دوبارہ پھر ورزش اور قفل چلوں میں کمزوری لاتی ہے۔

بہتر ہے ورزش صبح سویرے نہار منہ کی جائے۔ اگر صبح سویرے وقت نہیں تو کھانے کے فوراً بعد ورزش ہرگز نہ کی جائے۔ اس سے فائدہ کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔

ذہنی دباؤ سے چھٹکارا حاصل کریں

غصہ عقل کو کھٹکاتا ہے۔ غصہ اور قوت برداشت کی کمی دونوں ہی بری چیزیں ہیں۔ آج کے اس ایٹمی دور میں پیسے کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ اس دوڑ میں شامل ہر فرد ہر وقت دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے ہر روز صبح اسی لئے ہوتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر روپیہ پیسہ اکٹھا کر لے۔ اور وہ خود اس کے لئے روزانہ ہدف مقرر کرتا ہے اس ہدف کو پورا کرنے کے لئے جائز و ناجائز کی پرواہ نہیں کرتا۔

حالانکہ اسے پتہ ہے کہ اس فانی دنیا کو چھوڑ کر اسے اپنے اصل مقام کی طرف کوچ کرنا ہے۔ اور جب بھی بلاوا آجائے گا وہ اس طرف لوٹ جائے گا۔ اور اس کے تمام منصوبے دھرے رہ جائیں گے لیکن اکثر انسان سمجھ نہیں پاتے۔

(انسان اتنا لالچی ہے کہ آخر کار قبر کی مٹی سے اس کا پیٹ بھرتا ہے)

خود ساختہ مسائل کی بھرمار کی وجہ سے ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار رہ کر ہائی بلنڈ پریشر، دل کے عوارض میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے کوچ کر جانے سے کیا ملے گا۔

انسان کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق حلال روزی کی بہترین جدوجہد کرنا چاہیے، نہ کہ لالچ و حرص اور طمع کا غلام بن کر رات دن مختلف مسائل کو سینے سے لگا کر پیسہ کی دوڑ میں لگا رہے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اس لالچ کی بنا پر انسان مقام انسان سے گر جاتا ہے، پھر ذہنی دباؤ تو کیا بہت سی آفات اس کو بیماریوں کی شکل میں گھیر لیتی ہیں۔

ڈہنی دباؤ سے نجات کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟

اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے تمام اقسام کے ڈہنی دباؤ سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں سے ملاقات رکھی جائے جو خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درس دیتے ہیں۔

اور احکام خداوندی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائے ہیں، ان پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگیاں گزارنا چاہیے۔ ان احکامات کی روشنی میں وسیع تر رزق حلال کے حصول کے لئے مکمل رہبری موجود ہے۔

درگزر، برداشت اور حقیقت پسندانہ طرز زندگی گزارنے سے ڈہنی دباؤ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے نجات مل جاتی ہے، آزمائش شرط ہے۔

ہم بہت سے ڈہنی مریضوں کو جب کریدتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہیں پیسہ کے لالچ، شادی، رات و رات امیر بننے کے خواب اور کہیں اپنی بد اعمالیوں کے سبب ضمیر کی جھجکاہٹ کی بنا پر ڈہنی دباؤ عام ہے۔ تو سب سے پہلے اوپر بیان کردہ اصول اسے سمجھائے جاتے ہیں۔ اور پھر علامات جسم کے مطابق سنت سمجھ کر دوا کا استعمال کروایا جاتا ہے۔

تمباکو نوشی ترک کر دیں

پچھلے تیس سالوں میں مغربی ممالک میں تمباکو نوشی کے مضر اثرات سے لاکھوں افراد واقف ہو چکے ہیں۔ اور تمباکو نوشی ترک کر چکے ہیں۔ جب کہ ہمارے یہاں سگریٹ نوشی کا رجحان بڑھا۔ ہمارے پیارے ملک پاکستان میں اب باقاعدہ سگریٹ نوشی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

اس کا اطلاق سرکاری و نیم سرکاری دفاتر، پبلک ٹرانسپورٹ، سکولوں، کالجوں، ہسپتالوں اور دیگر پبلک مقامات پر ہوتا ہے۔ لوگ دیکھا دیکھی تمباکو نوشی کی عادت اپنا لیتے ہیں۔ گھر کے کسی بڑے فرد دادا، والد، انکل، بڑے بھائی کو سگریٹ پیتے دیکھ کر دیگر چھوٹے فیملی کے ممبر بھی اسے باقاعدہ اپنا لیتے ہیں۔

تمباکو نوشی سے خون کی نالیوں میں جمنے والی نیکیوٹین سے CHD میں اضافہ ہوتا ہے۔ (CHD سے مراد کوروناری ہارٹ ڈیزیز ہے)

ایک عام سگریٹ نوشی کرنے والے کو سگریٹ نوشی نہ کرنے والے کے مقابلہ میں ہارٹ

ایک سے دو چار ہونے کا کئی گنا زیادہ خدشہ ہوتا ہے۔

سگریٹ نوشی اور دل کے امراض کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ اس سلسلہ میں دنیا بھر میں تحقیق کی جا چکی ہے۔

30 سے 59 سال کی عمر والے افراد جو سگریٹ پیتے تھے۔ ان کا دس سال تک مشاہدہ کیا گیا ان ایک ہزار آدمیوں میں سے 40 ہارٹ ایکٹ سے فوت ہوئے۔ جب کہ آدھی ڈیڑھ سگریٹ پینے والے ایک ہزار افراد میں سے 66 افراد دل کے دورہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ اور ایسے افراد جو ایک پیکٹ سگریٹ روزانہ پیتے تھے ان میں سے 131 افراد ہارٹ ایکٹ سے فوت ہوئے۔

آپ تمباکو نوشی کیسے ترک کر سکتے ہیں؟

- 1- اپنے آپ کو احساس دلائیں، سگریٹ نوشی کا فائدہ کچھ نہیں نقصانات ہی نقصانات ہیں آپ یہ خسارے کا سودا کیوں کر رہے ہیں؟
- 2- یاد رکھیں سگریٹ نوشی سے آپ کی صحت جن خطرات میں گھر جائے گی ان سے آپ کی تمام فیملی متاثر ہوگی۔
- 3- سگریٹ نوشی وقت، صحت اور پیسہ کا ضیاع ہے۔
- 4- کسی بھی دوست یا عزیز کے کہنے پر سگریٹ نہ پیئیں جو خود سگریٹ پی رہا ہو اور آپ کو آفر کرے۔
- 5- ترک سگریٹ نوشی کے بعد اپنی جیب میں ٹافی، گولی یا مغز بادام رکھیں جب سگریٹ کی خواہش بیدار ہو مغز بادام ٹافی یا چٹکلم چبانے لگیں۔

مے نوشی ترک کریں

مے نوشی حرام ہے اس لئے شراب کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے، بد قسمتی سے ہمارے معاشرہ میں بہت سے لوگ غم غلط کرنے کے لئے حالات سے دل برداشت ہو کر اس بری عادت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مے نوشی سے جگر، دل، دماغ، گردے اعصاب اور پٹھے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ عام آدمی جو مے نوشی کے نقصانات کو سمجھتا ہے اس کے ملنے والوں میں اگر کوئی اس عادت میں مبتلا ہو تو اسکو اچھے طریقہ سے سمجھائے۔

اور اس کی صحت، عزت و وقت و پیسہ کا نقصان بھی اسے باور کروائے جو مے نوشی کے باعث

ہو رہا ہے۔

معالج کی ہدایات پر عمل کریں

آپ کا معالج یقیناً آپ کی صحت برقرار رکھنے کے لئے ہی آپ کو ہدایات دیتا ہے۔ اور ہدایات یا علاج کے لئے ایک کولیٹائڈ اکثر سے ہی رجوع کرنا چاہیے۔

وٹامنز اور اینٹی اوکسی ڈینٹ کا کردار

(The Role of Vitamins and Antioxidants)

مختلف کیمیکل کاروبار عمل ہمارے جسم میں اور ہر تھوڑے میں مسلسل جاری رہتا ہے حتیٰ کہ خیند کی حالت میں بھی۔

ان مینا بولک ری ایکشنز کے نتیجے میں جسم کے سیلز میں قیام پذیر ہر پیلے مادے پیدا ہوتے ہیں۔ ان ہر پیلے مادوں کو اکثر فری ریڈیکل کہا جاتا ہے۔

اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جسمانی خلیات کی تباہی، خلیات کی ڈی جینریشن اور کئی انواع کے سرطان کا باعث بنتے ہیں۔

تازہ ترین تحقیق سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ یہی فری ریڈیکل دل کے دورہ میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔

کیلی فورنیا میں کی جانے والی تحقیقات سے یہ بات بھی عیاں ہوئی کہ زائد کولیسٹرول جو خون میں گردش کرنے لگتا ہے، ان فری ریڈیکل کے باعث بہت خطرناک شکل کے کولیسٹرول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

اس کے باعث شریانوں میں لوتھڑے یا جھکے جمنے لگتے ہیں (Atherosclerosis) بیماری جنم لیتی ہے جو ہارٹ ایک کا باعث بنتی ہے۔

بیٹا کیروٹین، وٹامن سی اور وٹامن ای

(Beta Carotene, Vitamins C and E)

تحقیقات سے یہ بات عیاں ہو چکی ہے کہ بیٹا کیروٹین اور وٹامن سی اور ای دونوں ہی اوپر

بیان کرد و فری ریڈیکل کا قلع قمع کرنے کے لئے بہترین اور انکا کافی مقدار میں استعمال نمایاں طور پر دل کے عوارض کی شرح میں کمی کا باعث بنتا ہے۔

کئی سالوں کی تحقیقات کے بعد پتہ چلا یا گیا کہ روزانہ 25 ملی گرام کیروٹین کا استعمال دل کی بیماریوں سے محفوظ بناتا ہے۔

بدقسمتی سے ہمارے اکثر افراد کی خوراک میں 1.5 سے 2 ملی گرام روزانہ کیروٹین موجود ہوتی ہے جو بہت کم مقدار ہے۔

کیروٹین کی 25 ملی گرام کی روزانہ کی مقدار 50 فی صد تک ہارٹ ایکٹ کے حملہ سے محفوظ رکھتی ہے۔ وٹامن سی اور ای اور بیٹا کیروٹین کا استعمال فری ریڈیکل کو بے ضرر بنانے اور دل کی شریانوں کو تنگی، سختی اور ایٹھروسکلیروسس سے بچا کر دل کے دورہ سے محفوظ بناتا ہے۔

عام طور پر وٹامن سی، ای اور بیٹا کیروٹین کی اہمیت سے اتنی آگاہی نہیں ہے، ان کا استعمال نہ صرف دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے بلکہ فری ریڈیکل کو سرطان جیسا مہلک مرض بھی نہیں پھیلانے دیتا۔ خون کی نالیوں میں کولیسترول کو جمنے سے روکتا ہے۔

ایسی غذا جس میں بیٹا کیروٹین، وٹامن سی اور وٹامن ای موجود ہوں استعمال کرنے سے ہارٹ ڈیزیز کا خطرہ بہت زیادہ حد تک کم ہو جاتا ہے۔

ذیل میں بیٹا کیروٹین وٹامن سی اور ای کے ذرائع کا چارٹ دیا جاتا ہے۔

وٹامن ای کے ذرائع	وٹامن سی کے ذرائع	بیٹا کیروٹین کے ذرائع
گندم	نگوترہ	خوبانی
سویا بین	لیموں	گاجر
تمام اقسام کا دلیا	ترش پھل	آم
علیٰ کی مختلف اجناس	ٹماٹر	پالک
تج	بند گوبھی	مٹھے آلوؤں میں
سبز چٹوں والی سبزیاں	آلو	شائعیم
(مغزیات)	سبز مرچ	لوکی
کالی مرچ	آم	کدو

گاجر	شاہری	پیٹھا
سبز پتوں والی سبزیاں	امروہ	دھنیا کے پتے گھیا۔ آٹرو

دل کے امراض سے چھٹکارا ممکن ہے

(Heart Diseases Can be Reversed)

اب تک کی تمام بحث کا حاصل یہی ہے کہ بلڈ کولیسٹرول کا بڑھ جانا، بلڈ کولیسٹرول خون کی نالیوں میں جم جانا، ہائی بلڈ پریشر اور Atherosclerosis کا سبب بنتا ہے۔

آخر کار دل کی شریانوں کی تنگی اور خفگی کی بنا پر کئی اقسام کی دل کی بیماریاں جنم لے کر دل کے دورہ تک پہنچتی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب دل کی کوئی مرض ظاہر ہو جائے تو اس سے چھٹکارا ممکن ہے۔ اس کا جواب ہے ہاں کئی سال پہلے میڈیکل کے شعبہ سے وابستہ معالجین کو شک تھا کہ کیا کورونری آرٹری میں رکاوٹ دور ہو سکتی ہے یا نہیں۔

جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خون کی شریانوں میں تبدیلیوں یعنی ان میں خون کے جماؤ، لوتھڑا بننے اور Atherosclerosis کے عمل کو بلڈ کولیسٹرول لیول کم کر کے ممکن حد تک کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔ تمام گھل چربی والی غذاؤں اور گوشت سے پرہیز کیا جائے۔

سبزیوں کو اہل کرا استعمال کیا جائے تو ان کی پوری کی پوری افادیت برقرار رہتی ہے۔ لیکن اگر ان کو بھی تھی، اور کھن سے فرائی کیا جائے تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ البتہ ایسے کو کنگ آئل کا تھوڑا سا استعمال کیا جاسکتا ہے جو غیر سر شدہ ہوں۔

اس سلسلہ میں بہت پہلے تحقیق مکمل ہو چکی ہے کہ ایسے افراد جن کو اسٹیجی گرافی امتحان سے پتہ چلا کہ انہیں دل کی شریانوں کا مرق لائق ہے۔ ان کو اپنی نگرانی میں رکھ کر تین دن تک سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل خوراک دی گئی۔ انہیں ہر قسم کی دیگر غذاؤں سے روک دیا گیا، سبزیوں اور پھلوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ انہیں دہنی دباؤ سے نکالنے کے لئے تھوڑی ہلکی پھلکی ورزش بھی کروائی گئی۔

ایک ماہ کے بعد پتہ چلا کہ ان میں بہت سے مریضوں کا بلڈ پریشر نارمل تک آ گیا اور انجائنا کے درد میں کمی واقع ہو گئی۔

دوبارہ اسی نوعیت کی تحقیق جدید تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے پھر ڈاکٹر Dr. Antonio M. Gotto صاحب نے دوبارہ مریضوں کو سبزیوں اور پھلوں استعمال کروانے اور ان کے طرز زندگی میں تبدیلی پیدا کر کے ایک ماہ کے بعد دوبارہ چیک اپ کئے تو پتہ چلا کہ سبزیوں اور پھلوں کے مسلسل استعمال اور چربی والی غذاؤں کے ترک کرنے سے، ہلکی نوعیت کی ورزش اور طرز زندگی میں تبدیلی سے 20 فی صد سے زیادہ بلڈ کولیسٹرول لیول میں کمی واقع ہوئی اور 91 فی صد انجانا کے ورد میں کمی واقع ہوئی۔

ان ساری تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی طور پر خون کی شریانوں میں کولیسٹرول کے جمناؤ کو کم کر کے دل کی بیماریوں سے نجات ممکن ہے۔

اور ابتدائی مرحلہ پر ادویات کے بغیر صرف از صرف اپنے معالج کی ہدایات کے مطابق اور رابطہ سے ہلکی نوعیت کی ورزش، سبزیوں اور پھلوں کا استعمال تمام اقسام کی چربی غذاؤں سے پرہیز اور طرز زندگی میں تبدیلی ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول میں کمی کر کے Atherosclerosis سے بچا کر دل کی بیماریوں تک نہیں پہنچنے دیتی۔

دل کی شریانوں میں رکاوٹ والے مریضوں کو فکر مندی کی ضرورت نہیں بشرطیکہ وہ ان بیماری سے نجات چاہتے ہوں۔ انہیں چاہیے اپنی طرز زندگی میں تبدیلی لائیں، سبزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھا کر چربی اور چربی غذاؤں سے پرہیز رکھیں، ہلکی نوعیت کی مسلسل ورزش کریں، توازن، اللہ شفاء یقینی ہوتی ہے۔

اس سلسلہ میں ہونے والی سب سے بڑی ایک تحقیق پیش خدمت ہے، ڈاکٹر آرنش Dr. Ornish صاحب نے 35 سال سے 75 سال کی عمر والے ایسے 41 افراد کا انتخاب کیا جن کی اسٹیجیو گرافی رپورٹ کے مطابق تمام مریضوں کی دل کی شریانوں میں تنگی اور سختی واقع ہو چکی تھی۔

ان 41 مریضوں کو ڈاکٹر صاحب نے دو گروپوں میں تقسیم کیا۔ A ایک گروپ میں 22 مریضوں کو رکھا اور دوسرے گروپ B میں 19 مریضوں کو۔

گروپ A میں موجود 22 مریضوں کو سبزیوں اور پھلوں کا بھرپور استعمال کروایا گیا، چربی کے استعمال کو روک دیا گیا۔ روزانہ باقاعدگی سے ورزش کروائی گئی روزانہ آدھا گھنٹہ تک پیڈل واک کروائی گئی۔ یوگا، ورزش کرنے کے علاوہ سٹریس دور کرنے کی کے لئے سانس کی ورزشیں کروائی گئیں۔

جب کہ گروپ B جس میں 19 مریض تھے انہوں کو مکمل امریکن طرز علاج مسیا کیا گیا۔

ایک سال کے بعد گروپ ۸ والے مریضوں کا معائنہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ 18 مریضوں کی دل کی شریانوں میں کوئی رکاوٹ نہ تھی 3 مریضوں میں معمولی نوعیت کے آثار اور ایک مریض جو اس ایک سالہ پروگرام کو جاری نہ رکھ سکا تھا اس میں بھی شریانوں کی تنگی میں کسی حد تک کمی واقع ہوئی تھی۔ جب کہ گروپ بی والے مریضوں میں جنہیں مکمل امریکن طرز علاج کی سہولتیں میسر تھیں۔ 10 مریضوں میں دل کی شریانوں میں رکاوٹی عمل آگے بڑھ رہا تھا اور تمام 19 مریضوں میں چھاتی کے درد میں 165 فی صد تک اضافہ ہو چکا تھا اور درد کے دورانیہ میں 95 فی صد زیادتی واقع ہوئی تھی اور 39 فی صد تک درد کی شدت میں اضافہ ہوا تھا۔

ان دونوں گروپوں کے علاج کے بعد اس نتیجہ پر پہنچنے میں کوئی وقت نہیں آتی کہ جدید ادویاتی علاج والے مریضوں کی نسبت ایسے مریض جو اپنی غذا میں سبزیوں پھلوں کا استعمال زیادہ کرنے لگیں۔ چربی اور مرغن غذاؤں کو ترک کر دیں، ورزش یا قاعدگی سے کریں، زیادہ فوائد حاصل کرتے ہیں اور دل کی شریانوں کی تنگی کو نارمل سطح تک لے آنے میں کامیاب ہو کر دل کی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔

کیا دوسرے ہارٹ اٹیک سے بچا جاسکتا ہے؟

خوش قسمتی سے اب موجودہ دور میں جدید تحقیقات کی روشنی میں طرز زندگی میں تبدیلی، غذا میں تبدیلی، ورزش اور ادویاتی استعمال سے دوسرے دورہ سے بچا جاسکتا ہے۔

آج سے 20 سال پہلے 50 فی صد سے زائد افراد دل کے دورہ کے پہلے ہفتہ ہی فوت ہو جاتے تھے۔ لیکن اب 70 فی صد سے زائد افراد پہلے دل کے دورہ سے بچ سکتے ہیں۔

700,000 دل کا دورہ پڑنے والے مریض ہر سال امریکہ میں ہسپتالوں میں داخل ہوتے ہیں۔ ان میں سے 5,50,000 تقریباً بچ جاتے ہیں۔ اور انہیں ہسپتال سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔

لوگوں میں دل کے عوارض کے متعلق آگاہی جدید سہولتوں اور احتیاطی تدابیر آج اور آج سے بیس سال پہلے کے حالات میں بہت زیادہ فرق ہے۔

آپ کا اپنا تجربہ ہوگا آپ کئی ایسے افراد کو جانتے ہوں گے جن کو دل کا دورہ پڑے اور وہ بچ گئے اور اب نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں اور معالج ہونے کے ناطے میرے ذاتی

تجربہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں۔

ایسا کیونکر ممکن ہے اس کے لئے مختلف طریقہ کی تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
مندرجہ ذیل اقدامات سے آپ دوسرے دل کے دورہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

(1) سگریٹ نوشی ترک کر دیں

لازمی ہے کہ ہارٹ اٹیک کے بعد اگر آپ سگریٹ نوشی جاری رکھیں گے تو دوسرا دورہ بہت جلد ہو سکتا ہے اس لئے سگریٹ نوشی سے پرہیز ضروری ہے۔

(2) رویہ میں مثبت تبدیلی

ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جانا غصہ میں آ جانا۔ جلد نہ سونا اور ورزش نہ کرنا بھی دوسرے دورہ کا باعث بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھی جو حقیقی باتوں کے قائل ہوں اور آپ کے مفلس ہوں آپ کو پرہیز کرنے والی چیزوں کے استعمال پر نہ اکسائیں۔

(3) غذائی تبدیلیاں

اپنی خوراک میں حراروں اور چربی والی غذاؤں کو بہت حد تک کم کریں۔
سبزیوں، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں۔ لیموں، انگھڑو، پالک، گاجر، آم، خوبانی، اسرو،
آڑوا خروٹ وغیرہ بہت ہی مددگار اشیاء خوردہ ہیں۔

(4) وزن کم رکھیں

وزن کا بڑھنا دوسرے ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتا ہے لہذا اپنے وزن کو کنٹرول رکھیں عمر
اور قد کے حساب سے اسی کتاب میں وزن کا چارٹ دیا گیا ہے، اس سے بھی مدد لی جاسکتی ہے۔
کیونکہ بڑھا ہوا وزن خطرناک ہوتا ہے اور ایسے افراد کے لئے جو ہارٹ اٹیک کا شکار ہو
چکے ہوں کسی صورت میں بھی وزن کو بڑھنے نہ دیا جائے۔

(6) باقاعدگی سے ورزش

سائنسی تحقیق سے یہ بات عیاں ہو چکی ہے ایسے افراد جن کو دل کا دورہ پڑ چکا ہو ان میں سے
جو باقاعدگی سے ورزش کریں۔ 24 سے 32 فی صد ورزش نہ کرنے والے کی نسبت بہتری کے مواقع
ہوتے ہیں۔

لیکن ورزش صرف وہی کی جائے جو آپ کا معالج آپ کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے تجویز کرے۔ خود بخود یا کسی بھی فرد کی تجویز کردہ ورزشیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔

(6) ذہنی دباؤ سے بچیں

ذہنی دباؤ سے خود کو نکالنا چاہیے کیونکہ ذہنی دباؤ کے باعث بہت سی کیمیائی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ جودل کے بہت نقصان دہ ہوتی ہیں۔ ذہنی دباؤ سے بلڈ کولیسٹرول لیول میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لئے اپنے ذہن کو زیادہ سے زیادہ تفکرات و غم و غصہ سے آزاد رکھ کر اپنی مدد کی جاسکتی ہے۔ جلد باز، غصیلہ آدمی ہمیشہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ اسکے مقابلہ میں درگزر کرنے والا، غصہ کو پی جانے والا اور ذرا ذرا بات پر نہ بگڑنے والا فرد ذہنی سکون اور آسودگی میں رہتا ہے۔ ذہنی دباؤ سے بچاؤ کا سب سے بڑا علاج اپنے طرز زندگی کو اسلام کی شعائر کے مطابق گزارنے میں موجود ہے۔

پانچ وقت کی نماز ادا کرنا اور پانچ وقت اس کے لئے وضو کرنا ذہن کو آسودہ اور پاک و صاف رکھ کر کینسر غرور غصہ کو نزدیک نہیں آنے دیتا۔

(7) دیگر کئی بیماریوں پر قابو پانا

بہت سے دل کا دورہ پڑنے والے مریض ایک یا ایک سے زیادہ اقسام کی دیگر بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔

مثلاً شوگر، ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ کولیسٹرول، ان تمام پر دوسرے دل کا دورہ سے بچنے کے لئے قابو پانا یا کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کی شدت بھی دوسرے ہارٹ اٹیک کو دعوت ہوتی ہے۔

(8) کیا آپ کا علاج بہتر ہو رہا ہے

بہت سے دل کے امراض میں مبتلا افراد کو جودل کا دورہ پڑنے کے بعد بہتر ہونے پر ہسپتال سے فارغ کر دیا جاتا ہے تو ان کی نسخہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے تا کہ گھر میں جا کر ادویات کا استعمال جاری رکھیں۔ لیکن یاد رہے ادویات کے بہت سے اضافی اثرات بھی ہوتے ہیں، اپنی صحت کے بارے میں مکمل آگاہی کے لئے اپنے معالج سے رابطہ رکھیں۔

(9) کسی قسم کا بھی جنسی مسئلہ اپنے ہی معالج سے بیان کریں

دل کا دورہ پڑنے کے چار سے چھ ہفتے بعد بہت سے مریض اس قابل ہو جاتے ہیں۔ کہ وہ اپنے ازدواجی فریضہ کو سرانجام دے سکیں۔

لیکن ایسے دل کا دورہ پڑنے والے افراد جن کو دل کے دورہ کے چار سے چھ ہفتوں بعد بھی بے قاعدہ دھڑکن، دل کے قفل ہو جانے کے خدشات باقی رہیں۔ وہ فریضہ زوجیت ادا نہیں کر سکتے۔

اگر ان حالات میں وہ وظیفہ زوجیت ادا کریں گے تو دل کا دورہ پڑنے کے خطرات کو خارج از امکان نہیں سمجھا جاتا۔

آج سے تیس سال پہلے دل کا پہلا دورہ پڑ جانے کے بعد اگر دورہ جان لیوا نہ ہو اور مریض بچ جائے تو اسے مکمل آرام کروایا جاتا تھا اور تین ماہ تک مکمل آرام کا مشورہ دیا جاتا تھا۔

لیکن آج کل مریض کو ہارٹ ایک کے تیسرے چوتھے روز آہستہ آہستہ چلنے کا کہہ دیا جاتا ہے اور اکثر مریضوں کو سات سے دس دن بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔

اور اکثر ہارٹ ایک کے مریض ہارٹ ایک کے بعد دس سال تک اپنی مصروفیات برقرار رکھتے ہیں۔ اگر کوئی ہارٹ ایک کا شکار ہو چکا ہے تو وہ اپنی قوت ارادی کو مضبوط بنا کر۔ اپنے طرز زندگی میں مکمل تبدیلیاں لا کر نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔

بعد از آپریشن ہدایات

کسی بھی صورت دل کی سرجری ہی آخری علاج نہیں ہوتا، اس سے پہلے اور بعد دونوں صورتوں میں مریض کو چند ضروری باتیں مد نظر رکھنا چاہیے جو اس کی زندگی کے لئے ضروری ہوتی ہیں اور ان پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی نارمل زندگی کی پہلی پڑاوی پر چل سکتا ہے۔

آپریشن کی بعد یعنی bypass، آپریشن کے بعد تقریباً 45 فی صد بائی پاس پیوند کاری ایک سال بعد 45 سے 50 فی صد پانچ سال بعد اور 70 فی صد افراد کی شریانیں سات سال بعد بری طرح ناکارہ (Damaged) ہو جاتی ہیں۔

اور یہ اعداد و شمار میں نے انڈیا میں سرجری کی سرورے رپورٹ سے تیار کئے ہیں۔ یہاں آج کل ہمارے پیارے ملک کے لوگ بھاگ بھاگ کر دل کا بائی پاس کروانے جا رہے ہیں۔ وطن عزیز میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہمارے ملکی نتائج اس سے بہت زیادہ بہتر ہیں ضرورت

صرف اس امر کی ہے کہ حکومت ماہر سرجنوں کی خدمات کو غریب عوام تک بلا معاوضہ حکومتی سطح پر اخراجات برداشت کر کے پہنچائے۔ آپریشن کے بعد بھی اپنے طرز زندگی میں تبدیلیاں لاکر ہی فوائد سے مستفید ہوا جاسکتا ہے میں فقط طرز زندگی بار بار استعمال کر رہا ہوں۔ کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں آجاتی ہیں۔ کھانے، کام کرنے، سوتے، ورزش اور دیگر کئی انواع کی تبدیلیاں طرز زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ ان کو باقاعدگی اور متوازن رکھ کر ہی دل کی امراض سے بچا جاسکتا ہے اور گردل کی امراض میں مبتلا ہو جانے سے ہارٹ اٹیک یا بانی پاس جیسے مرحلہ سے بھی گزر چکے ہوں تب بھی احتیاطی اور تداویر ضروری ہوتی ہیں۔

اگر بانی پاس Bypass سرجری کے بعد صرف ایک ہی عادت کو ترک نہ کرے یعنی سگریٹ نوشی ہی ترک نہ کی جائے، تو یقین کریں 3 سے 5 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ بانی پاس Bypass سرجری کی ضرورت پیش آسکتی ہے۔

اسی طرح پرہیزی غذا بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چربی اور مرغن غذائیں چھوڑ کر سبزیوں پھلوں کا استعمال ورزش سیر اور خوش رہنے کی عادت بلڈ کولیسٹرول کو بڑھنے نہیں دیتی۔

جب بلڈ کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے تو بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ دل کی شریانوں میں Atherosclerosis جیسا عمل واقع نہیں ہوتا۔ دل کی شریانوں میں تنگی اور ختی نہیں آتی اور نارمل زندگی نصیب ہو جاتی ہے، اگرچہ موجودہ دور میں سرجری بہت آگے نکل چکی ہے لیکن سرجری دل کے امراض کا حل نہیں۔

دل کے امراض کا حل ہی اس تمام کتاب میں بتایا گیا ہے جس پر عمل چاہو کر مکانہ حد تک آپ دل کے امراض CHD سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور اگر آپ کا مرض اس حد تک نہیں پہنچا کہ سرجری ضروری ہوگئی ہو تو آپ اس میں بیان کردہ اصولوں کے مطابق عمل کر کے اپنے مرض کو خیر آباد کر سکتے ہیں۔

اسی طرح ایسے افراد جو ہارٹ اٹیک کا شکار ہو چکے ہوں وہ بھی اس کتاب میں موجود ہدایات و قوانین پر عمل کر کے دوسرے دل کے دورہ سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔

اپنے مستقبل کو صحت مند رکھئے

ہارٹ اٹیک کے ممکن عوامل پر ہم سیر حاصل گفتگو کر چکے ہیں۔ کورونری ہارٹ ڈیزیز CHD

تک پہنچانے والے فیکٹر مثلاً سگریٹ نوشی، شوگر، موٹاپا پر ہی پہلے پہل توجہ دی جاتی تھی لیکن اب ان میں سب سے نمایاں بڑی وجہ بلڈ کولیسٹرول لیول میں اضافہ کو بھی سرفہرست رکھا جاتا ہے۔

تحقیقات سے یہ بات بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ اگر ایک فی صد بلڈ کولیسٹرول لیول میں کمی واقع ہو تو دو فی صد ہارٹ ڈیزیز کا خدشہ کم ہو جاتا ہے۔ اپنا مستقبل بیمار یوں سے محفوظ بنانے کے لئے سب سے پہلا اصول

- 1- باقاعدگی سے پانچ وقت نماز ادا کریں۔
- 2- اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔
- 3- بے صبری، کینہ، غرور، تکبر، حسد جیسی بدخصلتوں کو نزدیک نہ آنے دیں یہ تمام بیماریوں کی جڑیں ہیں۔

ان میں مبتلا افراد ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں اور جب کوئی فرد ذہنی دباؤ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے جسم میں بہت سے کیمیائی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن کے باعث اس کا پورا جسمانی نظام متاثر ہوتا ہے۔ خاص کر دل اور متعلقہ دل اعضا، یعنی دل کی شریانیں۔ ان شریانوں میں ذہنی دباؤ کے باعث بلڈ کولیسٹرول میں اضافہ ہو کر تنگی، سختی اور اندرونی سطح میں کولیسٹرول کا جماؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے جو Atherosclerosis اور پھر ہارٹ ایکٹ جنم لیتا ہے۔

- 4- متوازن غذا، سبزیوں اور پھلوں کا کثیر المقدار استعمال کرنا چاہیے۔ مرغن غذاؤں اور سہل پسندی کو خیر آباد کہہ کر باقاعدگی سے ورزش کی عادت اپنانی چاہیے۔
- 5- وقت پر کھانا، وقت پر سونا، وقت پر اپنے تمام کام کو ج کو ختم کرنا ذہنی دباؤ سے نجات دلانا ہے۔
- 6- کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیں اور انہیں کسی تولیہ وغیرہ سے صاف کئے بغیر خشک ہو لینے دیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا چاہیے اسے سونے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کھانے کے درمیان پانی پینے کو چاندی اور بعد میں پانی پینے کو چھتر فرمایا گیا ہے۔

- 7- کھانا تھوڑا تھوڑا ڈال کر کھایا جائے اور کھانے کے اختتام پر اپنے کھانے والے برتن کو اچھی طرح صاف کر لیا جائے اس میں بھی شفا ہوتی ہے۔
- 8- اپنے جسم کی فلفلس کے لئے باقاعدگی سے ورزش کریں۔ اس کے لئے مختلف کھیلوں میں حصہ لیا

جاسکتا ہے۔ باکی، بیڈمنٹن، فٹ بال، باسکٹ بال، تیراکی، دوڑ لگانا وغیرہ اچھی خاصی ورزشی کھیلیں ہیں۔

حکومتی اقدامات

حکومت کو اپنی رعایا کی صحت کی بحالی اور بقا کے لئے مختلف ذرائع سے تقویت پہنچانا ضروری ہے۔

کھیل کے میدان

مثلاً کھیل کے لئے سپورٹس کمپلکس کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ نوجوان طبقہ اپنا وقت ضائع کرنے کی بجائے کھیل میں لگا کر ورزش کے ذریعہ اپنی صحت کو بحال رکھیں۔

ملاوٹ سے پاک اشیاء کی یقینی فراہمی

عوام کی صحت کے لئے لوگوں تک پہنچنے والی اشیاء خورد و نوش ملاوٹ سے پاک ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں کسی بھی نرمی سے کام نہ لیا جائے۔ اور ملاوٹی عناصر کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں۔ اگر قوم صحت مند ہوگی تو ہر میدان میں ترقی کر سکتی ہیں بیمار قوم ترقی کے مراحل طے کرنے سے قاصر ہوتی ہے۔ فرد افراد اور مجموعی طور پر صحت مند قوم ہی اچھے مستقبل کی ضمانت ہوتی ہے۔

علاج معالجہ کی سہولتوں کی فراہمی

جس طرح پولیو، کالی کھانسی، خسرہ، ٹی بی، وغیرہ سے بچاؤ کے لئے کافی کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح دیگر تمام نوعیت کی بیماریوں سے بچنے کے لئے عوام میں شعور بیدار کرنا ضروری ہے خاص کر ہائی بلڈ کولیسرول جو خاموش قاتل ہے زندگی کا اس کے لئے تمام ذرائع ابلاغ کو استعمال کیا جائے اور تندرستی کی نعمت کی قدر سمجھائی جائے۔

لوگوں کو سستا علاج معالجہ کی سہولتیں فراہم کی جائیں تاکہ بیماری کی صورت میں ایک عام آدمی بھی اس سے استفادہ کر سکے۔ اس سلسلہ میں حکومتی سرپرستی میں طب اسلامی اور ہومیو پیتھی سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔

اس سے زرمبادلہ بھی بچے گا اور ملکی ذرائع سے حاصل شدہ خام مال سے ادویات تیار کر کے استعمال میں لائیں جائیں گی، وہ زود اثر ہوں گی جو جزی بوٹی جس خطے میں ہوتی ہے وہاں کے رہنے

والے افراد پر اس کے اثرات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔

اس لئے مقامی ذرائع پر زیادہ سے زیادہ انحصار کیا جائے۔

طب اسلامی اور ہومیو پتھی کو فروغ دے کر ہر بنیادی ہیلتھ سنٹر ز اور رور ہیلتھ سنٹر میں طب اسلامی اور ہومیو پتھی کے ماہرین سے استفادہ کیا جائے۔

دل کی بیماریوں سے محفوظ رہنے کی ہدایات عام کی جائیں۔ لوگوں کو چربی اور مرغن غذاؤں کے مقابلہ میں سبزیوں، پھلوں اور دالوں کے استعمال کی افادیت سے آگاہ کیا جائے۔

یہ کام اکیلی حکومت کا نہیں، خیر حضرات اور حکومتی ادارے مل کر ایسے پروگرام تخیل دیں۔ جن کی بنا پر لوگوں میں اپنی صحت کو برقرار رکھنے خاص کر دل کے امراض سے بچنے کے لئے شعور آگئی عام ہو۔ اور ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول کی زیادتی جو خاموش قاتل کا کردار ادا کرتی اس کے بارے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم پیسہ خرچ کر کے ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جو کولیسٹرول لیول کو بڑھاتی ہیں۔

اس طرح ہم اپنی جیب سے پیسہ لگا کر دل کی بیماریوں کو دعوت دیتے ہیں۔ مناسب غذا اور امن پسندانہ طرز زندگی انفرادی طور پر اور مجموعی طور پر دونوں صورتوں میں فائدہ مند ہوتی ہے۔ اپنی طرز زندگی میں مثبت تبدیلیوں سے CHD سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔ ان تمام باتوں کو عام لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔

انفرادی کوششیں

انفرادی طور پر ہمیں خود کو دیگر بیماریوں کے ساتھ CHD جیسی جان لیوا بیماریوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماریاں کیسے لگتی ہیں، کیسے پھیلتی ہیں اور ان سے بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، جب ہمیں ذرائع ابلاغ اپنے معالج یا کسی اور طریقہ سے ان کے بارے معلومات حاصل ہو جائیں۔

تو بڑی سختی سے ان سے بچاؤ والی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر خود کو اپنی فیملی کو اور معاشرہ کو خوشحالی کی راہ پر گامزن ہونے میں مدد کریں۔

متوازن غذا، مناسب ورزش اور دیگر پہلو سے بیان کردہ ہدایات پر عمل کر کے ہائی بلڈ کولیسٹرول پر قابو پا کر CHD یعنی کورونری ہارٹ ڈیزیز سے محفوظ رہ کر اپنے اور ملک کے مستقبل کو

بیماریوں سے محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔

غذائی تبدیلیوں سے اس پر قابو پانے کی کوشش کی جاتی ہے۔

اور اکثر اوقات اگر مریض اپنے معالج کی ہدایات پر مکمل عمل کرے تو پرہیزی غذا سے ہی مطلوبہ مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔

اس لئے میرا ذاتی طور پر مریضوں کو مشورہ ہے کہ وہ اپنے معالج کی ہدایات پر مکمل اور سختی سے عمل کریں۔ تاکہ ادویاتی استعمال کی نوبت کم از کم آئے۔ ایلو پیٹھک ادویات کی ناصرف قیمتیں بہت زیادہ رکھی گئی ہیں بلکہ ان کے مابعد اثرات سے بھی مریض کو ہر روز آنا ہونا پڑتا ہے۔

ایک سمجھدار مریض اگر غذائی تبدیلیوں سے ایک بار صحت مند نہ ہو سکے تو دوبارہ اپنے معالج سے رجوع کر کے چند ناگزیر مزید تبدیلیوں پر عمل کر کے شفاء یاب ہو سکتا ہے۔ کیونکہ مریض کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے کس قدر اپنے معالج کی ہدایات پر عمل کیا ہے اور کون کون سی چیزیں منع کرنے کے باوجود ترک نہیں کیں۔

معالج کے مشوروں سے مریض چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے، اگر مریض ان پر عمل ہی نہ کرے تو معالج بے بس ہے وہ مریض کی مدد کیا کر سکتا ہے۔ تو کسی بھی قسم کے علاج کو شروع کرنے سے پہلے خواہ وہ طب کا ہو یا ہو میوپیتھی کا اپنے معالج کی تمام جگہ دیں ان کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے لئے اپنے ذہن کو تیار کر لیں تو انشاء اللہ ضرور شفاء سے ہمکنار ہوں گے۔ چونکہ ہم نے اس کتاب میں ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول جو دل کے امراض کا باعث بنتا ہے۔ اس کے لیول میں اضافہ کرنے والے دیگر عوامل کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ جن میں سٹریس یا ذہنی دباؤ، ہائی بلڈ پریشر، کافی، چائے نوشی، سگریٹ نوشی، الکوحل نوشی، موٹاپا، شوگر، ایٹھر و سیکلر و سس وغیرہ لہذا ان سب کے تدارک کے لئے، ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے باری باری ان کے علاج کے بارے گفتگو کریں گے۔

اور آخر پر ہائی بلڈ کولیسٹرول کے ذاتی طور پر میرے کلینک میں علاج کئے گئے چند مریضوں کے علاج معالجہ کے متعلق بتایا جائے گا۔ جن کو مختلف ہو میوپیتھی ادویات سے شفاء کلی حاصل ہوئی۔ سب سے پہلے سٹریس یا ذہنی دباؤ کو لیں گے اس کے بعد باقی سب عوامل کا ایک ایک کر کے علاج تحریر کیا جائے گا۔

سٹرٹس یا ذہنی دباؤ کا علاج (Treatment of Stress)

ذہنی دباؤ (Stress) کے لئے ہومیو پیتھی میں بہت ہی آسان اور موثر علاج موجود ہے۔ اس میں زیادہ تر آزمودہ ادویات یہاں پر مختصر انہیان کی جائیں گی۔

(1) اناکارڈیم

ذہنی دباؤ کے باعث مریض کی قوت فیصلہ جواب دے جائے اپنے آپ کو دو ٹھیسروں میں بنا ہوا محسوس کرے۔

اس لئے کسی بھی چیز کا اٹل فیصلہ نہ کر سکے۔ اپنے کام کے لئے خود پر بھی بھروسہ نہ ہو، دروازہ لگانے کے بعد بار بار اسے چیک کرے کہ کیا اس نے دروازہ لگا لیا ہے یا نہیں یقین نہ آئے۔

(2) آرم مٹ

مریض خود کشی کی طرف مائل خود کشی کرنا چاہیے، ذہنی طور پر ناکارہ ہو جائے سمجھ نہ آئے کیا کیا جائے۔ ذہنی انتشار کا شکار ہوتا ہے، طبیعت میں جوش مریض ذہنی دباؤ کی وجہ سے ناامید اور مایوس اور اپنی زندگی سے بیزار۔ ذہنی دباؤ کے باعث موت کا شدید خوف، معمولی اختلافات پر آپے سے باہر ہوتا جائے۔

ایسے ذہنی دباؤ میں مبتلا مریضوں کے لئے آرم مٹ نوید حیات ہوتی ہے۔

(3) ارجنٹم نائیسٹرکیم

ذہنی دباؤ کے باعث مریض سوچتا ہے کہ اس کی سوچ غلط ہے ناکام ہے۔

خوف زدہ اور پریشان

کھڑکی سے باہر کودنا چاہے۔

ذہنی دباؤ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ جس کے باعث ہر کام جلد جلد ختم کرنا چاہتا ہے۔ جس کی وجہ سے کوئی کام بھی مکمل اور درست نہیں ہوتا۔

ایسے تمام ذہنی دباؤ والے مریضوں کے لئے ارجنٹم نائیسٹرکیم بہت ہی مفید دوا ہوتی ہے۔

(4) ماسکس

مرد و زن دونوں کے لئے لیکن عورتوں کے لئے زیادہ مفید دوا ہے۔

ذہنی دباؤ سے ہسٹریائی کیفیت پیدا ہو جائے۔ ذہنی دباؤ اس قدر غالب ہو کہ مریض بے قرار، خوفزدہ، اور تندی شہوت، ذہنی دباؤ سے نبض کمزور اور غشی تک نوبت آجائے۔

اس کے علاوہ درجہ ذیل ادویات اپنی مخصوص علامات کے باعث ذہنی دباؤ میں کارآمد ہیں۔

چائے اور کافی کے بد اثرات کو زائل کرنے کے لئے

(2) کافی کروڈا

چائے اور کافی کے اثرات بد کو زائل کرنے میں بہت نمایاں اور بڑی دوا ہے۔ کافی اور چائے کے استعمال سے بڑھی ہوئی ذکی الحسی، شدید اعصابی تحریک اور بے قراری اس دوا سے ہی ٹھیک ہوتی ہے۔

چائے اور کافی کے اثرات بد کو زائل کرتی ہے مثلاً اعصابی دھڑکنیں، ذکی الحسی، خیالات کی بھرمار، ایسے محسوس ہو جیسے دماغ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہو۔ اور مریض انتہائی جلد باز ہو تو اس دوا سے درست ہوتا ہے۔

(2) کیمومیل

چائے، کافی اور دیگر منشیات سے پیدا شدہ تکالیف کی بہترین دوا ہے۔ مریض چائے اور کافی کے اثرات بد کے نتیجے میں بے حد چڑچڑاہٹ، حساسیت، پیاسا اور چیخنے چلانے والا ہوتا ہے۔ مریض برداشت نہیں کرتا کہ کوئی اس سے گفتگو کرے، تیز طرار اور غصہ سے بھرپور تنگ کرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو کیمومیل راہ راست پر لاتی ہے اور نارمل بناتی ہے۔

(3) نکس وامیکا

تیز چائے اور کافی کے بد اثرات کے ساتھ درجہ ذیل علامات کو درست کرتی ہے۔

مریض آپے سے باہر ہوتا جائے، چائے اور کافی کے اثرات بد کے نتیجے میں ذکی الحس، حاسد، روشنی اور چھوٹا جانا پسند نہ کرے، وقت آہستگی سے گزرے اور معمولی تکلیف اس پر گراں گزرے۔ دوسرے کی بے عزتی کرے۔ بد مزاج اور دوسروں کے عیب خوب نکالے ان تمام بد اثرات کافی اور چائے کو نکس وامیکا درست کرتی ہے۔ عام طور پر اس دوا کا استعمال رات کو سونے سے قبل کروایا جاتا ہے۔ کیونکہ سوتے وقت یہ دوا خوب اثر کرتی ہے۔

جس طرح سلفر کو صبح منہ بہار استعمال کروایا جاتا ہے۔

سگریٹ نوشی کے اثرات بد کو دور کرنے اور سگریٹ نوشی ترک کروانے کیلئے

(1) ٹوبیکم

سگریٹ نوشی اور دیگر کسی بھی طریقہ سے تمباکو پینے سے اثرات بد کے طور پر مریض مایوس، ناامید، غیر مطمئن اور بھولنے والا ہوتا ہے۔

نظر کی کمزوری، بھینگا پن، قے، متلی برف جیسے ٹھنڈے پسینہ، پٹھوں کی کمزوری اور قوی درد تمام کی تمام ٹوبیکم دوا کے استعمال سے دور ہوتی ہے، اس کی پونہسی 30 اور اونچی طاقت میں استعمال کی جاتی ہے۔

(2) آر سینیکم البم: تمباکو چبانے کے اثرات بد کو زائل کرتی ہے۔

(3) اگنیشیا: تمباکو نوشی کے اثرات بد سے آنے والی علامات کو دور کرتی ہے۔

(4) سپیا: تمباکو نوشی کے باعث پیدا شدہ بد ہضمی اور اعصابی دروں کے لئے بہترین دوا ہے۔

(5) لائیکوپوڈیم: تمباکو نوشی کے اثرات بد سے پیدا شدہ نامردی کی واحد دوا ہے۔

(7) ٹکس و امیکا: تمباکو نوشی سے منہ کا ذائقہ بگڑ رہے، معدہ خراب ہو اور کسی بھی شے سے منہ کا ذائقہ بہتر نہ ہو رہا ہو تو ٹکس و امیکا دوا ہوتی ہے۔

طاقت: تیس اور بلند طاقتوں میں بھی استعمال میں لائی جاتی ہے۔

(8) کلیدیم اور پلانٹیکو: یہ دونوں دوائیں تمباکو سے نفرت دلاتی ہیں۔

طاقت: تیس طاقت زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔

(9) فاسفورس: تمباکو کے باعث نامردی اور ساتھ دل کے عارضہ کے لئے بہت ہی موثر دوا۔

طاقت: 200, 30

الکوحل کے بد اثرات کو روکنے اور اس عادت کے چھٹکارا کیلئے

(1) ایوناسائیوا: کثرت سے نوشی کی عادت ترک کرنے کے لئے یا ع نوشی کے اثرات بد کو

زائل کرنے کے لئے بہت بڑی دوا ہے۔

بے خوابی، ذہنی ابتری، نامردی، جریان منی، ہاتھ پاؤں بے حس جیسے فالج ہو گیا ہو اور مرگی کے لئے بہترین دوا ہے۔

(2) کپسکیم: مریض انتہائی بد مزاج، گھر جانے کیلئے پریشان، بے خوابی اور خودکشی کا رجحان، تنہائی پسند۔ یہ تمام باتیں کثرت سے خوری کا نتیجہ ہوں تو کپسکیم بہترین دوا ہوتی ہے۔

حرارت غریزی کی کمی، رد عمل کی صلاحیت بہت ہی کم ہو گئی ہو خاص الخاص علامات میں سے ہیں۔ طاقت: 30 عام طور پر۔

(3) نکس و امیکا: کثرت سے نوشی کے اثرات بد کو زائل کر کے مے نوشی کی عادت کو ترک کرنے کے لئے لاجواب دوا ہے۔

طاقت: 30 سے لے کر اوپر تک۔

(4) فلوورک ایسڈ: شرابیوں کی جگر کی سختی کے لئے بے حد مفید دوا ہے۔ شراب نوشی کے بد اثرات خود سے پیار کرنے والے افراد سے لاپرواہ، اپنے فرائض پورے نہ کر سکے۔ اپنی ترنگ میں رہے اور ذہنی طور پر خوش رہے تو فلوورک ایسڈ ہی دوا ہوتی ہے۔

طاقت: 6 سے 30 اور اونچی طاقتوں میں استعمال کی جاتی ہے۔

(5) پکس لیکوٹا: کثرت سے نوشی سے معدہ میں درد اور سیاہ مواد کی تھ، مزمن براؤنکائٹس، ہاتھوں کی پشت پر دانے اور ناقابل برداشت کھلی جو کثرت سے نوشی سے آتی ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔ طاقت: 1 سے 6 تک۔

مونوپا

مونوپا کے لئے استعمال ہوئی والی ہو میو پیٹھک ادویات

(1) امونیم برومیڈم: مونوپا کے لئے بہترین دوا ہے۔ سر اور چھاتی میں ٹھن محسوس ہو، انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے خراش کا احساس جو صرف دانتوں سے کاٹنے سے بہتر محسوس ہو۔

مونوپا کے باعث سانس پھولنا ہو اور سیرھیاں چڑھنے اور اترنے میں بے حد تکلیف ہو گھٹنے

اپنی جگہ سے ہٹتے محسوس ہوں تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔

طاقت: 3 سے چھ۔

(2) فیوکس ویسی کیو لوکس: موٹاپا، ضدی نوعیت کی قبض، ایسے احساس جیسے لوہے کے کڑے میں پیشانی کو جکڑا جا رہا ہو۔

موٹے افراد کے تھائی رائیڈ غدود بڑھ جائیں، گلہڑ جس میں آنکھیں باہر نکل آتی ہیں۔

قوت ہاضمہ کو بڑھاتی ہے اور اچھا روکوم کرتی ہے۔

طاقت: 5 سے 60 قطرے مد رنگچر کے دن میں تین مرتبہ کھانے سے پہلے۔

(3) کلکیر یا کارب: ناقابل ہضم اشیاء کی زبردست خواہش مثلاً چاک کوئلہ، پنسل، انڈے کھانے کی شدید خواہش۔ موٹاپا رنگ گندی جلد پر ٹھنڈا اور ترش پسینہ۔

کام کاج سے ذہنی اور جسمانی تھکن، مریض وہمی اور خیال کرے کہ اس کے وہم کے متعلق دوسرے لوگ نہ جان جائیں۔

طاقت: یہ دوا اونچی طاقتوں میں استعمال کی جاتی ہے۔

(4) فائیکو لاکا: غدودوں کی سوजन، ریشہ دار پٹھوں کے خلاف کی سوजन، مزمن گھٹیا، گلے کا ورم، فائیکو لاکا بیرمی کا مد رنگچر موٹے افراد میں موٹاپے کی اوپر بیان کردہ علامات کے خاتمہ کے لئے بہترین دوا ہے۔

طاقت: مد رنگچر 20 سے 30 قطرے دن میں تین مرتبہ۔

(5) تھائیروڈینم: موٹاپا کے ساتھ خون کی کمی، لاغری، پٹھوں کی کمزوری، پسینہ، بازو اور ٹانگوں کا لرزہ۔

ٹانگوں کا استسقاء اور کانپنا۔

اس دوا کا استعمال نہایت ہی تجربہ کا حامل معالج موٹاپا کے لئے کر سکتا ہے۔

کیونکہ مادی حالت میں اس کا استعمال انتہائی خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے۔

اس سے ہائی بلڈ پریشر، اور نبض و دل کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے۔

شوگر

- (1) آر سینکیم بروم: ذیابیطس جس میں حرکت کا فقدان ہو۔ رسولیاں جن کا تعلق غدودوں سے ہو، بے حس اور نوبتی نکالیف۔ اس دوا سے ہی ٹھیک ہوا کرتی ہیں۔
طاقت: ہدرنچر کے 5 سے 7 قطرے دن میں تین مرتبہ ایک گلاس پانی میں ملا کر۔
- (2) گلوکا: ذیابیطس دھڑکن کی تیزی، دم کشی، بے چینی اور بے خوابی وغیرہ کے لئے بہت مفید ہے۔ بخلی تنفس، بخلی دم، سانس پھولنا، گفتگو سے نکالیف کا بڑھنا، بے خوابی ذہنی و جسمانی تھکن کے لئے بے حد مفید دوا ہے۔
طاقت: ہدرنچر سے 3 طاقت تک۔
- (3) کونیٹیم: ذیابیطس کے ساتھ بازوؤں اور ٹانگوں کے پٹھوں کی غیر ارادی پھڑکن۔ پوٹوں کی غیر ارادی حرکات، پورے بدن کا ہلکا ہوا۔ تو یہ دوا مفید ہوا کرتی ہے۔
طاقت: تین طاقت
- (4) ہیلی بورس: ذیابیطس کی وجہ سے دیکھنے، سننے، چکھنے کی حسیں خراب ہو جاتی ہیں۔
دل کا بیٹھتا جانا، جواب بہت آہستگی سے دینا، پیشانی پر جھریاں پڑ جانا، سسکیاں اور آہیں بھرنا خاص علامات میں سے ہیں۔
- (5) سیزری جینیم: یہ دوا خون میں شکر کی مقدار کو کم کرتی ہے۔ زبردست پیاس، کمزوری، لاغری اور ذیابیطس کے رخصوں کے لئے بے حد مفید دوا ہے۔
طاقت: ہدرنچر
- (6) یورینیم نائیٹرکیم: ذیابیطس پیشاب میں زیادتی، سوزش گردہ، جگر کی خرابی ہائی بلڈ پریشر، زبردست کمزوری اور استقامتی کیفیت کو دور کرتی ہے۔
طاقت: 3 سے 6۔

ہائی بلڈ پریشر

(1) پیلا ڈونا: اجتماع خون سر کی جانب چہرہ اور آنکھیں سرخ۔ سر میں تپکن والے درد جن میں سر جھکانے اور ٹھوکر لگنے سے زیادتی ہو جائے اور سر کو اونچا رکھنے سے سردی میں کمی واقع ہوتی ہے۔
بلڈ پریشر کی زیادتی کے باعث مریض بہت زیادہ پر جوش ہو، ہڈیاں ہواور خیالی چیزیں نظر آتی ہوں۔ تو پیلا ڈونا ہی دوا ہوتی ہے۔

(2) بیرٹا میور: ہائی بلڈ پریشر کے باعث دل و دماغ کے عوارض۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد تکلیف بڑھ جاتی ہے، شریانوں کے اندر گومڑوں کی موجودگی کے باعث بلڈ پریشر کی زیادتی۔ پیچھے پھروں کی شریانوں میں سختی کے باعث دمہ اور شریانوں کے تناؤ کو یہ دوا کم کرتی ہے۔
طاقت: 3 طاقت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔

(3) گلوٹا سن: اجتماع خون سر کی جانب ہائی بلڈ پریشر کے باعث سردی، لو لگنے کے بد اثرات جن کے باعث بلڈ پریشر بڑھ کر سرد ہو۔ سر میں جھٹکے آتے ہوں۔ نبض کی چال کے ساتھ جھٹکا آئے۔ سرگی کا اندیشہ اور دماغ کے پردوں کی سوزش۔ اسی دوا کو طلب کرتی ہے۔

(4) اورم میور یا ٹیکم نیٹر وٹیم: ہائی بلڈ پریشر جس کا باعث اعصابی خرابیاں ہوں۔ خون کی نالیوں کی سختی، گردوں کی سوزش جو ہائی بلڈ پریشر کے نتیجہ میں تو یہ دوا مفید ہوا کرتی ہے۔
طاقت: 2 اور 3 طاقت۔

(5) و سکم الیم: یہ دوا ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ بہرہ پن، چہرہ کے پٹھوں کی مسلسل پھڑکن اور چکروں کو درست کرتی ہے۔

تشفی کھانسی، تنگی تنفس، ہائیم جانب لیٹنے سے دم گھٹے جس کا باعث بلڈ فشار خون ہو تو یہ دوا مفید ہوتی ہے۔

طاقت: اندر ٹکچر اور چھوٹی طاقتیں۔

(6) بیلنس پریٹس: یہ دوا خاص کر اس وقت نہایت کارگر ثابت ہوتی ہے۔ جب ہائی بلڈ پریشر کی وجہ بیرونی عوامل ہوں۔

نوٹ: ایک اندر ٹکچر سے 3 طاقت۔

اوپر بیان کردہ ادویات کے علاوہ درج ذیل ادویات بھی اپنی اپنی علامات کے تحت ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہوتی ہے جب انہیں علاج بالمثل کے اصول کے مطابق منتخب کیا جائے۔
ایسپرین، لیکس، لائیو پوس، جلیسی میم، ناساوا وغیرہ

ایتھر و سیکلر و سس (Atherosclerosis)

خون کی نالیوں میں چربی اور کولیسٹرول کے جماؤ سے آنے والی تنگی اور سختی۔

بریشامیور یا ٹکا

شریانی سختی اور تنگی، شریانی گومڑا، پیچھے پڑنے والی شریانوں کی سختی کے لئے انتہائی معتبر دوا ہے۔
خوراک: تیسری طاقت۔

گلوٹائین

خون کی نالیاں سکڑ گئی ہوں اور خون کے دورہ میں اچانک بے قاعدگی آجائے۔ دل اور سر کی جانب دوران خون کی تیزی دھڑکن اور تنگی تنفس، ذرا سی محنت سے دوران خون دل کی جانب بڑھ جائے۔ پورے جسم حتیٰ کہ انگلیوں کے پوروں میں ٹپکن محسوس ہوتا گلوٹائین بہترین دوا ہوتی ہے۔
طاقت: تین اور اونچی۔

اورم میور یا ٹیکم نیٹر و نیٹم

خون کی نالیوں کی تنگی اور سختی کیلاجواب دوا ہے جب دیگر علامات بھی ساتھ موجود ہوں۔
طاقت: 2 اور 3 طاقت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اونچی طاقتوں میں بھی استعمال ہوتی ہے۔

وسکم البم

یہ دوا خون کی نالیوں کی تنگی اور سختی کو دور کرتی ہے، ساتھ ہائی بلڈ پریشر تنگی تنفس، دم گھٹنے اور تشنگی کھانسی کو بھی دور کرتی ہے۔

طاقت: مدرنچر اور چھوٹی طاقت 3

لیکس

خون کی نالیوں کی تنگی اور سختی کے باعث خون کا دورہ پورے بدن میں مطلوبہ مقدار میں نہیں

ہوتا۔ اور نہ ہی پورے جسم کی بافتوں کو مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پہنچتی ہے۔ مریض کو تنگی تنفس ہوتی ہے۔ گلے کے گرد کپڑے برداشت نہیں کر سکتا، منہ ڈھانپ نہیں سکتا۔ دم گھٹتا ہے اور بے قراری ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن بے قاعدہ ہو جاتی ہے اور چہرہ اور ہونٹ نیلے ہو جاتے ہیں لیکن شدید نوعیت کے مریضوں میں پورے جسم پر نیلا پن ظاہر ہو جاتا ہے۔ اندرونی جریان خون بھی ہوتا ہے۔

ان تمام علامات کے ساتھ خون کی شریانوں کی تنگی اور تنگی کی بہت بڑی دوا ہے۔

طاقت: 200 اور اونچی طاقتیں مگر ایک دفعہ ایک خوراک دے کر اثر ہونے کا انتظار کیا

جائے اور پلاسیبو کا استعمال جاری رکھا جائے۔

ٹوبیکیم

خون کی شریانوں اور وریدوں کی تنگی اور تنگی میں استعمال ہونے والی دوا ہے۔

جب تمباکو نوشی کے اثرات بد کے باعث شریانوں میں Atherosclerosis کا عمل

شروع ہو گیا ہو تو یہ دوا بہت مفید ہوا کرتی ہے۔

طاقت: 3 سے تین طاقت۔

آورم مٹیلیم

خون کی نالیوں کی تنگی اور تنگی Atherosclerosis جس میں مریض اپنی زندگی سے مایوس

ہو۔ خودکشی کا میلان شریانی نظام میں تنگی واقع ہو گئی ہو، بلند فشار خون، موت کا خوف معمولی اختلاف

پر جوش میں آجائے، اپنا کام پھرتی سے نہ کر سکے۔ ایسے محسوس ہو جیسے دل چند سیکنڈ کے لئے بند ہو گیا

ہے اور پھر زور سے دھڑکن ہوتی ہو۔ نبض کمزور، تیز اور بے قاعدہ اسی دوا کو طلب کرتی ہے۔

طاقت: 30 اور اونچی طاقتیں۔

ٹوٹل ہائی بلڈ کولیسٹرول

کا

ہومیو پیتھک علاج

اپنی پریکٹس سے چند نمایاں ٹوٹل ہائی بلڈ کولیسٹرول
کے کیس اور ان کا علاج پیش خدمت کر رہا ہوں

کیس نمبر 1

ہائی بلڈ کولیسٹرول والی مریضہ کو لایا گیا اس کا بلڈ پریشر کافی بڑھا ہوا تھا اور ارد گرد کی اشیاء اپنے اصل سائز سے کم دکھائی دے رہی تھیں، جس کا مریضہ نے بتایا کہ اسے چیزوں کا اصل حجم دکھائی دینے کی بجائے چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں۔ مریضہ کسی بھی شخص کو قتل کرنے کی خواہش رکھتی تھی۔

بے حد مغرور، متکبر اور خود کو اعلیٰ و ارفع سمجھتی تھی جب کہ دوسروں کو بہت حقیر سمجھتی تھی۔ فالج کی طرف میلان تھا اور مقامی طور پر بے حسی اور ٹھنڈک محسوس ہوتی تھی۔ انتہائی ذکی الحس اور ہسٹیریا کی کیفیت بھی موجود تھی۔

اس کی ان تمام علامات کو میں نے لکھ لیا اور کافی سوچ و پچار کے بعد اسے پلاٹینا 200 طاقت کی دوا دی اور مکمل طور پر یہ ہیز می غذا کی ہدایات دیں۔

سہزیوں اور پھلوں کا استعمال بڑھانے اور چربی والی اور مرغن غذاؤں کو ترک کرنے کی ہدایات بھی کیں۔

ایک ہفتہ بعد دوبارہ جب آئی تو اس کا بلڈ پریشر کافی نارمل تھا اور ہشاش بشاش معلوم ہو رہی تھی۔ پھر 200 پلاٹینا کی ایک خوراک اور باقی پلاسیو دی گئی۔

200 سے 1M اور 10M تک پہنچتے تقریباً تین ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اب مریضہ کا مکمل ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول کا معائنہ کروایا گیا تو خون کے لیبارٹری معائنہ سے پتہ چلا کہ اس کا ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول لیول 185 ملی گرام ہے۔

اور باقی تمام علامات بھی جاتی رہی تھیں۔

کیس نمبر 2

ایک 35 سالہ مریض جس کی خون کے معائنہ کی رپورٹ کے مطابق اس کا ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول 360 ملی گرام سے بھی زیادہ تھا۔

ہائی بلڈ پریشر کے دورہ کے وقت لایا گیا۔ مریض کا بلڈ پریشر چیک کیا تو 160/120 تھا۔ مریض بے چین و مضطرب تھا مگر باتیں کئے جارہا تھا میں نے مکمل ہسٹری جاننے کے لئے اس سے کافی گفتگو کی۔ وہ دوسرے لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہ کرتا تھا۔ انتہائی خشکی مزاج اور غمگین تھا اور آرام کی موت چاہتا تھا۔

اس کی پینائی کافی کمزور ہو چکی تھی اور اسے مختلف اشیاء کا عکس درست نہیں دکھائی دیتا ہے۔ جنسی اعضاء میں زبردست تحریک تھی، لیکن سے دم گھٹتا تھا۔ گلے میں گھٹن اور گلے کے گرد کوئی چیز برداشت نہ کر سکتا تھا سردی کافی تھی مگر وہ منہ ڈھانپنے سے گریزاں تھا کیونکہ اس کا سانس رکھتا تھا، نیند میں دم گھٹتا تھا۔ چھو ا جانا برداشت نہ کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ دھڑکن اور غشی کے دورے پڑتے ہیں۔

سرور کسی شدت میں نیند آ جاتی مگر جاگنے پر ویسے کا ویسے رہتا۔

ہڈیائی کیفیت، لرزہ، ذہنی افسردگی حسد اور کیڑے کوٹ کوٹ کر بھر ا ہوا تھا۔

تمام علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے لیکسس 200 کی ایک خوراک دی گئی اور پندرہ دن کی پلاسبو۔ پندرہ دن بعد کافی حد تک ذہنی اور جسمانی کیفیت میں تبدیلی واقع ہوئی پھر 1M کی پینٹے بعد دو خوراکیں اور 10M تک پہنچتے ہوئے تقریباً ساڑھے چار ماہ کا عرصہ لگا۔

ساتھ ساتھ ہلکی نوعیت کی ورزش، اور تمام چربی والی اور مرغن غذاؤں کی جگہ سبزیوں اور پھلوں کا بھرپور استعمال کیا گیا۔

پھر خون کا لیبارٹری معائنہ کروایا گیا تو ٹوٹل بلڈ کولیسترول لیول 190 ملی گرام تھا۔

کیس نمبر 3

45 سالہ آدمی جس کا بلڈ کولیسترول نوٹل 300 ملی گرام تھا ساتھ درج ذیل علامات تھیں۔ ہائی بلڈ پریشر، گردے کی خرابیاں اور پیشاب میں سرخ ریت آتی تھی۔ پٹھے ناکارہ ہو گئے محسوس ہوتے تھے۔

مریض دبلا پتلا اور چہرہ پر جھریاں لیٹے ہوئے اپنی عمر سے بڑا معلوم ہوتا تھا۔ معمولی معمولی بات پر بگڑتا، انتہائی ڈکی الحس، خود اعتمادی کی کمی، شکی مزاج، حافظہ کمزور، سوچ منتشر تھی۔ رونی سے نفرت اور میٹھی اشیاء کی زبردست خواہش رکھتا تھا غذا اتنی گرم کھا جاتا تھا کہ دیکھنے والے حیران رہتے۔ شہوت نہ آتی تھی اور غدہ دندی بڑھ گئے تھے۔ دن کے وقت غنودگی میں رہتا اور نیند میں چونکتا، حادثات کے خواب دیکھ کر اٹھ پڑتا۔

دل کی بے حد بڑھی ہوئی دھڑکن کے باعث بائیں جانب ایٹنا محال تھا۔

مانچو لیا طبیعت اور اکیلے رہنے سے خوفزدہ ہو جاتا تھا۔

اور ذہنی ابتری کا یہ عالم تھا کہ اپنا لکھا ہوا پڑھ نہ سکتا تھا۔

سنا جائے تاکہ دوبارہ ہونے کے ممکن ہو جاتا۔

مریض کے متعلق سوچ کر مضطرب و بے چین رہنا اور اسی وجہ سے متکبر اور مغرور ہو گیا تھا۔ اس کی تمام ہسٹری لکھنے کے بعد جب میں تسلی سے بیٹھ گیا تو اس کے لواحقین جو ساتھ انہوں نے مریض کے متعلق پوچھا کہ یہ کون سا مرض ہے میں نے کہا بلڈ کولیسٹرول لیول میں زیادتی کیرپورٹ آپ خود تو لائے ہیں۔

انہوں نے کہا پھر بھی آپ کی سمجھ میں کیا مرض ہو سکتا ہے۔ تو میں نے بڑی ملائمت سے کہا لائیکوپوڈیم۔

کیونکہ اس کی بلڈ رپورٹ بشمول دیگر علامات جو میں نے لکھ لیں تھیں لائیکوپوڈیم سے ملتی تھیں۔

لائیکوپوڈیم کی 200 کی تین خوراکیں ایک دن چھوڑ کر دوسرے دی گئیں پھر IM اور جب IM نے کام چھوڑ دیا تو 10M تک جا کر تقریباً 4 ماہ کی مدت میں ادویاتی علاج کے ساتھ ساتھ مکمل طور پر غذائی علاج اور پریہیز دونوں کو شامل رکھا گیا۔ تب مریض شفا سے ہمکنار ہوا۔

کیس نمبر 4

ایک ذہیلے ڈھالے جسم کا مرد جس کی عمر تقریباً 50 سال کے قریب تھی، سردرد بانی بلڈ پریشر کے ساتھ آیا۔

اس کے بتانے پر پتہ چلا کہ کافی عرصہ سے وہ خون کا معائنہ کرواتا رہتا ہے اور نوٹس بلڈ کولیسٹرول لیول نارمل سے کافی بڑھا رہا ہے۔

چند دنوں تک دوائی وغیرہ کھانے سے جب دوران خون کی تیزی میں تھوڑا آفاقہ ہوتا ہے دواڑ چھوڑ دیتا ہے۔ اب تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔

مریض کی ہڈیاں ٹیڑھی ہو چکی تھیں اور پیٹ پر کافی چربی چڑھی ہوئی تھی۔ میرے سوال پر کہ معدہ کا کیا حال ہے مریض نے بتایا پہلے تو بہت سیٹ تھا میں چاک، کوئلہ اور پنسل کا سکہ تک کھا جاتا تھا۔ لیکن اب دودھ ہضم نہیں ہوتا۔ ترش ڈکار آتے ہیں۔ زیادہ کام کرنے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے کیچہ جلتا ہے اور زرد آوازوں کے ساتھ ڈکار آتے ہیں۔

مزید یہ کہ مجھے ڈر لگا رہتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی چھوت دار مرض آگھیرے گا۔ معمولی کام

کاج سے سانس پھول جاتا ہے۔ اس لئے میں کام نہیں کرتا۔

رات کو اور کھانے کے بعد دل کی دھڑکن تیز اور ساتھ سردی کا احساس ہوتا ہے۔

ساتھ ہی ساتھ بے قراری اور سینے میں گھٹن ہوتی ہے۔ خیالات کی بھرمار کی وجہ سے میں سو نہیں سکتا اور آنکھ کھلنے پر ڈراؤنی چیزیں نظر آتی ہیں۔ مجھے ڈر لگتا رہتا ہے کہیں میں پاگل نہ ہو جاؤں۔ اگر نیند آجائے تو مردوں کے خواب آتے ہیں۔

چھاتی اور کمر میں موج آجانے جیسے درد ہوتے ہیں۔ سردی بہت ہی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔

میں نے تمام ہسٹری لکھنے کے بعد کلکیر یا کارب IM اور ایک ہفتہ کی پلاسبودی، ساتھ مکمل غذائی پریسز اور ہسٹریوں اور پھلوں کی استعمال کی تاکید لی پھر دیا۔ ہفتہ بعد مریض جب دوبارہ آیا بلڈ پریشر میں کافی کمی تھی میں نے دوبارہ IM کی دو خوراکیں اور پلاسبودی اس طرح یہ کیس 5 ماہ 20 دن چلا اور میں CM کلکیر یا کارب تک پہنچا اور کیس ٹھیک ہو گیا۔

خون کے معائنہ سے ٹوٹل بلڈ کولیسترول لیول نارمل تھا۔ اور باقی ماندہ علامات بھی ختم ہو چکی تھیں۔

کیس نمبر 5

ہائی بلڈ پریشر اور ٹوٹل بلڈ کولیسترول کی زیادتی والا مریض جس کی عمر تقریباً 52 سال تھی۔ ساتھ درج ذیل علامات بھی موجود تھیں۔

مریض خوفزدہ پریشان تھا۔ سمجھتا تھا کہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔
غشی لرزہ اور مایوسی کیفیت میں گھرا ہوا تھا۔

خود کو ہائی بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ کولیسترول کے علاوہ کسی اور بڑی خطرناک مرض میں مبتلا سمجھتا تھا۔

مریض گھنٹوں گزر جانے پر بھی سمجھتا تھا ابھی بہت کم وقت گزرا ہے، شعور و ادراک کی غلطیاں اور ہر کام جلدی سے کرنا چاہتا تھا۔ خوف اور گھبراہٹ کے ساتھ فضول کاموں کے خیالات کی بھرمار۔ مریض کھڑکی سے کود کر خودکشی کرنے کی کئی بار کوشش کر چکا تھا۔

سو گھنٹے کی جس ختم ہو چکی تھی۔ چہرہ بے رونق، زرد اور 80 سالہ معلوم ہوتا تھا۔ گرمی کو جان لیا

خیال کرتا تھا۔

میٹھی اشیاء بہت زیادہ کھاتا، دھڑکن، نبض بے قاعدہ اور ایک نبض مس ہوتی تھی۔ دل درد رات کو بڑھ جاتا تھا اور دم کھٹتا تھا۔

بے خوابی اور اگر سو جاتا تو خواب میں سانپ نظر آتے۔ غنودگی اور مدہوشی جنسی خواہش کے خواب۔ میں نے تمام علامات مرض اور مرضیاتی حالتوں کو لکھنے کے بعد کافی سوچ و بچار کے بعد ارجنٹم نائٹرکیم کی جانب متوجہ ہوا تو یہ علامات تمام ارجنٹم نائٹرکیم سے ملتی تھیں۔

چنانچہ میں نے اس کو ارجنٹم نائٹرکیم 200 سے شروع کیا اور 6 ماہ بعد وہ مریض بالکل ٹھیک ہو گیا۔

اس کی بلڈ کولیسٹرول رپورٹ نارمل اور بلڈ پریشر نارمل ہونے کے ساتھ دیگر علامات مرض بھی جاتی رہیں۔

یاد رہے کہ اس مریض کو بھی مکمل طور پر چربی خنداؤں سے روک کر مہربیوں اور پھلوں کے استعمال پر لگایا گیا تھا۔

کیس نمبر 6

38 سالہ مریض جو مے نوشی کا دلدادہ تھا اور پریش زندگی گزارتا تھا۔ ایک دن دل کے درد کے ساتھ آیا۔ چیک اپ سے پتہ چلا کہ ہائی بلڈ پریشر ہے میں نے پوچھا کہ یہ حالت کب سے ہے۔ اس نے بتایا کافی دیر سے بلڈ پریشر بڑھا رہا ہے اور کبھی کبھی سینے میں درد بھی ہو جایا کرتا ہے۔

میں نے اس کا ای سی جی معائنہ اور لوٹل بلڈ کولیسٹرول چیک کروایا۔ تو پتہ چلا وہ ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول کا حامل ہے اور Atherosclerosis کے باعث خون کی نالیوں میں تنگی اور سخت پیدا ہو چکی ہے۔

میرے سوال و جواب پر اس نے درج ذیل علامات اور ہسٹری بتائی۔ کہ وہ ذاتی کاروبار کرتا ہے اور سکون حاصل کرنے کے لئے کثرت مے نوشی اور تہا کو نوشی بھی کرتا ہے۔ چائے بے حد و حساب پیتا ہے اور بازار کی مریخ غذاائیں زیادہ تر کھاتا پیتا ہے۔

پھر ان غذاؤں کے باضمرہ کے لئے مختلف نوعیت کی دوائیں اور گولیاں کھاتا رہتا ہے۔ اور حالت اب اس قدر بگڑ گئی ہے کہ طبیعت چڑچڑی، ذکی الحس اور غصیلی ہو گئی کہ میں معمولی باتوں پر طیش

میں آجاتا ہوں اور اپنے محسن اور بڑے لوگوں سے بھی بدتمیزی کر جاتا ہوں، بعد میں مجھے خیال آتا ہے کہ ایسا نہ کرنا چاہیے تھا، محرک اور چکنائی والی اشیاء زیادہ کھاتا ہوں۔ اور کبھی بھی ورزش کے نزدیک نہیں گیا۔ نہایت آرام طلبی کی زندگی بسر کر رہا تھا اب یہ تمام نکالیف آگئی ہیں۔

ساری درد کہانی سننے کے بعد میں نے ایک دن چھوڑ کر دوسرے روز نکلس و امیکا 200 کی تین خوراکیں ایک ہفتہ کے لئے دیں۔ ہفتہ بعد نکلس و امیکا دی گئی تقریباً 4 ماہ تک اس کا علاج چلتا رہا اور 10M نکلس و امیکا پر پہنچ کر علاج مکمل ہو گیا۔

خون کے معائنہ سے بلڈ کولیسٹرول لیول نارمل اور باقی دیگر علامات بھی جاتی رہی تھیں مگر ساتھ تمام غذائی پرہیز بھی کروائی گئی تھی۔

کیس نمبر 7

گلے کے نعرود بڑھے ہوئے۔ بدبودار رطوبت کا اخراج، تنگی تنفس، ذرا سی مشقت سے شرابور ہو جانے والے مریض کو دیکھنے کے لئے بلوایا گیا۔

مریض کا بلڈ پریشر چیک کیا تو بہت زیادہ تھا۔ گھر والوں نے بتایا کہ اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے اور خون کے معائنہ میں کولیسٹرول کی زیادتی بتائی جاتی ہے۔

مریض ناامید، اپنی صحت سے مایوس اور مایوس لیا کی کیفیت والا تھا۔ مریض میں خودکشی کا رجحان اور خاصہ ضدی محسوس ہوتا تھا۔ گھر والوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ

حالانکہ اب گرمی کا موسم ہے یہ پھر بھی نہانا پسند نہیں کرتا۔ اسے سردی محسوس ہوتی ہے، رات کو اٹھ کر کوئی نہ کوئی چیز کھاتا رہتا ہے۔

مزید مریض نے خود بتایا کہ اسے تنگی تنفس ہوتی ہے جس کو ٹیٹھنے سے زیادتی ہوتی ہے اور بازوؤں کو پھیلا کر لینے سے آرام ملتا ہے۔ سینے کی ہڈی کے نیچے زخم کا احساس ہوتا ہے۔

سردی کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں مولے کپڑے پہننے سے بھی سردی نہیں رکتی۔ مریض میں رد عمل کا بہت زیادہ فقدان تھا اور جلد جسم ٹھنڈی اور بدبودار پسینہ سے شرابور تھی۔ اور نہایت گندمی اور کھردری تھی۔ جلد چکنی اور سارے جسم پر پرت دار ابھار اور ناخنوں کے قریب چھالے تھے۔

مریض نے مزید بتایا کہ ذرا سی محنت کے بعد چھپا کی نمودار ہو جاتی ہے حالانکہ اکثر ہائی بلڈ

پریشر والے مریضوں کو سردی زیادہ نہیں لگتی۔ لیکن اسے تو گرمی میں بھی سردی لگ رہی تھی۔

تمام علامات کا جائزہ لینے کے بعد میں نے سوراٹینم 200 طاقت میں تجویز کی اور ایک ہفتہ کی پلاسیدو دے دی۔

ہفتہ وار سوراٹینم 200 طاقت سے ڈیڑھ ماہ تک کیس ٹھیک چلتا رہا پھر رک گیا۔

تو میں نے درمیان میں سلفر 1M کی ایک خوراک دے کر دوبارہ سوراٹینم شروع کر دی۔

1M سوراٹینم تک پہنچتے پہنچتے 2 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ اس کے بعد علامات دوبارہ لیں کیونکہ

شفائی عمل میں تعطل آ گیا تھا۔ دوبارہ کیس لینے پر کاربووتک کی علامات سامنے آئیں اور کاربووتک 30

طاقت سے شروع کی گئی تقریباً 5 ماہ سے زیادہ عرصہ کے بعد یہ مریض بالکل شفا پا گیا۔

لیبارٹری معائنہ خون سے ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول لیول نارمل کی رپورٹ ملی اور دیگر ذہنی وجہ سانی

علامات بھی جاتی رہی۔

کیس نمبر 8

ایک مریضہ جس کی عمر 35 سال تھی ہائی بلڈ پریشر ایٹھرو سکلوٹس

Atherosclerosis اور ذہنی امراض میں مبتلا تھی۔

ذہنی علامات کے باعث بہت سے ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کی گئی، لیبارٹری ٹیسٹ

خون کے معائنہ سے ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول لیول میں بہت زیادہ اضافہ اور خون کی انتہائی کمی بتائی گئی۔

بہت سے علاج معالجہ کے بعد بھی مریضہ کی حالت سنبھل نہ رہی تھی۔

جب میں نے علاج شروع کیا اس وقت مریضہ کو دل کی دھڑکن تیز اور سینے میں گھٹن تھی۔

بلڈ پریشر بڑھا ہوا تھا۔ ذرا سی حرکت سے دوران خون کی رفتار بڑھ جاتی تھی۔ نہ بچھنے والی پیاس اور

انتہائی گرمی محسوس ہوتی تھی۔

پورے جسم میں سکڑاو کا احساس اور زبردست کمزوری ولاغری موجود تھی۔

افسردگی اور غصہ بہت زیادہ تھا تسلی دینے پر مریضہ کی تکلیفیں بڑھ جاتی۔ مریضہ اکیلے رہنے کو

ترجیح دیتی تھی۔ اور لوگوں یا گھروالوں کے اکٹھا ہونے سے خوف کھاتی تھی۔

اس کی والدہ نے بتایا کہ تقریباً تین سال سے اس کی کیفیت ایسی ہی ہے۔

میرے سوال کرنے پر کہ مرض کے شروع میں کوئی خاص بات پیش آئی ہو اس کی والدہ نے

بتایا جب سے اس کے والد فوت ہوئے ہیں تب سے اس کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے۔

حالانکہ اس کے بچے اور میاں اس سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ والد کے انتقال کا صدمہ تھا کہ اس کے بعد اس کی صحت بحال ہوئے کو نہیں آئی۔

میں نے اس ہسٹری کی بنیادی بات یعنی بعد از غم یا صدمہ کے صحت کی خرابی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دیگر علامات کو پر بھی غور کیا تو میرا ذہن نیٹرم میور کی جانب سوچنے لگا۔

پس میں نے نیٹرم میور 200 کی ایک خوراک ہفتہ تک اس طرح جاری رکھی کہ ایک دن چھوڑ کر دوسرے روز خوراک دوہرائی جاتی، ساتھ دن میں چار مرتبہ پلاسبیدی گئی۔

پھر ہر ہفتہ 200 کی ایک خوراک چھ ہفتوں تک جاری رکھی جب 200 طاقت اپنا اثر دکھانے سے رک گئی تو ایک ہزار کی ایک خوراک ہفتہ بعد دی گئی، دوران علاج مریضہ کو گوشت، انڈے اور دیگر مرغی غذاؤں سے مکمل پرہیز کروائی گئی۔

تازہ کیٹی سبزیاں اور پھل کا بکثرت استعمال کروایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً ساڑھے تین ماہ کی مدت کے بعد مریضہ کا بلڈ پریشر نارمل ہو گیا اور بلڈ کولیسٹرول ٹوٹل لیول نارمل سطح پر آ گیا۔ دیگر تمام ذہنی اور جسمانی علامات بھی جاتی رہیں۔

نوٹ: نیٹرم میور کو جب پوٹنسی میں استعمال کیا جائے خصوصاً ہائی پوٹنسی میں تو کروڈ شکل کے خوردنی نمک سے پرہیز کروائی جائے۔

کیس نمبر 9

ایک مریض جس کی عمر 42 سال تھی۔ ہائی بلڈ پریشر اور ٹوٹل ہائی بلڈ کولیسٹروال کے ساتھ خون کی نالیوں میں تنگی اور سختی کافی حد تک واقع ہو گئی تھی۔ اس کی ان پتھالوجیکل تبدیلیوں کے باعث ساتھ درج ذیل علامات بھی موجود تھیں۔

مریض اپنی بیماری کا خود کو ہی قصور وار سمجھتا تھا۔ شدید ناامید، اپنی زندگی سے بیزار اور معمولی اختلاف پر جوش ہو جانے والا تھا۔ مریض کو موت کا خوف نمایاں تھا لیکن خود کشی کی باتیں کرتا اور کئی بار خود کشی کی کوشش کر چکا تھا۔

انتہائی زود حس، پست ہمت، بے جان اور کمزور حافظہ کا مالک تھا۔ ذہنی پستی و حزن ملال کی حالت،

دل کی دھڑکن بلند فشار خون اور دل کے عوارضات والی بہت سی علامات کے ساتھ جنسی خواہش بڑھی ہوئی۔

مریض نے بتایا کہ اسے ایسے محسوس ہوتا کہ دل چند سیکنڈ کے لئے بند ہو گیا ہے اور پھر زور سے دھڑکن ہوتی ہے اور ساتھ ہی سینہ میں کمزوری اور ٹھٹھن محسوس ہوتی ہے۔

نبض کا معائنہ کرنے سے میں نے نبض کمزور، تیز اور بے قاعدہ نوٹ کی۔ دل پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ رات کو سانس کی تنگی ہوتی ہے۔ مریض نے بتایا بار بار گہرا سانس لینا پڑتا۔ بے خوابی اور دوران نیند خوفناک اور ڈراؤنے خواب دیکھتا ہوں۔

میں ساری ہسٹری سن کر نوٹ کرنے کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ یہ اور میٹ کا مریض ہے۔ اور میٹ 30 طاقت سے اس کا علاج شروع کیا گیا۔ چند روز میں دونوں بعد ذہنی اور جسمانی علامات میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی اور تین کے بعد 200 اور پھر 1M طاقت تک ہی پہنچ کر مریض کی تمام علامات ٹھیک ہو گئی۔

کیس نمبر 10

55 سالہ مریض ہائی بلڈ پریشر اور ہائی ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول لیول کے ساتھ ساتھ دل کی دھڑکن تیز، دل کے آس پاس تکلیف محسوس کرتا تھا۔ جیسے دل چوڑا جا رہا ہو یا مروڑا جا رہا ہو۔ ناگوں کی کمزوری، ناکلیں بے حس، اعصاب کی سختی، لرزہ، پھڑکنیں اور جھٹکے بہت زیادہ تھے۔

مریض ناگوں میں کمزوری اور بے آرام کے باعث مسلسل ناگوں کو ہلاتے جا رہا تھا۔ غیر معمولی سکڑاؤ اور غیر معمولی حرکات دیکھنے میں آئیں۔

جنون شبوت، زبردست بے قراری، چالاک اور تخریبی ذہن کا تھا۔ ہسٹریائی مزاج، شدت شہوت۔

مزید پوچھنے پر اسکی بیوی نے بتایا کہ یہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے اخلاقی فقدان اور خود غرضی بہت نمایاں ہو گئی ہے۔ یہ اتنے احسان فراموش ہیں کہ اپنے بھائی جو ان سے چھوٹے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں اور مالی طور پر بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں کبھی بھی ان کا شکریہ ادا نہیں کیا بلکہ الٹا ان سے بد اخلاقی سے پیش آنا ان کا معمول بن گیا ہے۔

خود سر اور سرکش ہوتے جا رہے ہیں باتیں کئے جاتے ہیں اور موضوع بدلتے جاتے ہیں۔ میں نے مریض کا بغور مشاہدہ کیا تو اسے رعشہ تھا اور ٹانگوں کی اتنی بے قراری تھی کہ مسلسل انہیں ہلاتا جا رہا ہے۔

باتیں کرتے کرتے موضوع کو جلد از جلد تبدیل کر کے دوسرے موضوع پر گفتگو شروع کر دیتا۔

تمام علامات مرض ہائی بلڈ پریشر اور ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول لیول میں بے انتہائی بلندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ساتھ تمام دیگر ذہنی و جسمانی علامات کی موجودگی کے باعث میں نے ٹیرنٹولائیڈ کی اور ٹیرنٹول 6 سے مریض کا علاج شروع کیا پھر 30 طاقت اور 200 سے 1M تک کے استعمال سے مریض مکمل شفاء یاب ہو گیا۔

مریض کے لیبارٹری معائنہ خون کی رپورٹ کے مطابق مریض کا ٹوٹل بلڈ کولیسٹرول نارمل تھا۔ مریض کی ذہنی اور جسمانی علامات جاتی رہیں اور بلڈ پریشر نارمل حالت میں آ گیا۔ علاج کے دوران مکمل غذائی تبدیلیوں کو بروئے کار لایا گیا۔

پہلے سے بیان کردہ ان دس منتخب کیسوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہومیو پتی نہایت ہی مؤثر طریقہ علاج ہے۔ جو انتہائی کم وقت میں اچھے نتائج مہیا کرتا ہے مگر شرط یہ ہے کہ بالمشل اصول کو سامنے رکھتے ہوئے ادویات کو استعمال میں لایا جائے۔ اگر اس کے بالمشل قانون کو چھوڑ کر صرف از صرف مرض کے نام پر ہی دوا دی جائے تو کارگر ثابت نہ ہوگی۔

میں نے ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول، بلڈ پریشر کی زیادتی اور Atherosclerosis میں جن ادویات کو استعمال کیا، ساتھ ساتھ میں ان تمام یعنی ہائی بلڈ کولیسٹرول لیول، ہائی بلڈ پریشر، اور ایٹھرو سیکلروسس کی وجہ سے ساتھ پیدا ہونے والی اضافی ذہنی اور جسمانی علامات کو نظر انداز نہ کیا، بلکہ تمام چیتھا لو جیکل تبدیلیوں، جسمانی اور ذہنی علامات کو اکٹھا کر کے پھر دوا کو بالمشل اصول کے مطابق چنا گیا تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔

یہی بالمشل اصول کی صداقت ہے جو پریکٹیکل سامنے آتی ہے اور اپنے آپ کو منوالیتی ہے۔ ہر طریقہ علاج کی اپنی اپنی شناخت ہے مگر ہومیو پتی ان تمام دیگر طریقہ ہائے علاج ممتاز اور منفرد نظر آتی ہے۔ میں یہاں پر طب اسلامی کی افادیت سے انکار ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اس طب کے اپنے قوانین اور اصول ہیں۔ جن پر عمل پیرا ہو کر مریض کو شفاء، یابی سے ممکن کر کیا جاتا ہے۔

اسی طرح ایمر جنسی میں ایلیوٹیٹھی طریقہ علاج کی افادیت سے انکار کرنا بھی ناممکن ہے۔ لیکن الیکٹرانک میڈیا کی جانب داری افسر شاہی، بیوروکریسی اور ذاتی مفادات کے تحفظ کی خاطر صرف از صرف ایلیوٹیٹھی طریقہ علاج کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جا رہا ہے۔

حالانکہ طب اسلامی اور ہومیوپیٹھی اس طریقہ علاج سے کسی بھی طرح پیچھے نہیں۔ بلکہ ایمر جنسی کی حالت میں بھی طب اور ہومیوپیٹھی میں بہت بڑی بڑی ادویات موجود ہیں۔ بہر حال تمام طریقہ ہائے علاج کا مقصد وہی انسانیت کو مرضوں سے نجات دلانا ہی ہے۔ اور بلا تفریق رنگ و نسل تمام انسانوں کو ایسی جدید ترین سہولتوں سے مستفید کرنا ہے جن کی بدولت معاشرہ میں بیماری کم ہو اور تندرستی عام۔

ہائی بلڈ کولیسٹرول کیلئے درج ذیل ادویات بھی اپنی اپنی خاص علامات کے تحت کارگر ثابت ہوتی ہیں۔

1-	پلساٹیل	7-	تھوجا
2-	گریفٹائینس	8-	کیمومیل
3-	لائکوپس	9-	ناجا
4-	سلفر	10-	سپیا
5-	شانی سکیریا	11-	سکیل کار
6-	سلشیا		

ہائی بلڈ پریشر، ہائی بلڈ کولیسٹرول اور ایٹھروسکلروسیس کے باعث جسم انسانی پر ظاہر ہونے والی ذہنی و جسمانی علامات کے ہائٹل اور پر بیان کردہ ادویات میں سے جس کا بھی انتخاب ہو گا وہ مؤثر اور شاندار نتائج مہیا کرے گی۔ مگر یاد رہے کہ ادویاتی علاج کے ساتھ ساتھ غذائی پرہیز، یا مکمل غذائی تبدیلیوں، بلکی ورزش اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے بغیر شفا کا حصول مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہوتا ہے۔

ہائی بلڈ پریشر اور ہائی بلڈ کولیسٹرول اور ذہنی دباؤ کا طبی طریقہ علاج اسلامی طب میں بہت سی مفید ادویات جو ہائی بلڈ کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور ذہنی دباؤ کے

لئے استعمال کی جاسکتی ہیں موجود ہیں۔

لیکن اس جگہ پر نہایت ہی معتبر اور آزمودہ چند خاص الخاص ادویات کا ذکر کیا جائے گا۔

(1) ذہنی دباؤ یا سٹریس

(1) بالچھڑ

بالچھڑ کی خوراک 1 سے 2 ماشہ تک ہے، یہ ذہنی دباؤ کے باعث پیدا شدہ ریشہ، اور عصب اعصاب کے لئے نہایت مفید دوا ہے۔ اس کا استعمال مسکن، مقوی اعصاب اور دافع سٹریس ہوتا ہے۔

(2) سنائی

طب اسلامی کا اصول تھخہ جو ذہنی دباؤ کو کم کر کے دائمی سرور کو دور کرتی ہے۔ اور شدید اضطراب، ذہنی دباؤ کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ سے پیدا شدہ ذہنی کمزوری اور لیان کو بھی دور کرتی ہے۔

(3) حنا

بلند فشار خون کو نارمل کرتی ہے خاص کر جب دوران خون سر کی جانب ہو اور سر میں دھڑکنیں اور پھڑکنیں زوروں پر اور بلند پریش کی زیادتی کے باعث ذہنی سکون جاتا رہے۔ بے خوابی اور ہائی بلڈ پریشر سے پیدا شدہ تکسیر کو درست کرتی ہے۔

(4) روغن مغز کدو 2 روغن کا ہو (3) روغن گل + روغن خشخاش اور روغن بادام مغز تمام کو ملا کر سر پر مساج کرنے کی صورت میں ذہنی دباؤ stress دور ہوتا ہے۔
بے خوابی دور ہوتی ہے اور قدرتی نیند نصیب ہوتی ہے۔

(5) چھوٹی چندن یا اسرول

بے خوابی کو دور کرتی ہے، ہائی بلڈ پریشر کو دور کر کے خون کا دباؤ نارمل بناتی ہے۔ جس کے باعث ذہنی دباؤ سے بھی چھٹکارا چلتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کے باعث ذہنی دباؤ اور مایٹو لیا کی کیفیت جب مریش جنونی ہو۔ بھاگتا پھرے اور مارنے کے لئے دوڑے، شور و غل کرے تو مفید ہوتی ہے۔

مگر خاموش مایٹو لیا کی اور جنونی مریضوں میں زیادہ کام نہیں کرتی۔

رات کو سونے سے دو گھنٹے پہلے عرق گلاب کے ساتھ کپسول 500 ملی گرام والا کھلا دیں۔

صندل سفید

دل و دماغ کو قوت بخشتا ہے، دماغی بڑھتی ہوئی حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل کر کے دل کی تالیوں کو قوت فراہم کرتا ہے۔ مفرح اور مصفی خون بھی ہے۔
250 ملی گرام سے 500 ملی گرام خوراک

فالس

فالس کے درخت کا چھلکا بیج کر 6 ماشہ سے 12 ماشہ خوراک رات کو بھگول کر صبح رگڑ کر چھان کر پی لیا جائے۔
یہ ہائی بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر لاتا ہے، ذہن کو سکون فراہم کرتا ہے اور اختلاج قلب کے لئے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔

کشمینز

5 ماشہ سے 7 ماشہ خوراک وضیا ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے بلند فشار خون کو نارمل کرتا ہے اور جنون و وسوس دور کرتا ہے۔ یہ مفرح قلب ہے اور دل کو سکون بخشتا ہے۔ لیکن اس کا بہت زیادہ اور آگ تار استعمال جنسی فقدان پیدا کرتا ہے۔

جو کھار

بلند فشار خون کو نارمل سطح پر لاتا ہے اور پیشاب آکر ہائی بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر لاتا ہے۔ خون کی تالیوں کی تنگی اور سختی کو دور کرتا ہے۔

کشمش

5 سے 7 دانے رات کو عرق گلاب کے آدھا گلاس میں بھگو دیں۔ صبح ناشتہ سے پہلے کشمش کھالیں اور عرق پی لیا جائے۔

ہائی بلڈ پریشر کو نارمل بناتا ہے۔ ذہنی دباؤ کو سکون اور CHD دل کی بیماریوں سے محفوظ بناتا

فلفل سیاہ (کالی مرچ)

کالی مرچ خون میں کولیسٹرول لیول کی سطح کو بڑھنے سے روک کر خون کی شریانوں کی تنگی اور سختی کو روکتی ہے۔ اور خون کی شریانوں میں لوتھڑے نہیں بننے دیتی لیکن اس کا مسلسل استعمال ساتھ مکمل غذائی تبدیلیوں کے فائدہ مند ہوا کرتا ہے۔

اسبغول

خون کی حدت کو کم کر کے ذہنی و باؤ stress سے نجات دلاتا ہے۔ خون کے انجماد کو روکتا ہے اور زائد چربی کو جسم سے خارج کرتا ہے۔

اندرائن

2 چاول سے چار چاول

شریانوں سے زائد چربی کو خارج کرتا ہے۔ خون سے دیگر فاسد مادوں کو خارج کر کے کئی جلدی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔

عناّب

خون کے گاڑھے پن کو دور کرتا ہے۔ شریانوں کی تنگی اور سختی Atherosclerosis کے لئے بے حد مفید ہے۔

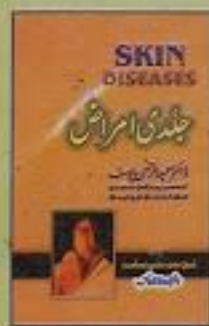
کولیسٹرول لیول کو نارمل رکھتا ہے اور جسم کو موٹاپے سے بچاتا ہے معضیٰ خون بھی ہے اور خون کی بہت سی امراض کے لئے بہت ہی موزوں ہے۔

ایلووا

آدھی سے ایک رقی خوراک۔

جسم خصوصاً شریانوں میں کولیسٹرول کو جھننے سے روکتا ہے۔ پورے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتا ہے اور پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا۔

معیاری کتب کے سلسلہ کی چند کتب



سیل پوائنٹ
شیخ محمد بشیر اینڈ سنز
 ناشران و تاجران کتب